(MEDCAL SERVICE OF TACTICAL OPERATIONS)

การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

ขอบเขตการบรรยาย

1. การบริการทางการแพทย์ ในค่ายพักและที่พักแรมในสนาม
2. การบริการทางการแพทย์ ในการรบด้วยวิธีรุก
3. การบริการทางการแพทย์ ในการรบด้วยวิธีตั้งรับ
4. การบริการทางการแพทย์ ในการร่นถอย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ มีความรู้ความเข้าใจการบริการทางการแพทย์ในค่ายพัก ที่พักแรมในสนาม
2. เพื่อให้ มีความรู้ความเข้าใจการบริการทางการแพทย์ในการรบด้วยวิธีรุก รับ ร่นถอย
3. เพื่อให้ สามารถอธิบายการบริการทางการแพทย์ ในค่ายพัก ที่พักแรม การรบด้วย วิธีรุก รับ และร่นถอยได้

การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

การให้การบริการทางการแพทย์ของ ทบ. ยามสงคราม

เขตสงคราม

เขตภายใน

5. การบริการทางการแพทย์ระดับเขตภายใน

รพ.ทบ. (นขต.พบ.)
- รพ.รร.6
- รพ.อ.ป.ร.
- รพ.ค่ายสุรนารี
- รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ทร.
- รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ทอ.
- รพ.องค์การทหารผ่านศึก
- รพ.พลเรือนที่กำหนด

เฉพาะทาง พักฟื้น อวัยวะเทียม

เขตยุทธบริเวณ

เขตหลัง

4. การบริการทางการแพทย์ระดับเขตหลัง

รพ.มทบ./รพ.พลเรือนในพื้นที่

เฉพาะทาง

เขตหน้า

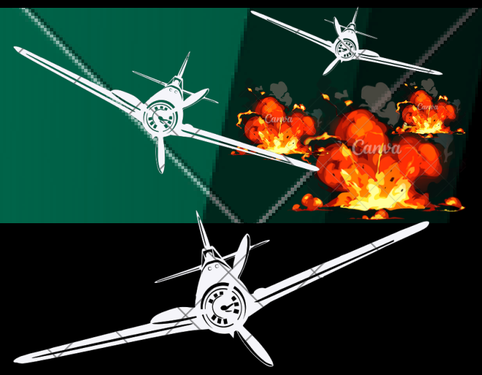
1. การบริการทางการแพทย์ระดับหน่วย
ขนาดหน่วยตั้งแต่ มว.สร. ลงมา
ฉุกเฉิน TCCC

2. การบริการทางการแพทย์ระดับกองพล
พัน.สร.พล ช่วยชีวิตขั้นแรก

3. การบริการทางการแพทย์ระดับกองทัพภาค
พัน.สร.บชร. รักษาช่วยชีวิต

การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

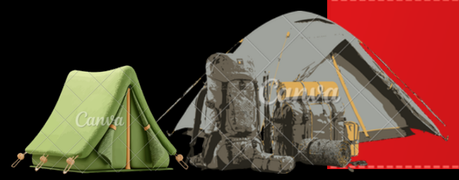
การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี



คำจำกัดความ

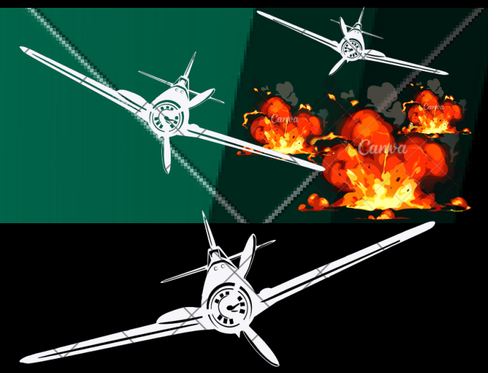
FORT ค่ายทหารยามปกติ

CAMP ค่ายทหารในสนาม
ที่พักชั่วคราว หรือที่พักกึ่งถาวร



BIVOUAC ที่พักแรมในสนามในระยะเวลาสั้นๆ คือ พื้นที่ที่เลือกไว้สำหรับ
เป็นที่พักของหน่วยทหาร และยังมิได้ประจันหน้ากับข้าศึก

การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี



การวางกำลังของหน่วยทหารในค่ายพัก

การวางกำลัง ต้องพิจารณาถึง

- การจัดให้มีความสะดวกในการบังคับบัญชางานธุรการ
- มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการฝึก
- สามารถปรับพื้นที่ให้เข้ากับความต้องการทางสุขาภิบาลได้

การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

การวางกำลังของหน่วยทหารในค่ายพัก

การจัดหาอาคารที่พักผู้ป่วยเจ็บ

- จัดให้มีบริการทางการแพทย์อย่างเพียงพอ
- อาคารที่พักมีสิ่งอำนวยความสะดวกตามสมควร
- อาคารที่อาจพิจารณานำมาเป็นที่พักผู้ป่วยเจ็บได้

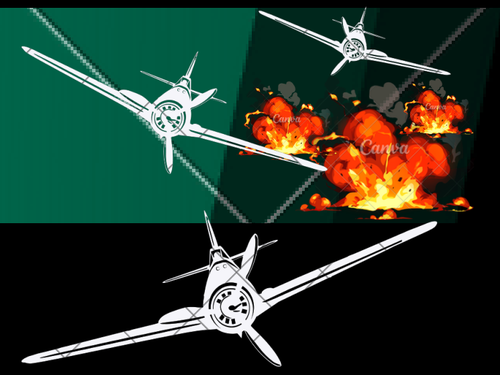
การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

การวางกำลังของหน่วยทหารในค่ายพัก

อาคารที่อาจพิจารณา นำมาเป็นที่พักผู้ป่วยเจ็บได้

- กระโจม(เต้นท์) — ไม่เหมาะกับผู้ป่วยเจ็บอาการหนัก
- คลังสินค้า — อาคารทางอุตสาหกรรม ขาดการระบายอากาศ
- บ้านส่วนบุคคล — การจัดการภายในไม่ดี บันไดแคบ
- อาคารห้องเช่า — ดี ถ้ามีลิฟต์และบันไดใหญ่พอ
- สถานที่ราชการ — ดี มีระเบียง บันไดกว้าง สิ่งอำนวยความสะดวก
- รพ.พลเรือน — ดีมาก ต้องคำนึงถึงพลเรือน ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
- ก่อสร้างใหม่ — ต้องคำนึงถึงห้วงเวลาที่ใช้งาน

การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี



การวางกำลังของหน่วยทหารในค่ายพัก

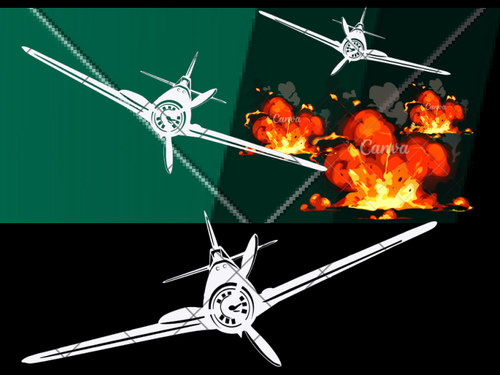
การสุขาภิบาล

- ยึดถือคำสั่ง ทบ.ที่ 168/2548 เรื่อง ชี้แจงการปฏิบัติการสุขาภิบาลในสนาม ลง 22 มี.ค. 48
- เจ้าหน้าที่แพทย์ในทุกระดับจะต้องประสานงาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

การฝึกอบรม

- ต้องมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่แพทย์อยู่เสมอ
  ทักษะการปฐมพยาบาล ห้ามเลือด พันแผล เข้าเฝือก ยก คย. ผป.เจ็บ
- กำลังพลของหน่วยรบ
  TCCC สุขศาสตร์ส่วนบุคคล การสุขาภิบาล

การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี



การปฏิบัติของหน่วยแพทย์

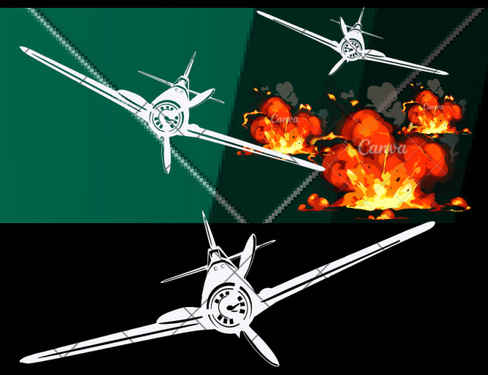
เมื่อออกไปจากที่ตั้งปกติ

- เวลามีผู้ป่วยเจ็บเกิดขึ้น หน่วยแพทย์จะต้องให้การดูแลรักษาพยาบาลได้ทันที
- โดยไม่คำนึง ว่าจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือไม่

ในที่ตั้งปกติ

- ให้การรักษาพยาบาลอย่างประณีตต้องใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างครบถ้วน

การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี



การปฏิบัติของหน่วยแพทย์

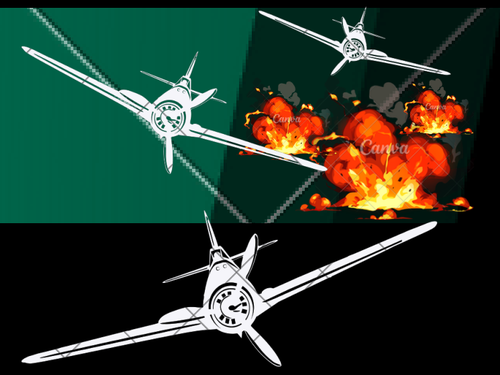
การบริการทางการแพทย์ในค่ายพัก

- มว.สร. เปิดที่ตรวจโรค ให้การรักษาตามความจำเป็น

- พัน.สร. เปิดที่ตรวจโรค ให้การรักษาพยาบาลตามความจำเป็น

- นขต.พัน.สร. ฝึกปฏิบัติงานใน รพ.มทบ.

การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี



การปฏิบัติของหน่วยแพทย์

การบริการทางการแพทย์ในค่ายพัก

- การวางกำลังของหน่วยทหารในค่ายพัก
- การบริการทางการแพทย์ทำได้อย่างจำกัด
- เปิดที่พยาบาลกองพัน หรือที่พยาบาลกองพล ตามความจำเป็น

ต้องมีความปลอดภัย รักษาความลับ เหมาะสมต่อการใช้กำลังในการปฏิบัติการในอนาคต

การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

การเคลื่อนย้ายหน่วยทหาร

* กระทำได้ทั้ง ทางพื้นดิน ทางน้ำ ทางอากาศ
* แต่ละหนทางเป็นไปตามสภาพของการขนส่ง วิธีการไม่เหมือนกัน
* นำกำลังทหารพร้อมยุทธสัมภาระจากตำบลหนึ่งไปยังตำบลหนึ่ง
* นำกำลังเพียงบางส่วนไปปฏิบัติ หรือทั้งหมดก็ได้
* ความสำเร็จ คือ การไปถึงจุดหมายปลายทาง ตามเวลา ทหารอยู่ในสภาพสดชื่น พร้อมปฏิบัติภารกิจ

การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

การเคลื่อนย้ายหน่วยทหาร

การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

การเคลื่อนย้ายหน่วยทหาร

* เคลื่อนย้ายหน่วยทหาร ยุทโธปกรณ์ตามภารกิจทางยุทธวิธี ในสภาพการรบ และในเมื่อยังมิได้ปะทะกับข้าศึก
* การเคลื่อนย้ายจะสิ้นสุดเมื่อมีการปะทะกับข้าศึก หรือ เคลื่อนย้ายถึงที่หมาย

ประเภทของการเคลื่อนย้าย

1. การเคลื่อนย้ายทางยุทธวิธี

2. การเคลื่อนย้ายทางธุรการ

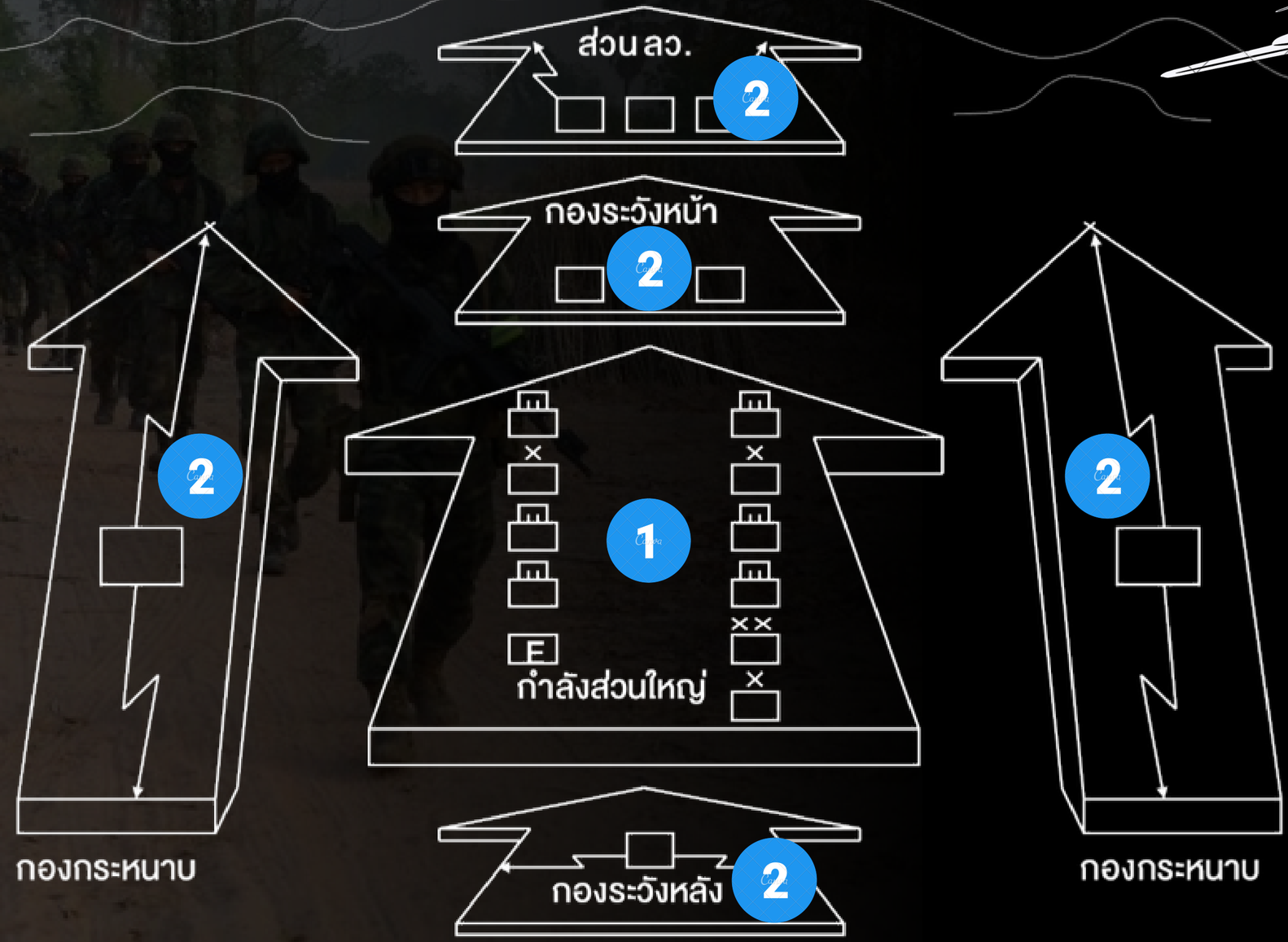
* การเคลื่อนย้ายเมื่อไม่มีการรบกวนจากข้าศึก
* การปะทะกับข้าศึกที่อาจเกิดขึ้นได้ ยังอยู่ห่างไกลมาก

การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

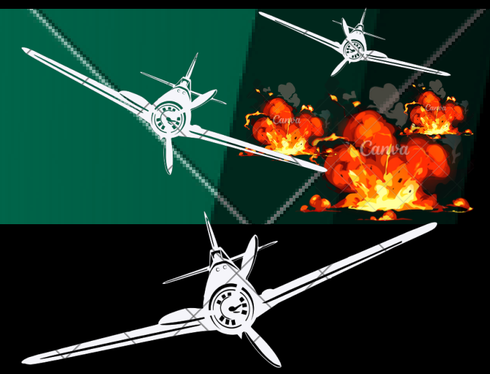
ขบวนการเดิน

1. กำลังส่วนใหญ่ (MAIN BODY)

2. ส่วนระวังป้องกัน (SECURETY FORCE)



การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี



- การปฏิบัติการทางทหาร
  - สงคราม
    - ตามแบบ
      - รุก
      - รับ
      - ร่นถอย
      - ภายใต้สภาพพิเศษ
    - ไม่ตามแบบ
      - เศรษฐกิจ
      - การเมือง
      - ศาสนา
      - อื่นๆ
      - สงครามพิเศษ
        - สนบ.
        - ปปส.
        - ปจว.
  - MOOTW

การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

การรบด้วยวิธีรุก

- เป็นวิธีเดียวในการบรรลุชัยชนะแตกหักของสงคราม
- เป็นวิธีสุดท้ายของ ผบ.ในการบังคับให้ข้าศึกปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของตน

การรบด้วยวิธีรุก

- พื้นฐานการรบด้วยวิธีรุก
  - การจู่โจม
  - รวมกำลัง
  - รวดเร็ว
  - อ่อนตัว
  - ห้าวหาญ
- วัตถุประสงค์หลัก
  - ทำลายกำลังรบ
  - ทำลายระบบการตั้งรับของข้าศึก
- วัตถุประสงค์รอง
  - ควบคุมภูมิประเทศสำคัญ
  - ลวงหันเหการปฏิบัติของข้าศึก
  - ตรึงกำลังข้าศึก
  - ให้ได้ข่าวสาร
  - ขัดขวางการเข้าตีของข้าศึก
  - ขัดขวางมิให้ข้าศึกใช้ทรัพยากรภูมิประเทศสำคัญยิ่ง
- แบบของการรบด้วยวิธีรุก
  - เคลื่อนที่เข้าปะทะ
  - ตีเร่งด่วน
  - ตีประณีต
  - ขยายผล
  - ไล่ติดตาม
- การดำเนินกลยุทธ์
  - การตีโอบ
  - การตีตลบ
  - การแทรกซึม
  - การตีเจาะ
  - การตีตรงหน้า

การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

การรบด้วยวิธีรุก

1.การเคลื่อนที่เข้าปะทะ

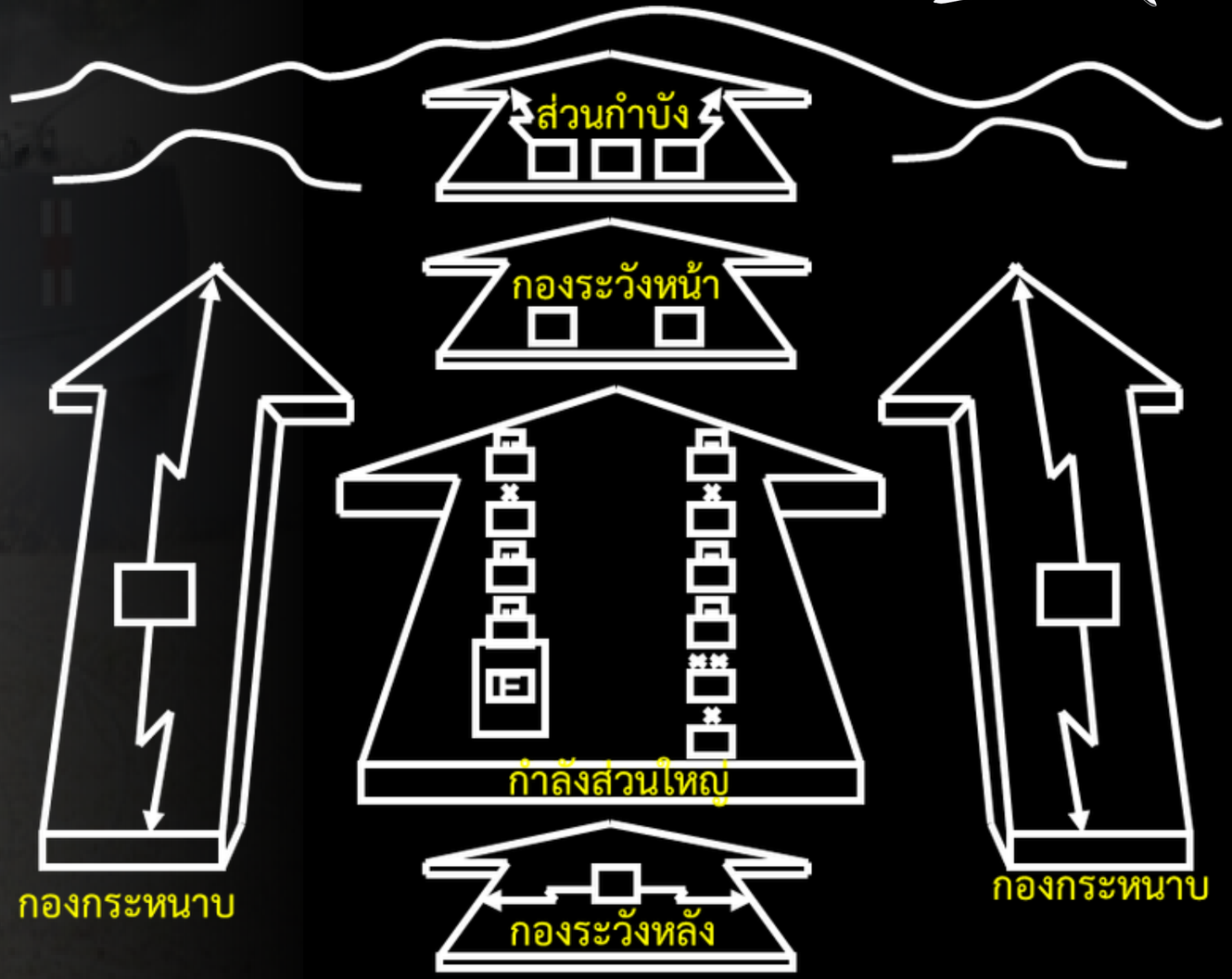
มีวัตถุประสงค์ :เพื่อคลี่คลาสถานการณ์

การปฏิบัติ

- รวดเร็ว ห้าวหาญ
- สิ้นเปลือง สป.3 สูง ความต้องการซ่อมบำรุงยานพาหนะเพิ่มขึ้น
- สิ้นเปลือง สป.5 น้อยลง

สิ้นสุดเมื่อ * เข้ายึดที่หมายโดยปราศจากการปะทะ หรือ เมื่อเกิดการปะทะโดยการรบปะทะ หรือ เข้าตีเร่งด่วน

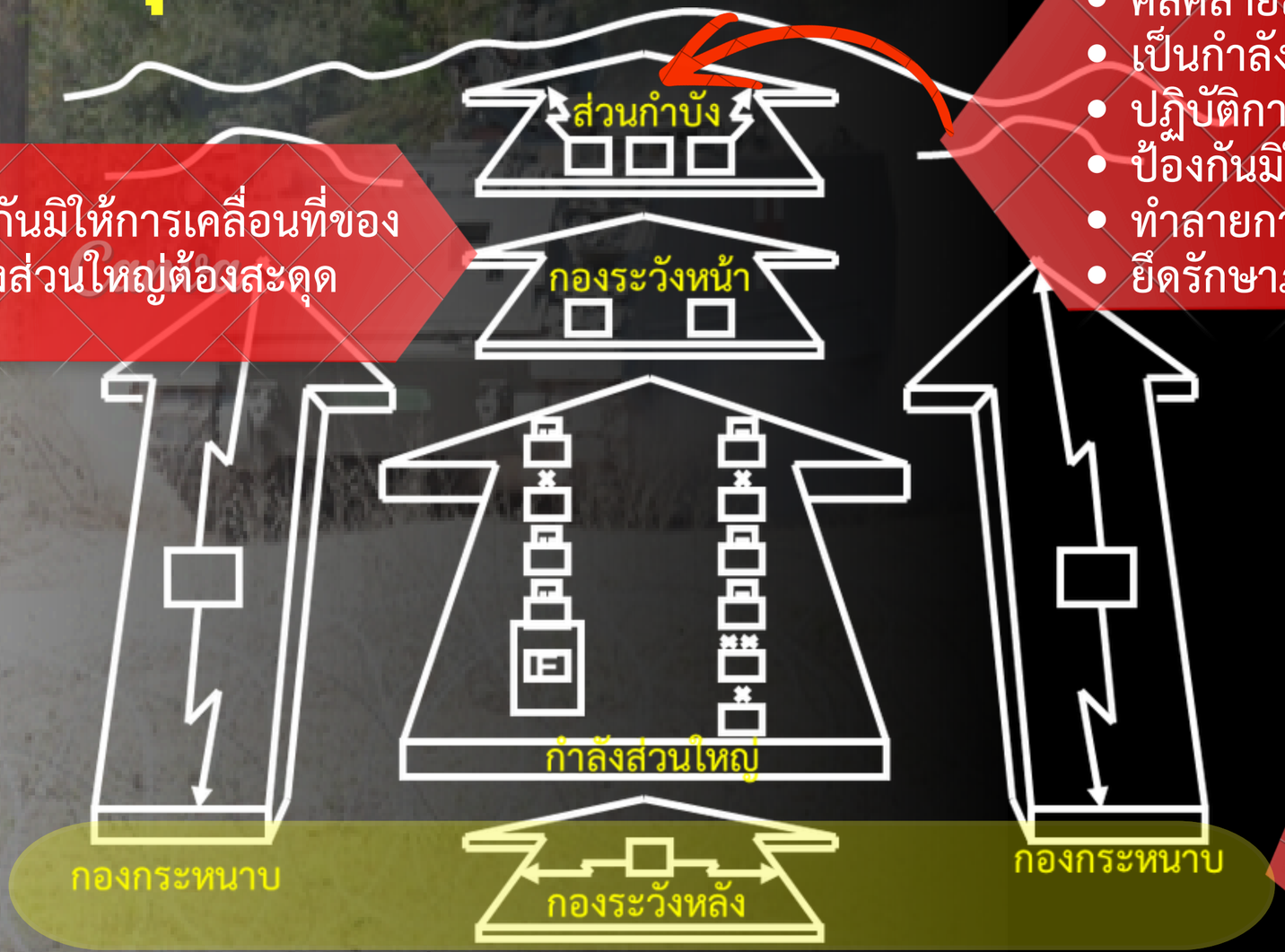
การจัดกำลัง ประกอบด้วย



การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

การรบด้วยวิธีรุก

1.การเคลื่อนที่เข้าปะทะ



- ป้องกันมิให้การเคลื่อนที่ของกำลังส่วนใหญ่ต้องสะดุด

- คลี่คลายสถานการณ์
- เป็นกำลังที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง
- ปฏิบัติการห่างจากกำลังส่วนใหญ่
- ป้องกันมิให้กำลังส่วนใหญ่ชักช้าโดยไม่จำเป็น
- ทำลายการต้านทานของข้าศึก
- ยึดรักษาภูมิประเทศสำคัญ

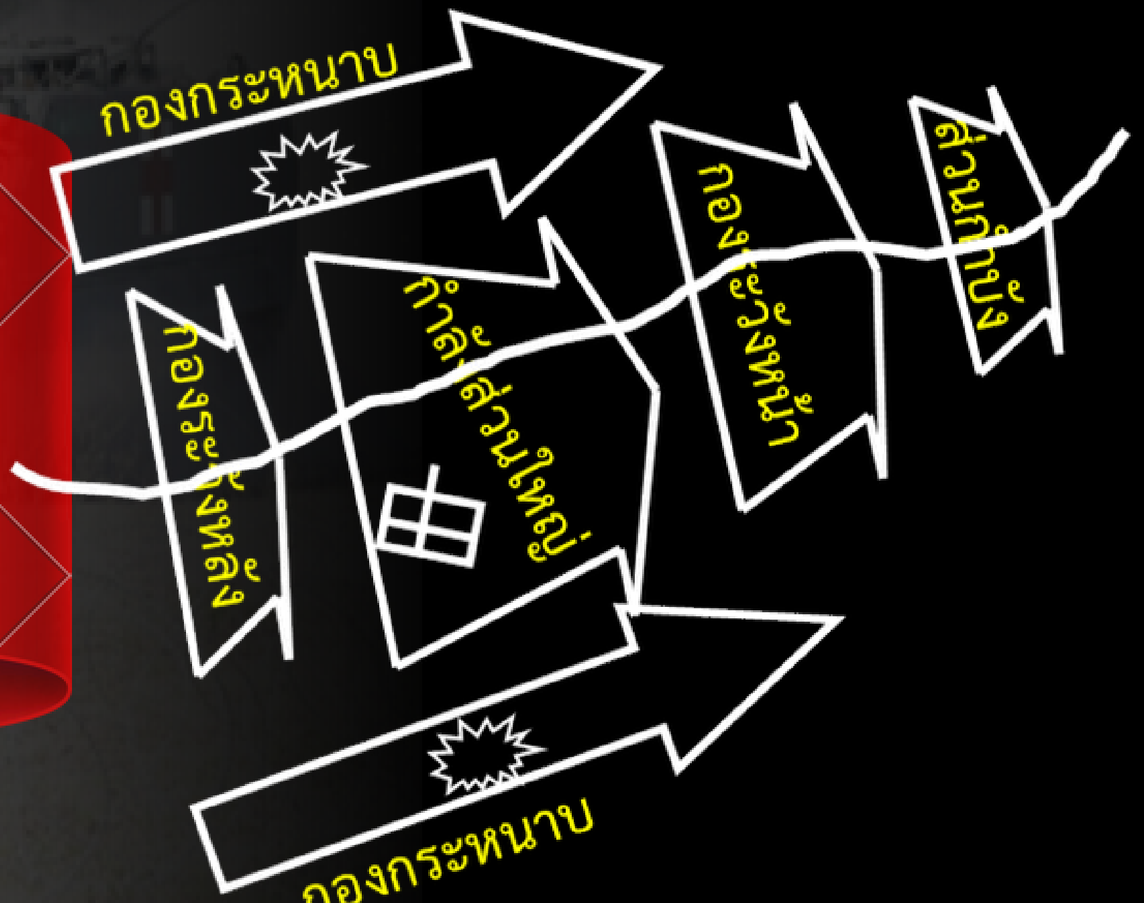
- ป้องกันกำลังส่วนใหญ่จากการตรวจการณ์ทางพื้นดิน การโจมตีอย่างจู่โจม

การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

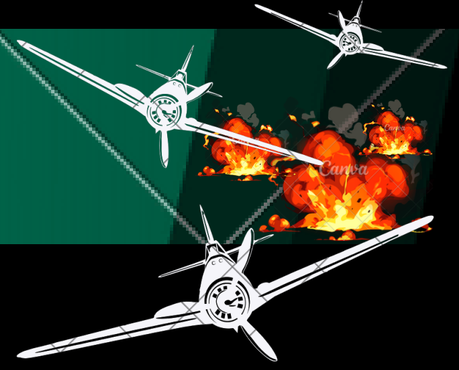
การรบด้วยวิธีรุก

การรบปะทะ

- ปฏิบัติต่อเนื่องจากการเคลื่อนที่เข้าปะทะ
- แต่ละฝ่ายยังไม่เตรียมการมากนัก
- ข่าวสารไม่กระจ่างชัด
- สิ้นสุดเมื่อคลี่คลายสถานการณ์ได้แล้ว
- เป็นจุดสำคัญในการตัดสินใจของ ผบ.พล ว่าจะเปลี่ยนการปฏิบัติไปสู่การเข้าตีหรือตั้งรับ



การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี



การรบด้วยวิธีรุก

2. การเข้าตี

การเข้าตี
มีอยู่ 2 ลักษณะ

1

การเข้าตีเร่งด่วน

- เป็นการปฏิบัติต่อจากการรบปะทะ
- ขศ.ยังไม่สามารถจัดระเบียบตั้งรับได้

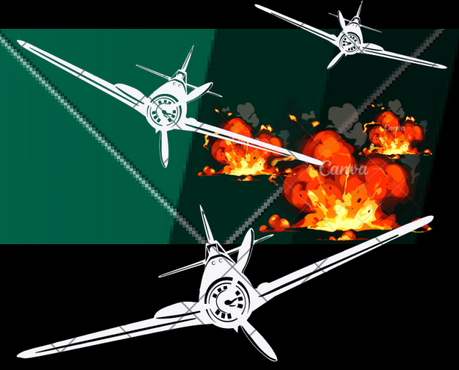
2

การเข้าตีประณีต

- ข้าศึกมีการจัดระเบียบตั้ง รับอย่างสมบูรณ์
- ฝ่ายเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรืออ้อมผ่านได้

- มีหลักในการปฏิบัติเช่นเดียวกัน
- แตกต่างกันในเรื่องของ
  * การเตรียมการ
  * การวางแผน
  * การประสานงาน

การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี



การรบด้วยวิธีรุก

2. การเข้าตี

ใช้ทั้ง 5 แบบหรือบางแบบ ผสมผสาน

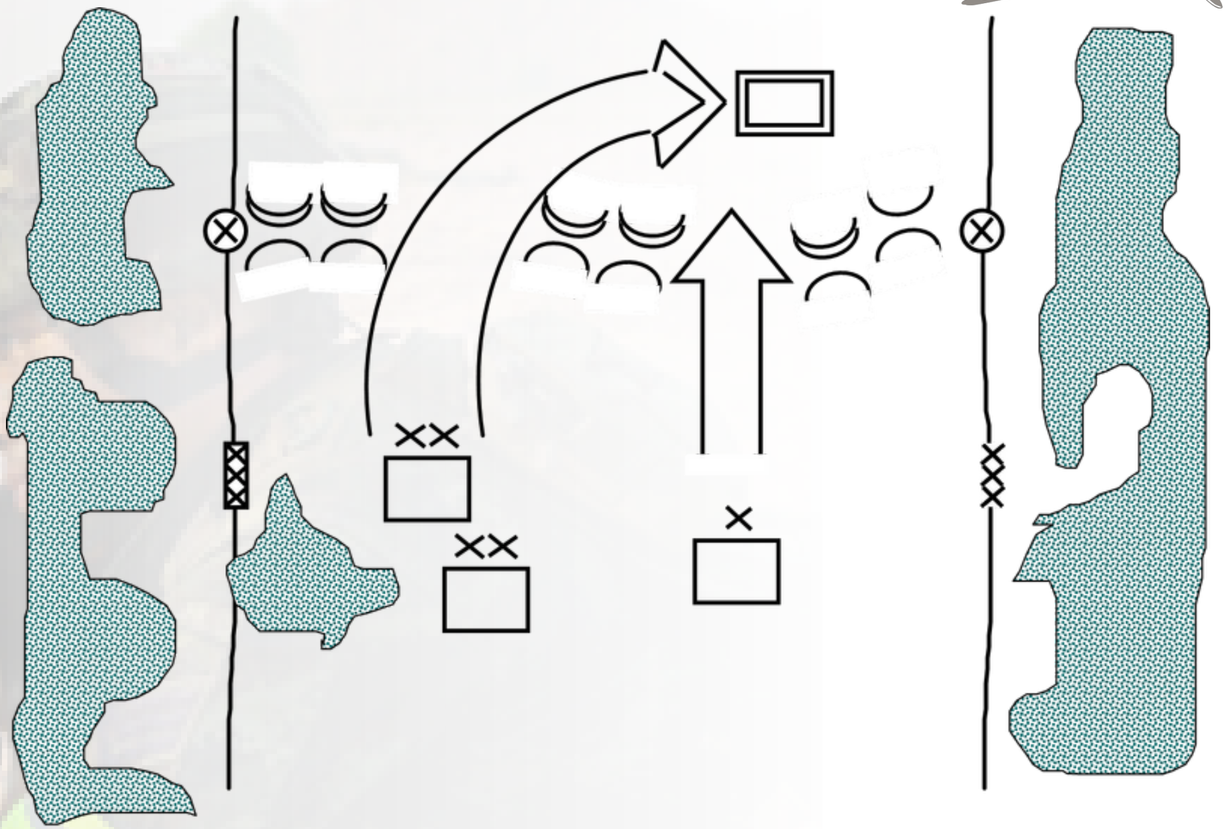
การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

การรบด้วยวิธีรุก

2. การเข้าตี

ใช้ทั้ง 5 แบบหรือบางแบบ ผสมผสาน

การตีโอบ



* เป็นพื้นฐานในทุกหลักนิยม
* ใช้ความแข็งแกร่งเข้าต่อสู้กับจุดอ่อน หลีกเลี่ยงข้าศึกที่อยู่ด้านหน้า
* เข้าตีหลักทางปีกหรือทางหลังข้าศึกด้วยการดำเนินกลยุทธอ้อมผ่านหรือข้ามผ่าน

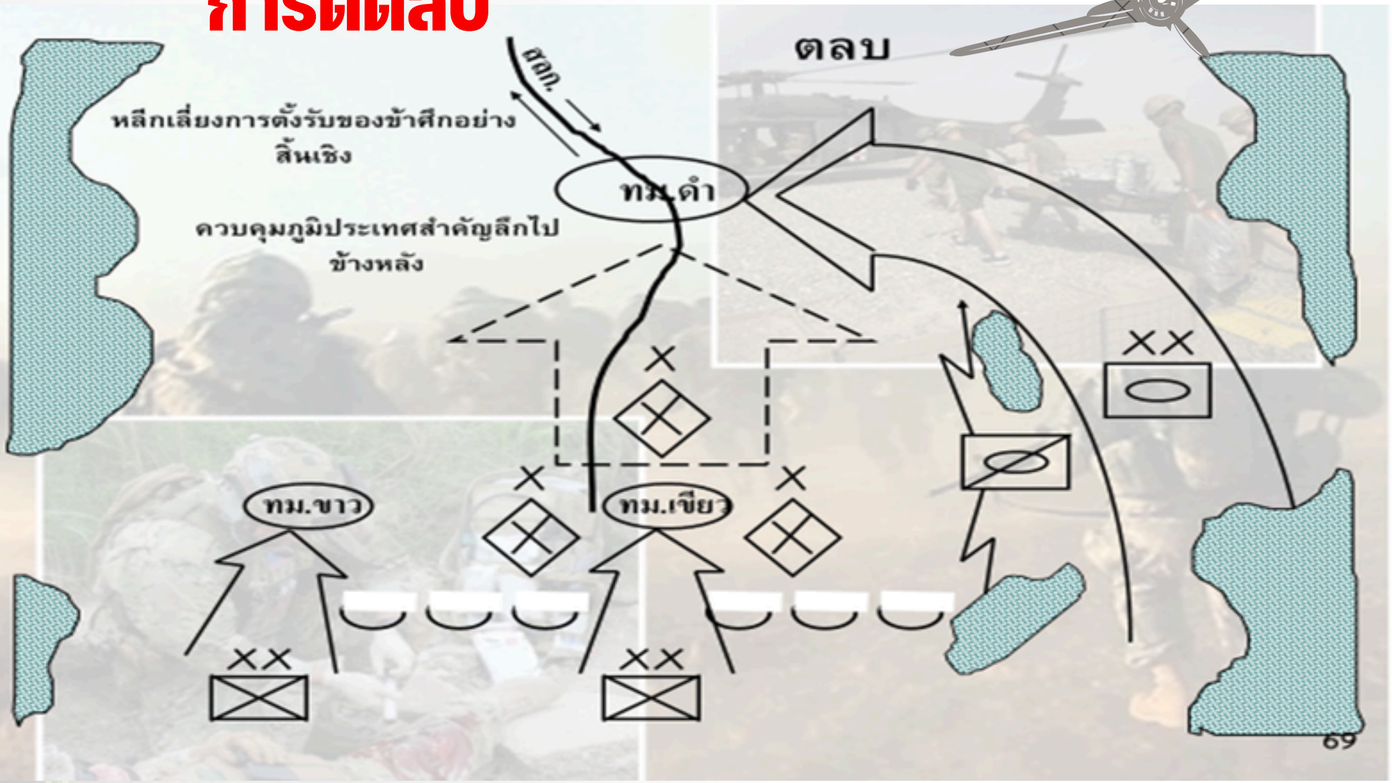
การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

การรบด้วยวิธีรุก

2. การเข้าตี

ใช้ทั้ง 5 แบบหรือบางแบบ ผสมผสาน

การตีตลบ



* แปร*รูปแบบของการตีโอบ* พยายามหลีกเลี่ยงการตั้งรับของข้าศึกอย่างสิ้นเชิง
* เข้า*ควบคุมภูมิประเทศสำคัญลึกไปข้างหลัง*ตามเส้นทางคมนาคมของข้าศึก
* เป็นผลให้*ข้าศึกต้องหันกลับ*จากที่มั่นตั้งรับ และ*ถูกบังคับ*ให้เข้าตีมาทางด้านหลังด้วยความเสียเปรียบ

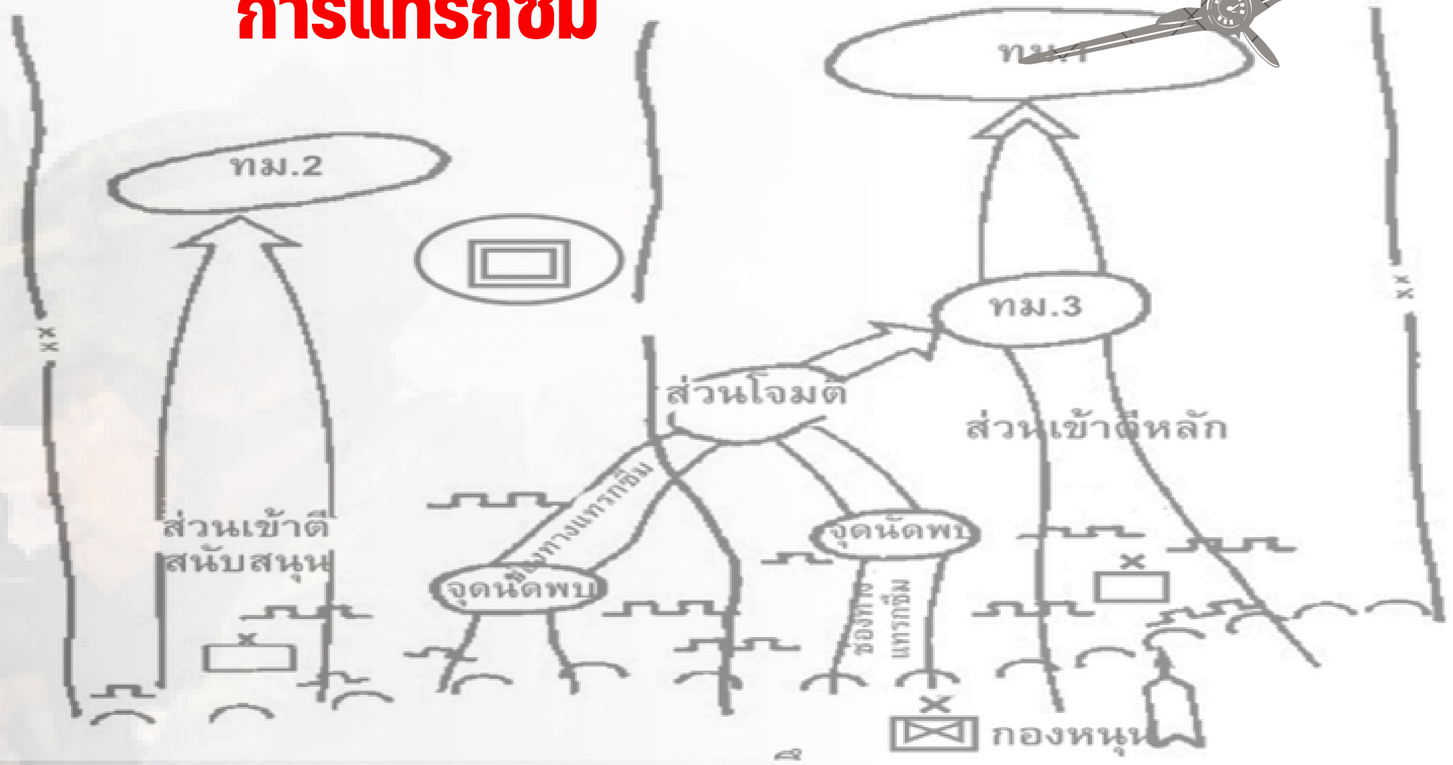
การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

การรบด้วยวิธีรุก

2. การเข้าตี

ใช้ทั้ง 5 แบบหรือบางแบบ ผสมผสาน

การแทรกซึม



- เข้าสู่ส่วนหลังข้าศึก โดยหลีกเลี่ยงการตั้งรับของ ขศ.ผ่านแนวของข้าศึกไปยังที่หมายข้างหลัง

* เคลื่อนที่ปกปิดกำลังบางส่วนหรือทั้งหมด หลีกเลี่ยงการถูกตรวจพบและการปะทะให้มากที่สุด

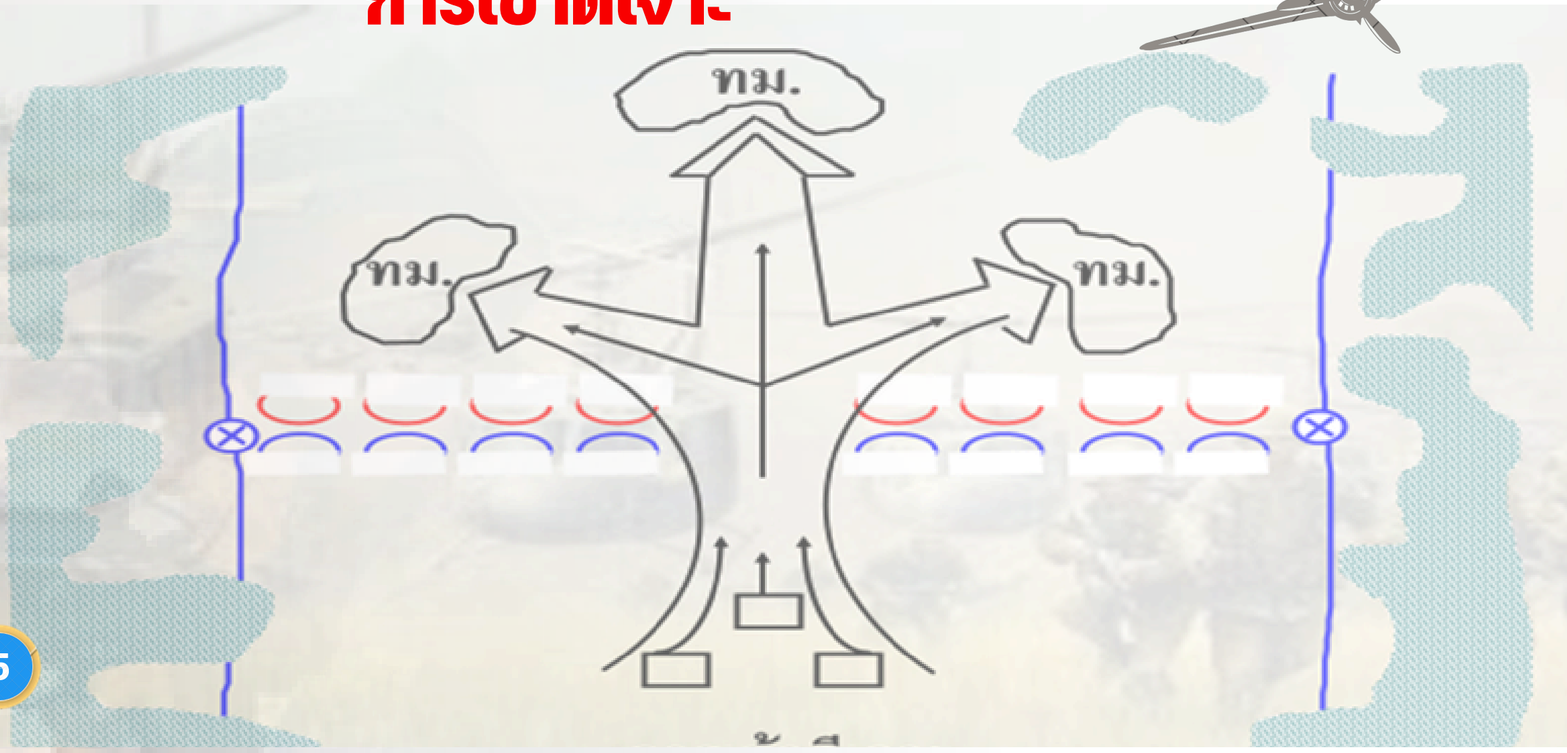
การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

การรบด้วยวิธีรุก

2. การเข้าตี

ใช้ทั้ง 5 แบบหรือบางแบบ ผสมผสาน

การเข้าตีเจาะ



* ใช้เมื่อปีกข้าศึกไม่เปิด ปัจจัยเวลาไม่อำนวยให้ใช้การดำเนินกลยุทธแบบอื่น
* พยายามเจาะช่องตั้งรับของข้าศึกด้วยความกว้างด้านหน้าแคบ
* พยายามทำให้ปีกทั้งสองของช่องเจาะเปิด เปิดช่อง พุ่งเข้าสู่ส่วนหลังของข้าศึก
* โดยทั่วไปการเข้าตีเจาะประกอบด้วย 3 ขั้นตอน

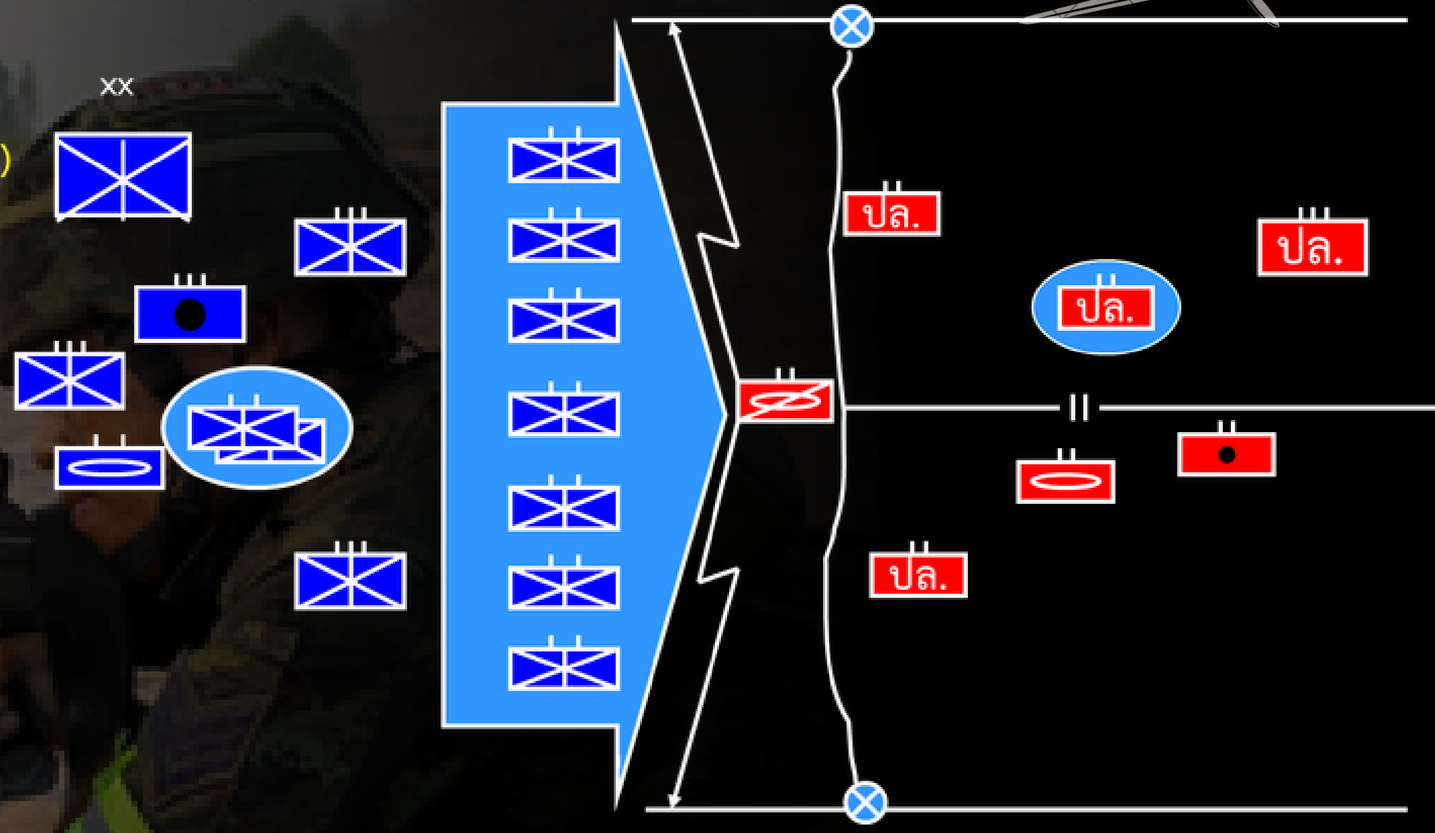
การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

การรบด้วยวิธีรุก

2. การเข้าตี

ใช้ทั้ง 5 แบบหรือบางแบบ ผสมผสาน

การเข้าตีตรงหน้า



* โจมตีกว้างด้านหน้า เป็นการดำเนินกลยุทธที่อันตรายที่สุด
* เปิดเผยกำลังของฝ่ายเข้าตี ล่อแหลมต่อการถูกระดมยิง จำกัดอำนาจการยิงของฝ่ายเข้าตี
* เป็นการดำเนินกลยุทธที่ง่ายที่สุด เหมาะนำมาใช้ต่อการตั้งรับที่เบาบาง

การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

การรบด้วยวิธีรุก

3. การขยายผล

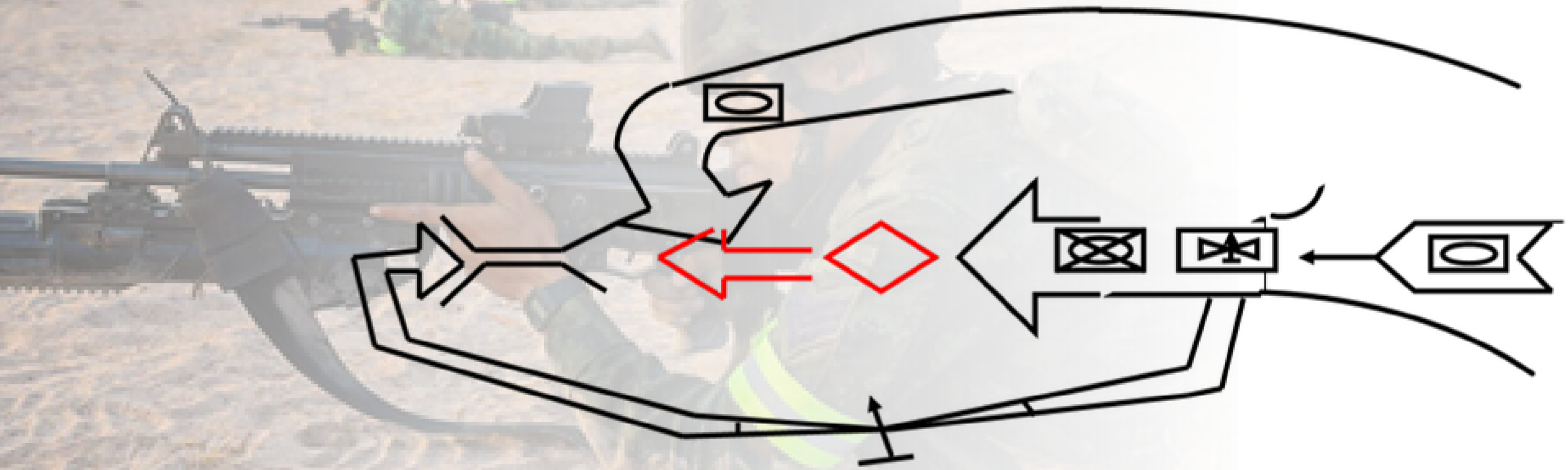
- เป็นการปฏิบัติเมื่อบรรลุผลสำเร็จของการเข้าตี
- ทำลายขีดความสามารถในการจัดระเบียบใหม่ก่อนจะทำการตั้งรับ หรือถอนตัวอย่างมีระเบียบของข้าศึก

การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

การรบด้วยวิธีรุก

4. การไล่ติดตาม

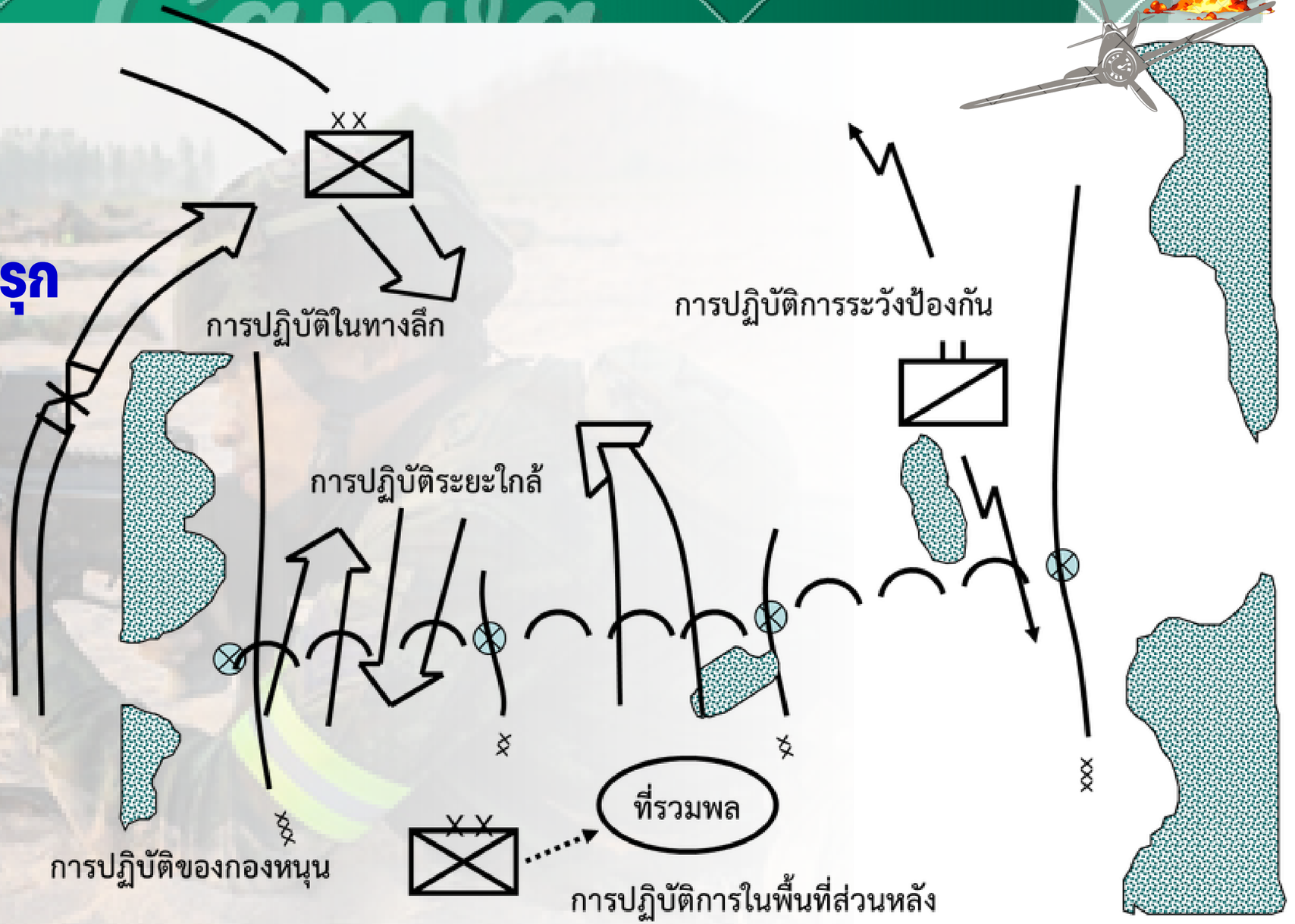
- เป็นการปฏิบัติต่อจากการขยายผล
- เพื่อทำลายกำลังฝ่ายตรงข้ามลงอย่างสิ้นเชิง
- ที่หมายของการไล่ติดตามคือ กำลังข้าศึกเริ่มเสียขวัญระส่ำระสายละทิ้งที่มั่น เริ่มผละหนี



การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

การรบด้วยวิธีรุก

โครงร่างของการปฏิบัติการรุก



MEDICAL SERVICE IN OFFENSIVE OPERATIONS

การบริการทางการแพทย์ในการรบด้วยวิธี รถ

การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

MEDICAL SERVICE IN OFFENSIVE OPERATIONS

การบริการทางการแพทย์ในการรบด้วยวิธีรุก

หลักนิยมทางการแพทย์ในการรบด้วยวิธีรุก

- ความคล่องตัวเป็นสิ่งสำคัญมาก
- การ ส่งกลับ ต้องทันเวลา และสถานการณ์
- ผบ.หน่วย รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมผู้ป่วย ในพื้นที่การรบ ไว้ในที่พยาบาลของตน
- ที่พยาบาลกองพลหน้า ทำการส่งกลับ ผป.จากที่พยาบาลกองพัน ไม่ใช่จากพื้นที่การรบ
- การส่งกลับจากที่พยาบาลกองพัน ไปยังที่พยาบาลกองพลหน้า มีความสำคัญมาก
- ในพื้นที่ที่มี ผป.หนาแน่น ต้องสามารถสนับสนุนการจัดตั้งที่พยาบาลได้
- การเข้าตีกว้างด้านหน้ามาก ทำให้การส่งกลับ ผป.เป็นไปอย่างยากลำบาก จากปัญหาการติดต่อสื่อสาร การลำเลียง ผป. ออกจากพื้นที่การรบ

การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

MEDICAL SERVICE IN OFFENSIVE OPERATIONS

การบริการทางการแพทย์ในการรบด้วยวิธีรุก

หลักนิยมทางการแพทย์ในการรบด้วยวิธีรุก

ลักษณะของการรบด้วยวิธีรุกที่มีอิทธิพลต่อการบริการแพทย์

การจู่โจม เป็นปัจจัยสำคัญของการเข้าตี ต้องรักษาความลับ หน่วยแพทย์มักไม่ได้รับอนุมัติให้เปิดที่รักษาพยาบาลเต็มรูปแบบ จนกว่าจะเริ่มเข้าตี

การวางแผน กำหนดแนวทางปฏิบัติ วางแผนไว้ล่วงหน้า ผบ.หน่วยแพทย์ต้องได้รับข่าวสาร เพื่อนำมาวางแผนให้สอดคล้อง

การขยายผลเพื่อความสำเร็จ วางแผนการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการไล่ติดตาม

แบบของการดำเนินกลยุทธ

มีอิทธิพลต่อการบริการทางการแพทย์

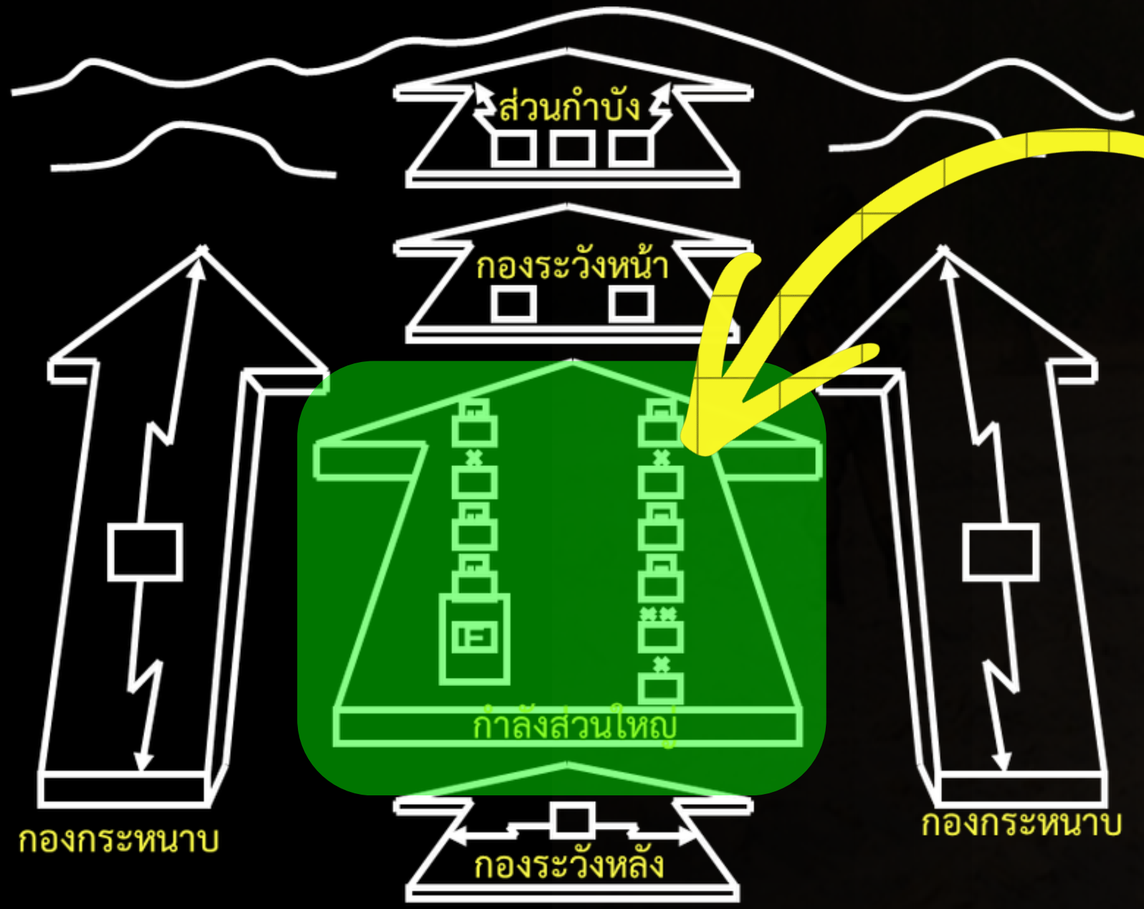
- จำนวนผู้ป่วยเจ็บ
- การกระจายของผู้ป่วยเจ็บ
- เวลา
- พื้นที่
- ที่ตั้ง
- การเคลื่อนย้ายหน่วย

การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

MEDICAL SERVICE IN OFFENSIVE OPERATIONS

การบริการทางการแพทย์ในการรบด้วยวิธีรุก

การบริการแพทย์ในการเคลื่อนที่เข้าปะทะ



กำลังส่วนใหญ่

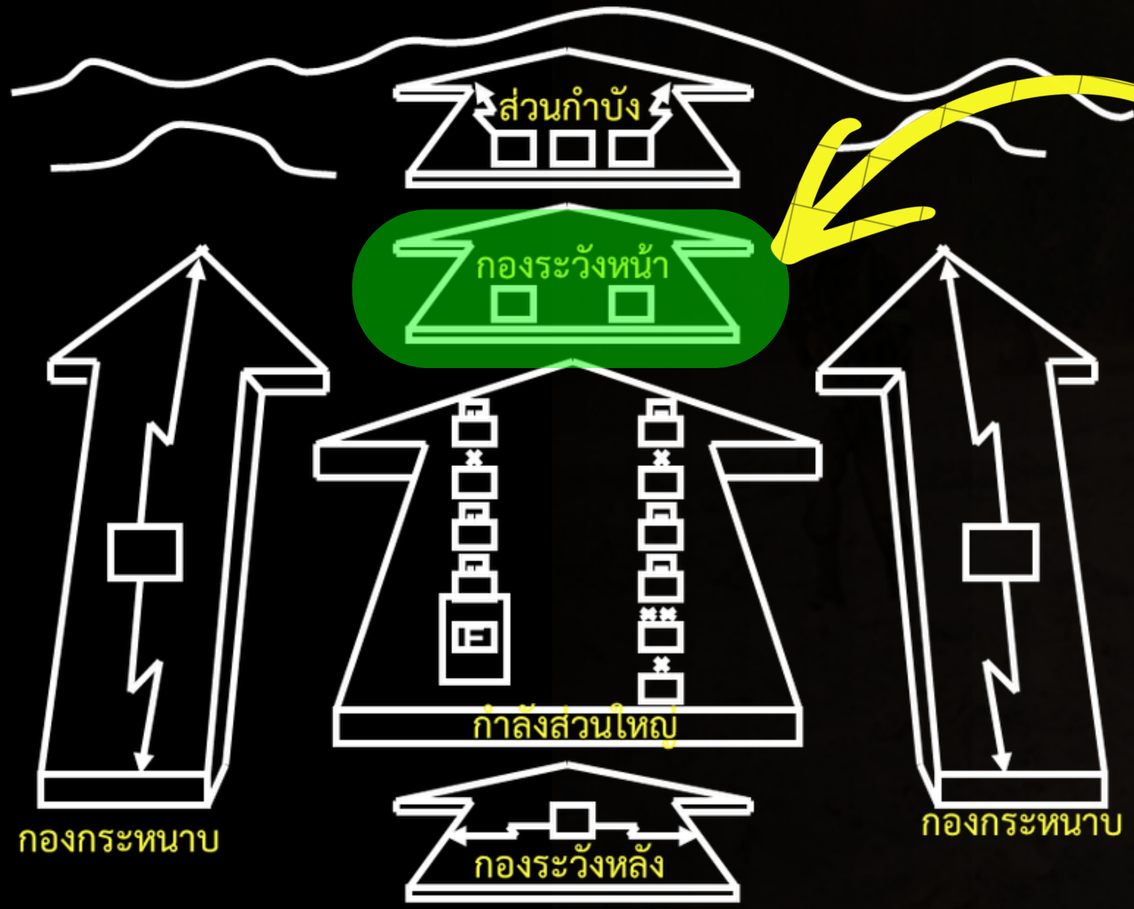
* ระหว่างการเคลื่อนที่กระทำได้เพียงปัจจุบันพยาบาล ถ้าหยุดหน่วยการบริการทางการแพทย์สามารถกระทำได้มากขึ้น
* ผป.ที่ไม่ต้องการความช่วยเหลือมาก ยังเดินได้ดีให้ร่วมขบวนไปกับหน่วยของตน
* ผป.ที่พอช่วยตนเองได้ ให้ปลดยุทธภัณฑ์ประจำตัวฝากไปกับเพื่อน หรือยานพาหนะ ส่วน ผป.ยังเดินไปกับขบวน

การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

MEDICAL SERVICE IN OFFENSIVE OPERATIONS

การบริการทางการแพทย์ในการรบด้วยวิธีรุก

การบริการแพทย์ในการเคลื่อนที่เข้าปะทะ



กองระวังหน้า

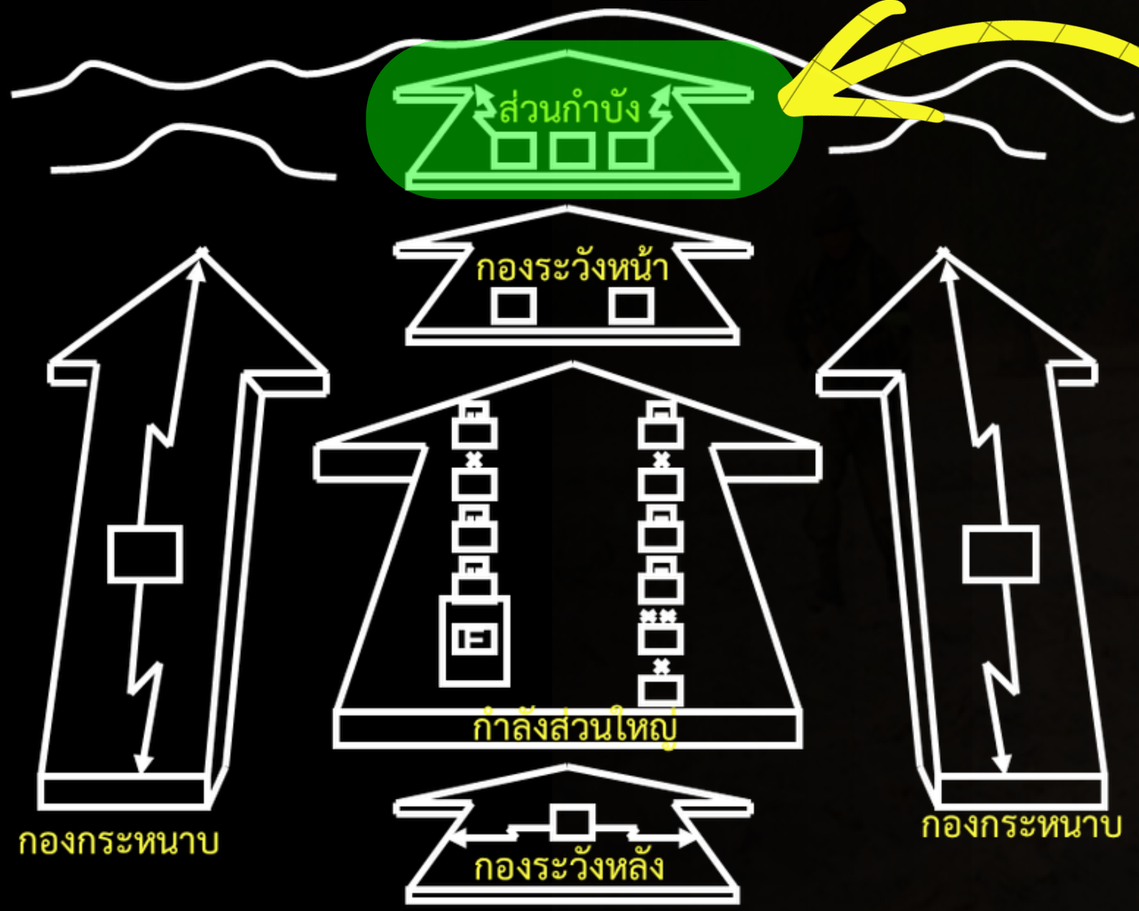
1. เมื่อมีผู้ป่วยเจ็บให้การรักษาขั้นต้น
2. นำ ผป.พักไว้ ณ ตำบลรวบรวมผู้ป่วยเจ็บที่กำหนดไว้
3. หลังจากนั้นให้เป็นหน้าที่ของกำลังส่วนใหญ่ที่จะเคลื่อนที่มาถึง

การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

MEDICAL SERVICE IN OFFENSIVE OPERATIONS

การบริการทางการแพทย์ในการรบด้วยวิธีรุก

การบริการแพทย์ในการเคลื่อนที่เข้าปะทะ



ส่วนกำบัง

*จัดหน่วยแพทย์สนับสนุนให้ได้ส่วนสัมพันธ์กับกำลังส่วนกำบัง

*ประกอบกำลังระดับกรมขึ้นไป อาจจัด รยพ. จาก พัน.สร.พล. ขึ้นสมทบด้วย

* ถ้ากำลังส่วนใหญ่จะผ่านพื้นที่ส่วนกำบังในเวลาไม่นานก็ไม่จำเป็นต้องเพิ่มเติมกำลัง

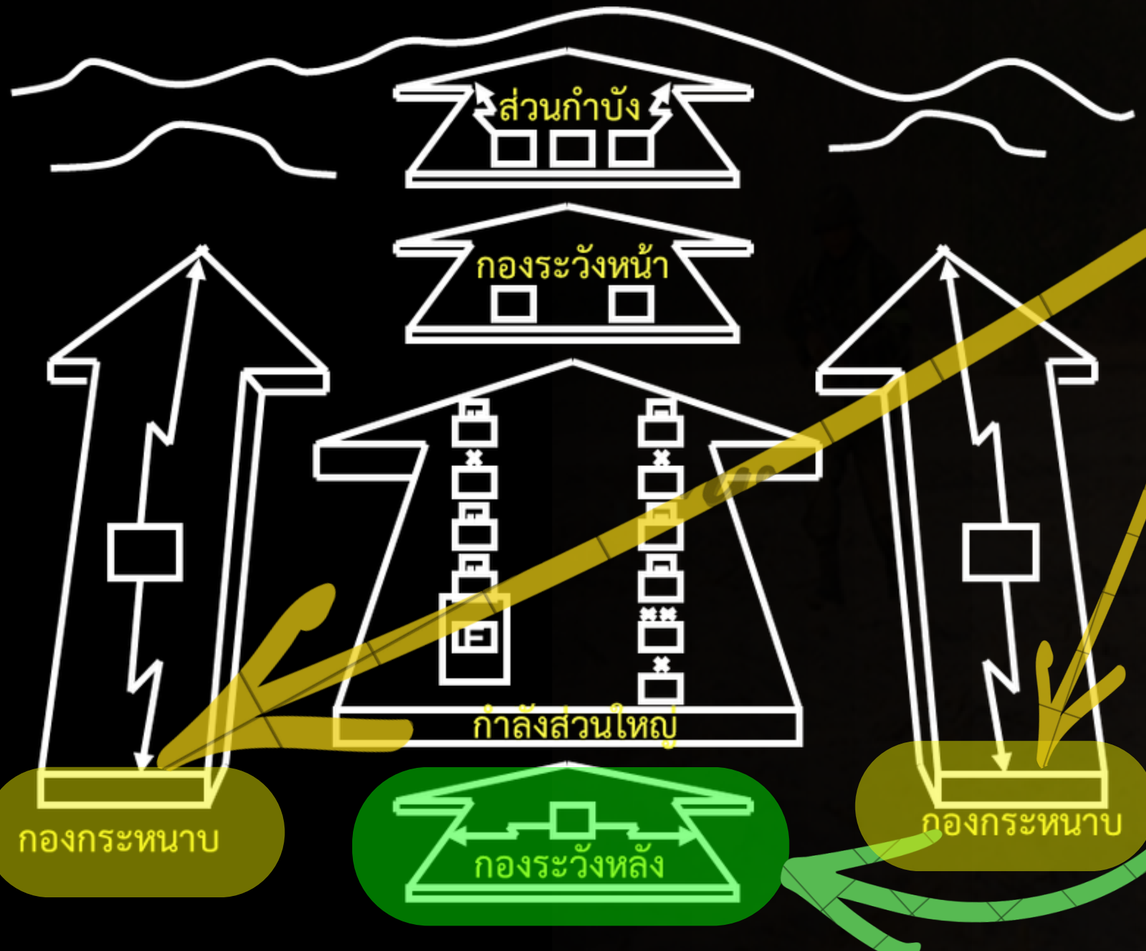
* ส่งกลับ ผป. มายังที่พยาบาลกองพล หรือหน่วยแพทย์อื่นที่อยู่ใกล้เคียง

การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

MEDICAL SERVICE IN OFFENSIVE OPERATIONS

การบริการทางการแพทย์ในการรบด้วยวิธีรุก

การบริการแพทย์ในการเคลื่อนที่เข้าปะทะ



กองกระหนาบ

ให้การรักษาขั้นต้น นำผู้ป่วยเจ็บไปกับหน่วยหรือลำเลียงเข้าหากำลังส่วนใหญ่

กองระวังหลัง

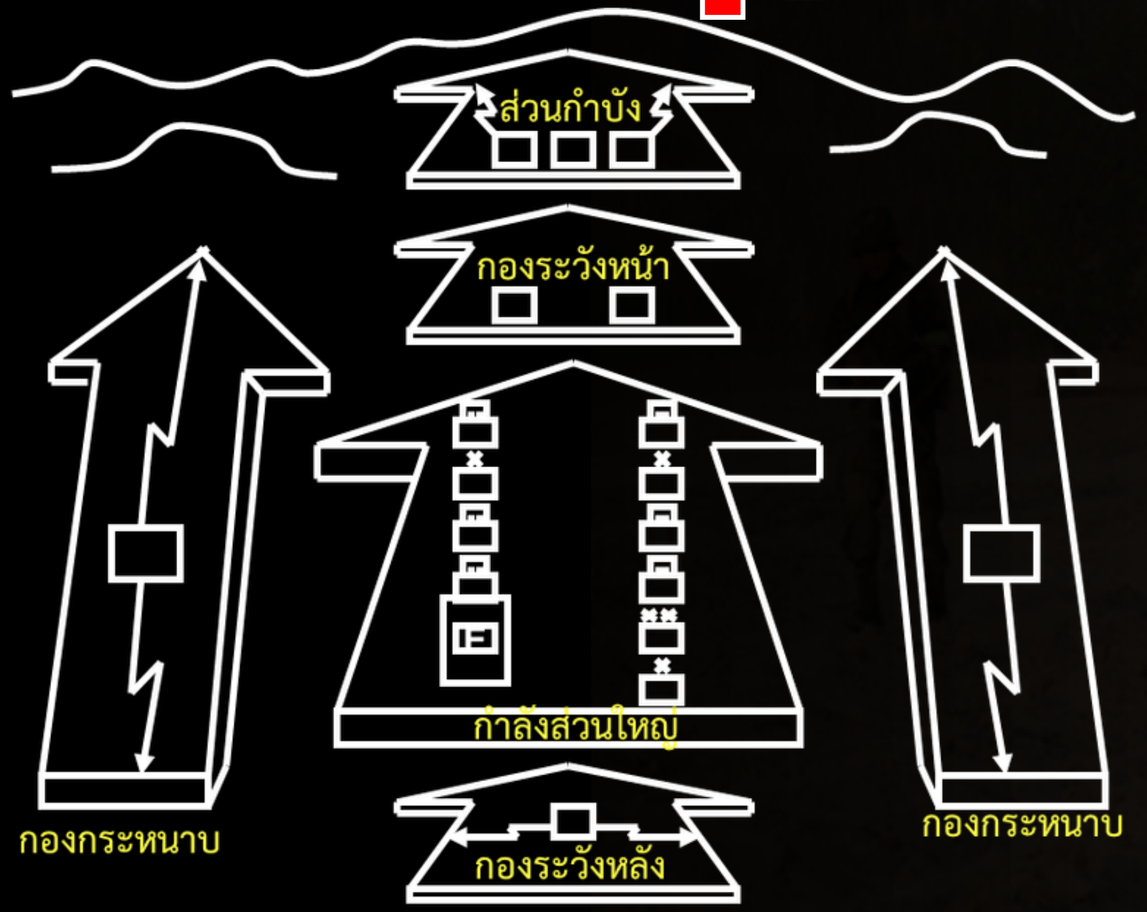
เมื่อมีผู้ป่วยเจ็บให้การรักษาขั้นต้น ส่งกลับผู้ป่วยเจ็บเข้าหากำลังส่วนใหญ่

การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

MEDICAL SERVICE IN OFFENSIVE OPERATIONS

การบริการทางการแพทย์ในการรบด้วยวิธีรุก

การบริการแพทย์ในการเคลื่อนที่เข้าปะทะ



การเก็บรวบรวมผู้ป่วยเจ็บ

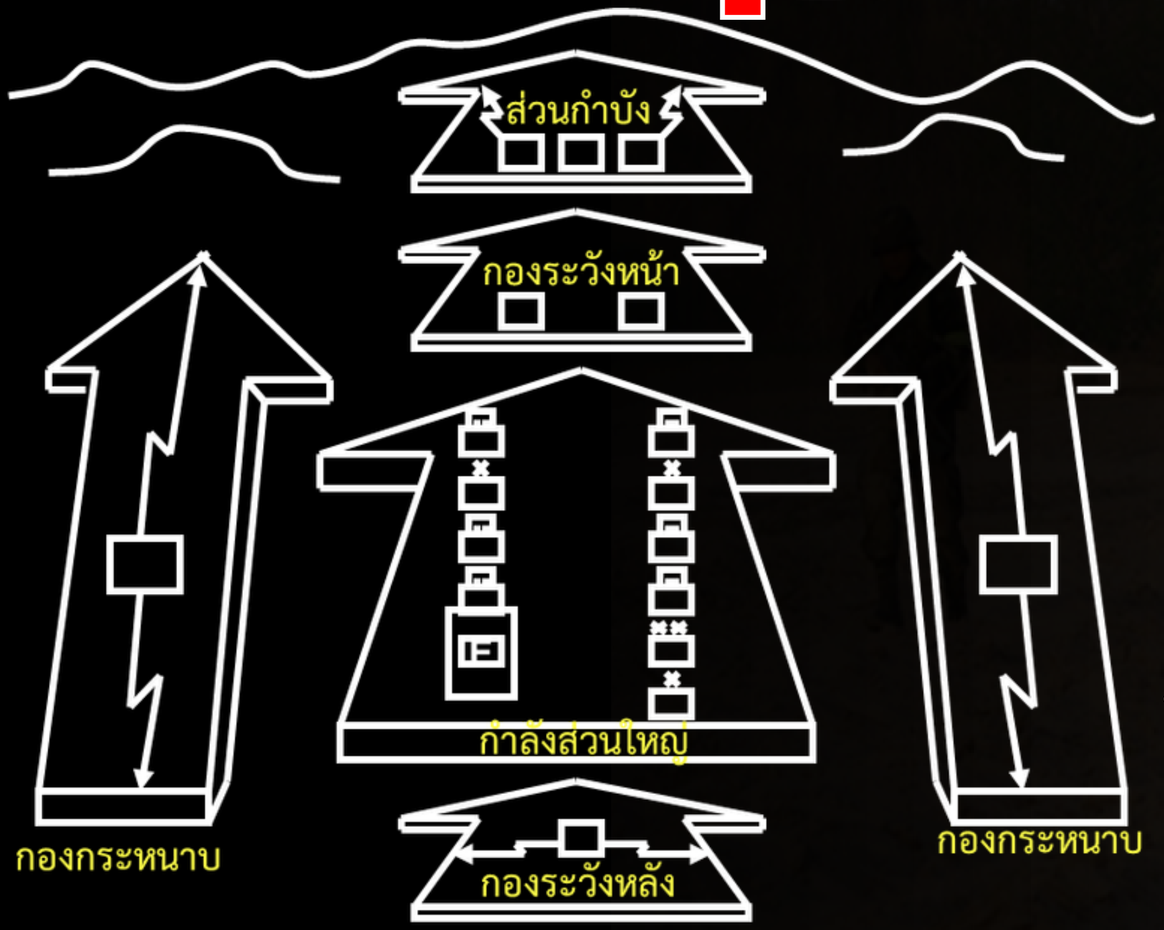
1. จัดตั้งตำบลรวบรวมผู้ป่วยเจ็บ
2. เมื่อไม่อาจจัดตั้งตำบลรวบรวมผู้ป่วยเจ็บได้
   * ปล่อยผู้ป่วยเจ็บไว้ข้างทางเพื่อให้หน่วยแพทย์ที่ติดตามมาเก็บรวบรวมและส่งกลับ
   * บรรทุกผู้ป่วยเจ็บไปกับรถยนต์พยาบาลของหน่วย จนกว่าจะร้องขอการส่งกลับได้

การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

MEDICAL SERVICE IN OFFENSIVE OPERATIONS

การบริการทางการแพทย์ในการรบด้วยวิธีรุก

การบริการแพทย์ในการเคลื่อนที่เข้าปะทะ



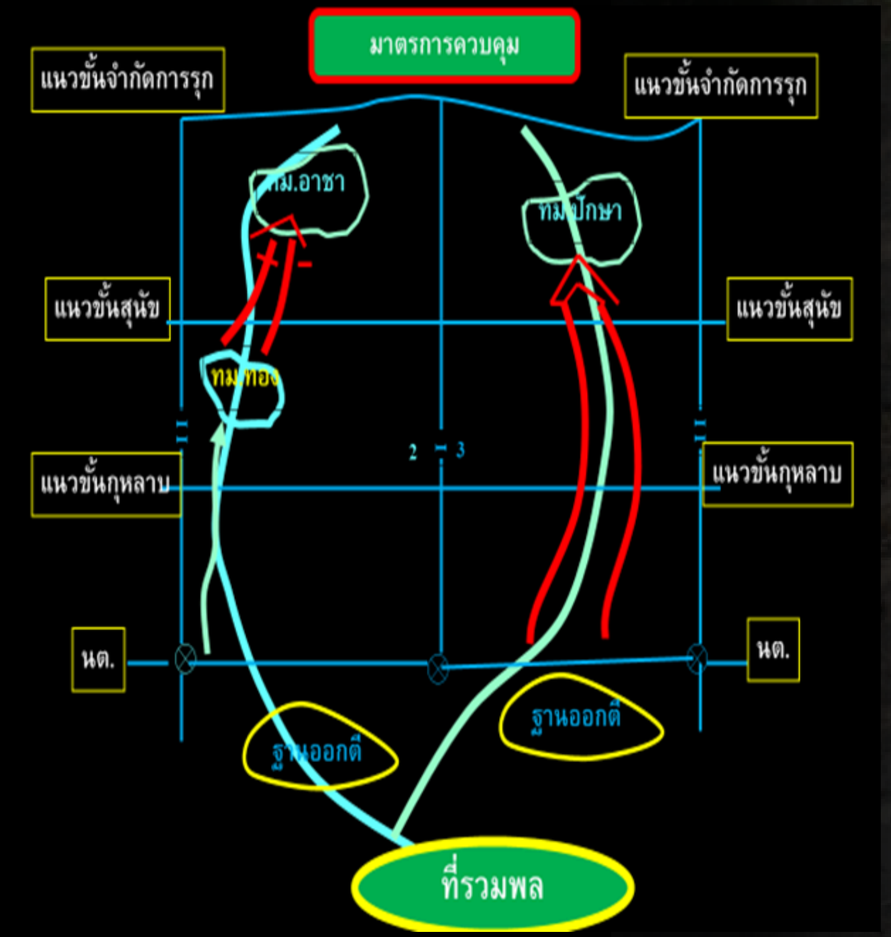
การวางกำลังของหน่วยแพทย์

* หน่วยแพทย์ต้องวางกำลังให้สามารถสนับสนุนหน่วยกำลังรบได้ทันที
* ผบ.หน่วยแพทย์ ร่วมไปกับ ผบ.หน่วยรบ ที่ตนสนับสนุน
* ส.พยาบาลกองร้อย ร่วมไปกับกองร้อยที่ตนขึ้นสมทบ
* มว.สร. ตามหลังหน่วยกำลังรบ แต่อยู่หน้าขบวนสัมภาระ
* ยานพาหนะสายแพทย์ไปกับขบวนสัมภาระ
* พัน.สร. อยู่ท้ายขบวน และอยู่บริเวณย่านกลาง เพื่อให้การสนับสนุนได้ทั่วถึง อาจจัดกำลังเพิ่มเติมให้กับหน่วยระวังป้องกัน

การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

MEDICAL SERVICE IN OFFENSIVE OPERATIONS

การบริการทางการแพทย์ในการรบด้วยวิธีรุก



การบริการทางการแพทย์ (ระดับหน่วย) ของ มว.สร.พัน.ร. ในการเข้าตี

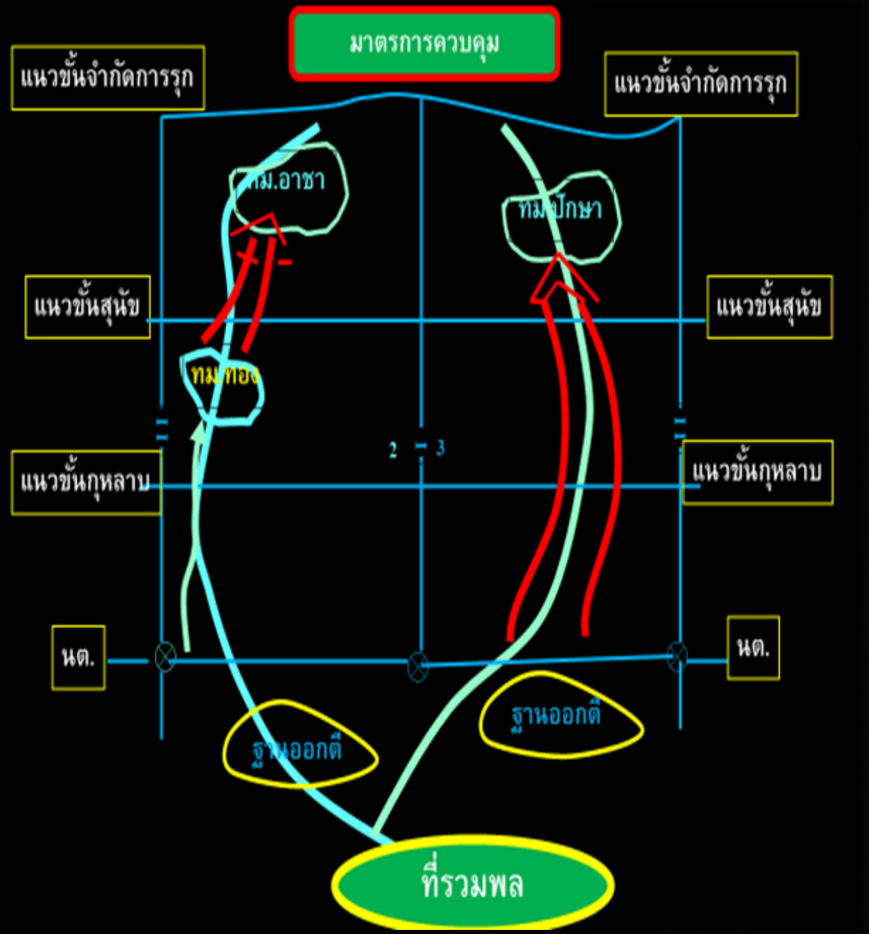
ก่อนเข้าที่รวมพล

* ส.พยาบาลกองร้อย ร่วมไปกับ ร้อย อวบ. ที่เหลือไปกับ มว.สร.
* เมื่อ พัน.ร. แยกขบวน พวกเปล ขยายให้เต็มกว้างด้านหน้า

การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

MEDICAL SERVICE IN OFFENSIVE OPERATIONS

การบริการทางการแพทย์ในการรบด้วยวิธีรุก



การบริการทางการแพทย์ (ระดับหน่วย) ของ มว.สร.พัน.ร. ในการเข้าตี

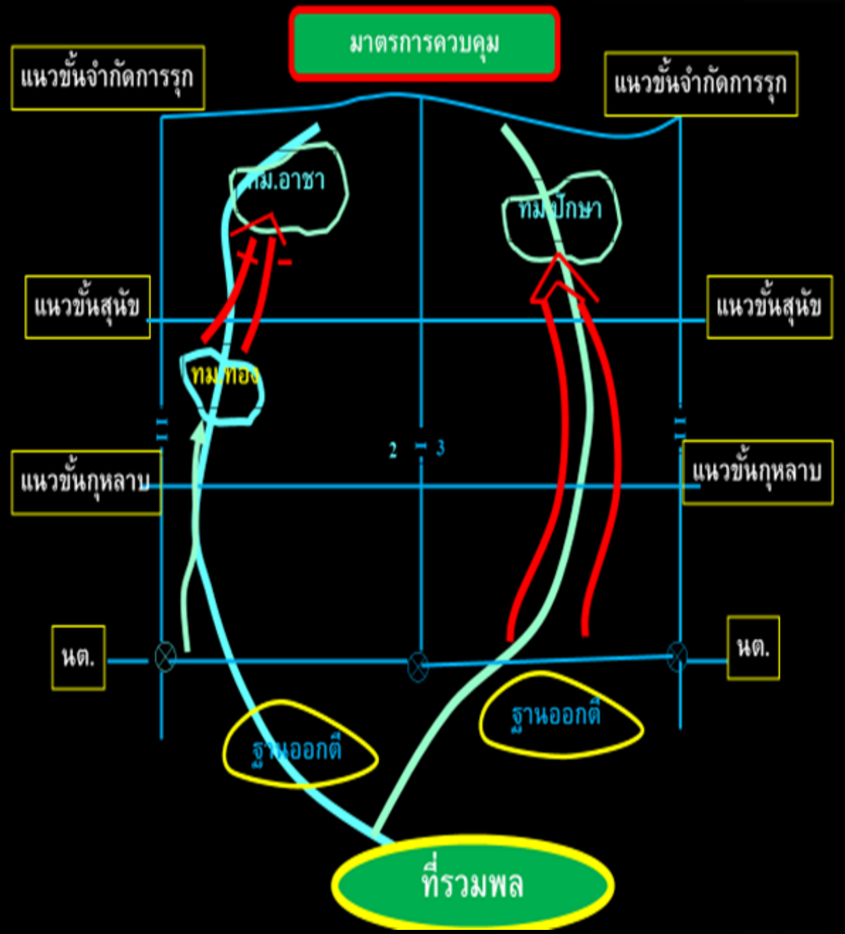
ในที่รวมพล

* ผบ.มว.สร.ปรับแผน/ออกคำสั่งหน่วยรอง
* เพิ่มเติม สป.สายแพทย์ ให้ ส.พยาบาลกองร้อย
* วางแผนใช้ รยพ. ไกลออกไปในพื้นที่ทางข้างให้มากที่สุด

การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

MEDICAL SERVICE IN OFFENSIVE OPERATIONS

การบริการทางการแพทย์ในการรบด้วยวิธีรุก



การบริการทางการแพทย์ (ระดับหน่วย) ของ มว.สร.พัน.ร. ในการเข้าตี

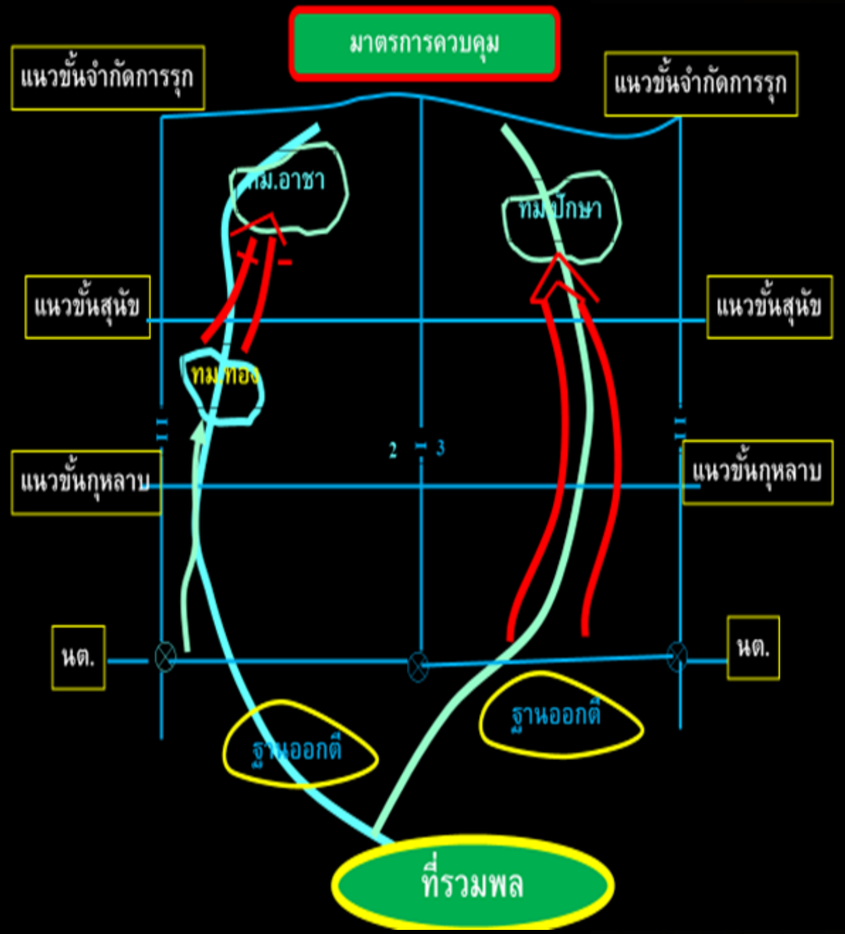
การผ่านแนวออกตี

* หน่วยต่างๆ แยกขบวน เปิดระยะเคียง/ต่อ มากขึ้น
* ส.พยาบาลกองร้อย ไปกับ ร้อย.อวบ.
* พวกเปล กระจายเต็มด้านหน้าของกองพัน
* ผบ.มว.สร. ไปกับ ผบ.พัน.ร. ให้นานที่สุด
* ใช้การยิงประกอบการเคลื่อนที่

การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

MEDICAL SERVICE IN OFFENSIVE OPERATIONS

การบริการทางการแพทย์ในการรบด้วยวิธีรุก



การบริการทางการแพทย์ (ระดับหน่วย) ของ มว.สร.พัน.ร. ในการเข้าตี

เมื่อผ่านแนวออกตี

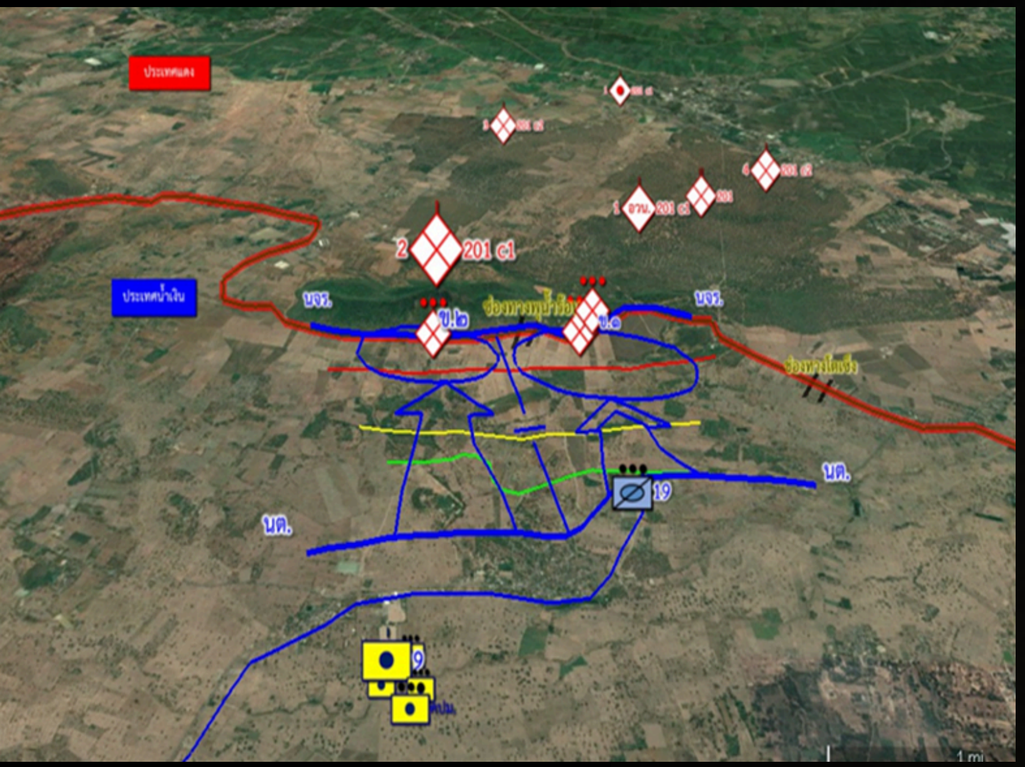
* ส.พยาบาลกองร้อย ไปกับ กองร้อยของตน
* พวกเปล กระจายเต็มด้านหน้าพร้อมสนับสนุน
* ที่พยาบาลกองพัน อาจยังไม่จัดตั้ง หรือตั้งเป็นบางส่วน
* เมื่อยังไม่จัดตั้ง ให้ลำเลียง ผป. เข้าหาเส้นหลักการรุก
* ผบ.มว.สร. สำรวจเส้นทาง เลือกตำบลจัดตั้งที่ พยาบาลกองพัน

การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

MEDICAL SERVICE IN OFFENSIVE OPERATIONS

การบริการทางการแพทย์ในการรบด้วยวิธีรุก

การบริการทางการแพทย์ (ระดับกองพล) ของ พัน.สร. พล.ร. ในการเข้าตี



อุปสรรคในการบริการทางการแพทย์

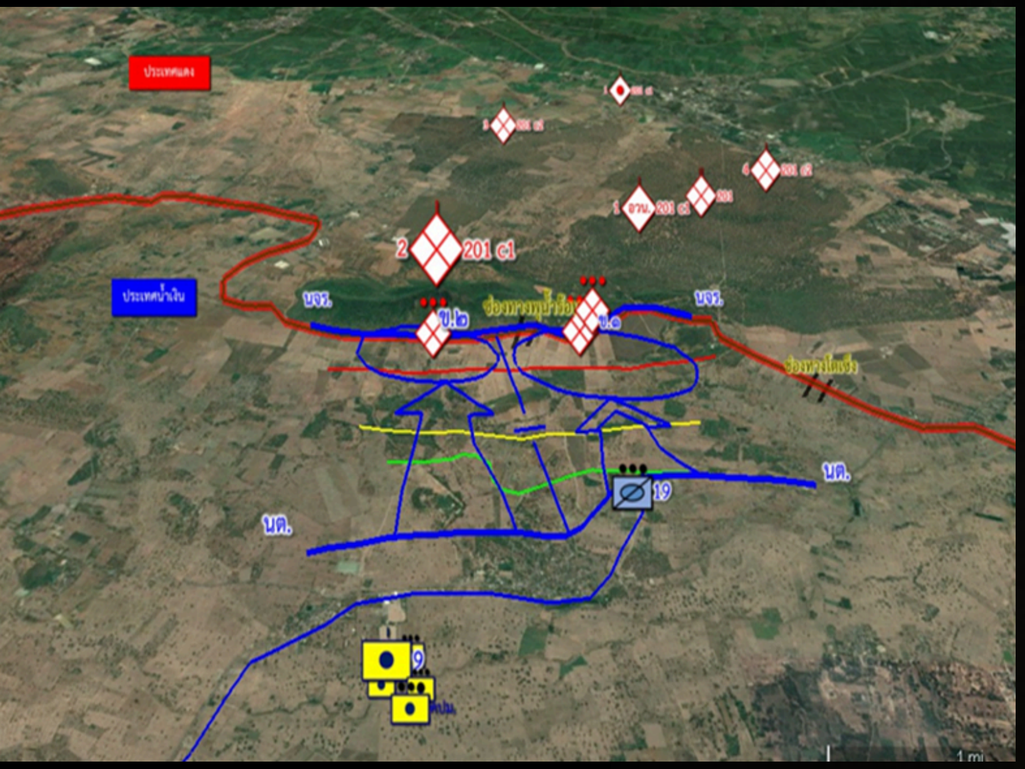
* ผป. เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก
* การดำรงการติดต่อหน่วยลำบาก
* แนวรุกไม่สม่ำเสมอ ทำให้มีปัญหาการส่งกลับการติดต่อ
* อาจต้องแบ่งที่พยาบาลออกเป็น 2 ส่วน เมื่อยึดพื้นที่ได้มาก

การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

MEDICAL SERVICE IN OFFENSIVE OPERATIONS

การบริการทางการแพทย์ในการรบด้วยวิธีรุก

การบริการทางการแพทย์ (ระดับกองพล) ของ พัน.สร. พล.ร. ในการเข้าตี



ข้อพิจารณาในการบริการทางการแพทย์

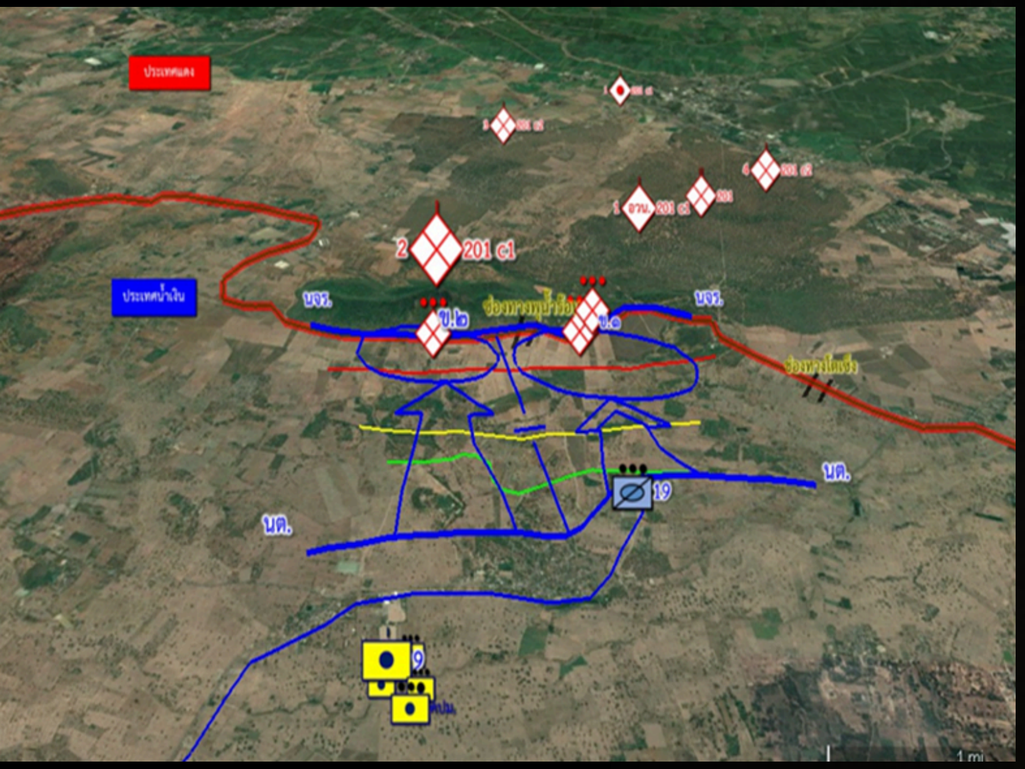
* การใช้หน่วยได้ดีพียงใด อยู่ที่พิจารณาการวางกำลัง
* การวางแผนโดยละเอียด การประสานเป็นสิ่งจำเป็น
* นขต.มีเสรีในการปฏิบัติ มากขึ้น
* การใช้ รยพ. เป็นไปตามสถานการณ์
* ที่พยาบาลกองพล ควรตั้งค่อนไปข้างหน้ามากๆ
* ดำรงความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่
* ถ้า การเข้าตีหลัก การเข้าตีสนับสนุน ห่างกันมาก อาจต้องแยกที่พยาบาลออกเป็น 2 แห่ง

การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

MEDICAL SERVICE IN OFFENSIVE OPERATIONS

การบริการทางการแพทย์ในการรบด้วยวิธีรุก

การบริการทางการแพทย์ (ระดับกองพล) ของ พัน.สร. พล.ร. ในการเข้าตี



การบริการทางการแพทย์ในการเข้าตีหลัก เข้าตีสนับสนุน

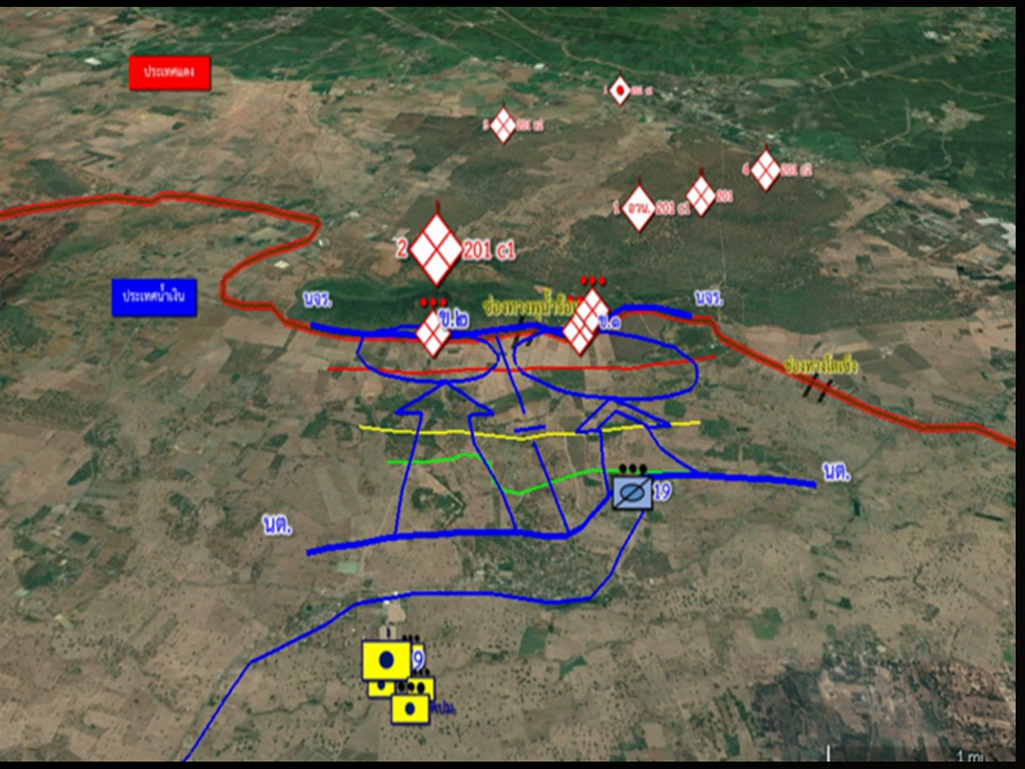
* ผบ.พัน.สร.ต้องทราบแผนการดำเนินกล ยุทธเพื่อการวางแผน
* ส่วนเข้าตีหลักจะได้รับการสนับสนุน สป./กพ. อย่างเต็มที่
* หน่วยแพทย์ที่สนับสนุนส่วนเข้าตีหลัก ต้องดำรงความคล่องแคล่วในการเคลื่อนย้ายติดตามหน่วยดำเนินกลยุทธ์
* ส่วนเข้าตีสนับสนุน ถ้ากว้างด้านหน้ามากกำลังจะกระจาย ผป. มีน้อย แต่การส่งกลับล่าช้า เพราะไกล/ข้าศึกขัดขวาง

การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

MEDICAL SERVICE IN OFFENSIVE OPERATIONS

การบริการทางการแพทย์ในการรบด้วยวิธีรุก

การบริการทางการแพทย์ (ระดับกองพล) ของ พัน.สร. พล.ร. ในการเข้าตี



การบริการทางการแพทย์ในการเข้าตีหลัก เข้าตีสนับสนุน

* ผบ.พัน.สร.ต้องทราบแผนการดำเนินกล ยุทธเพื่อการวางแผน
* ส่วนเข้าตีหลักจะได้รับการสนับสนุน สป./กพ. อย่างเต็มที่
* หน่วยแพทย์ที่สนับสนุนส่วนเข้าตีหลัก ต้องดำรงความคล่องแคล่วในการเคลื่อนย้ายติดตามหน่วยดำเนินกลยุทธ์
* ส่วนเข้าตีสนับสนุน ถ้ากว้างด้านหน้ามากกำลังจะกระจาย ผป. มีน้อย แต่การส่งกลับล่าช้า เพราะไกล/ข้าศึกขัดขวาง

การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

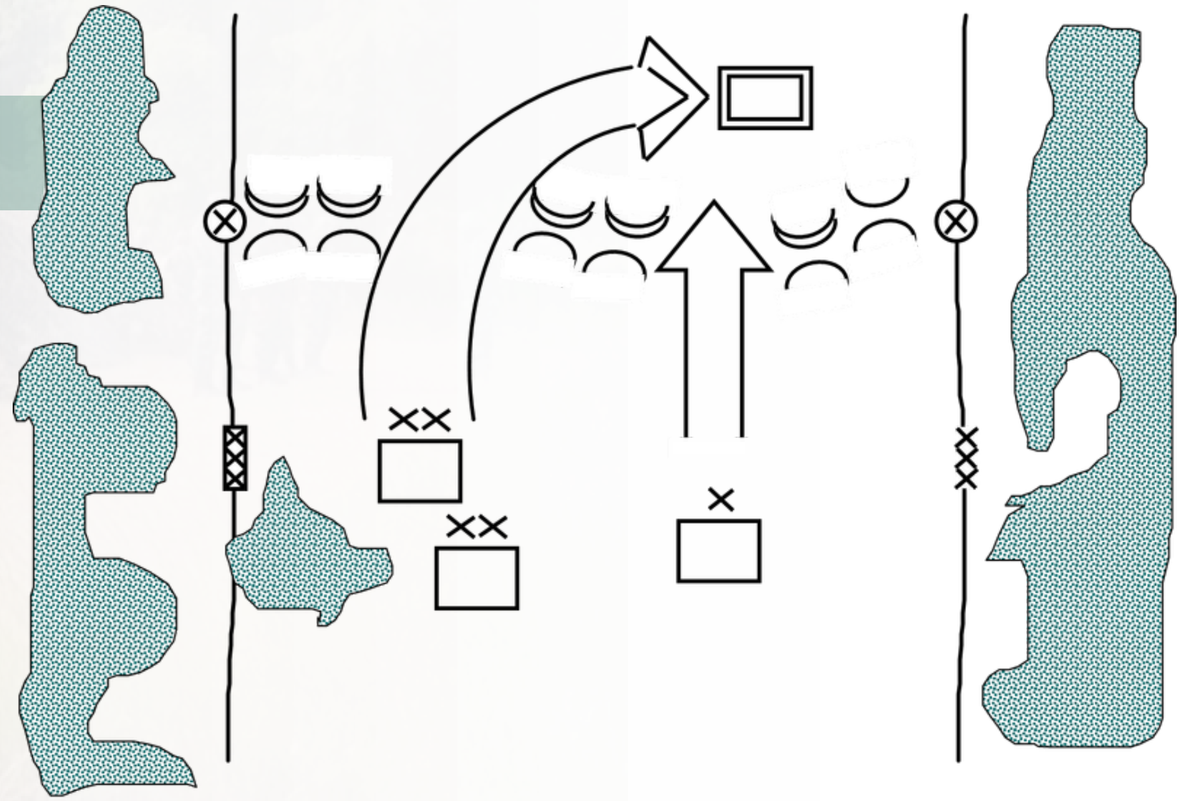
MEDICAL SERVICE IN OFFENSIVE OPERATIONS

การบริการทางการแพทย์ในการรบด้วยวิธี รุก

การบริการทางการแพทย์ (ระดับกองพล) ของ พัน.สร. พล.ร. ในการเข้าตี

การบริการทางการแพทย์ในการเข้าตีโอบ

* เคลื่อนที่ตามเส้นหลักการรุก
* ให้บริการแพทย์กับส่วนเข้าตีหลักอย่างเพียงพอ
* ที่พยาบาลกองพลเปิดเป็นบางส่วน และเตรียมเคลื่อนย้ายหน่วยสนับสนุนส่วนเข้าตีหลัก
* รยพ. ใช้ตามปกติ มีสำรองสำหรับส่งกลับผป.ทางปีก



การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

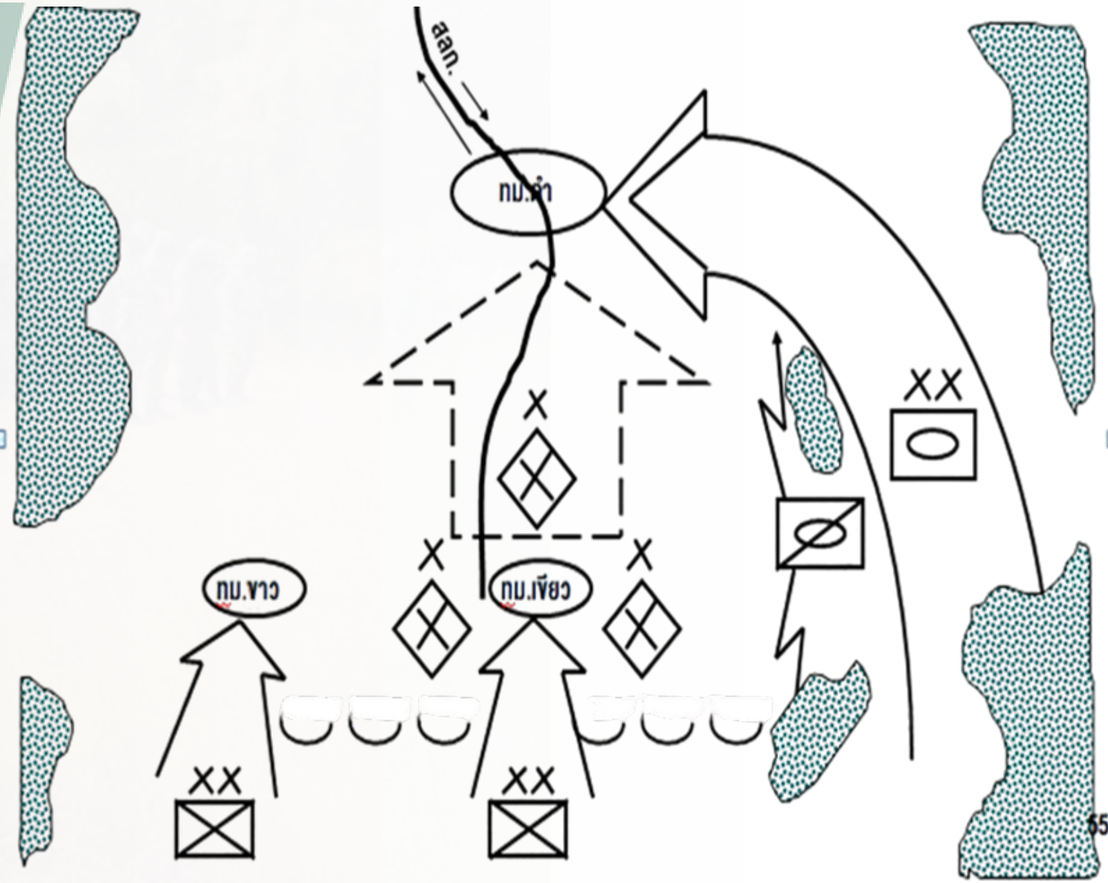
MEDICAL SERVICE IN OFFENSIVE OPERATIONS

การบริการทางการแพทย์ในการรบด้วยวิธี รุก

การบริการทางการแพทย์ (ระดับกองพล) ของ พัน.สร. พล.ร. ในการเข้าตี

การบริการทางการแพทย์ในการเข้าตีตลบ

* แบ่งหน่วยแพทย์ให้ส่วนเข้าตีหลักเป็นอิสระ
* ที่พยาบาลกองพลเปิดเป็นบางส่วน บริเวณ ด้านหลังที่รวมพล
* เมื่อเริ่มเข้าตี ที่พยาบาลกองพลเคลื่อนย้ายเพื่อ เตรียมให้บริการแพทย์
* ผป. จากส่วนเข้าตีสนับสนุน จะทยอยเข้ามาเป็นระยะ
* ผป.จากส่วนเข้าตีหลัก มาก/น้อย ขึ้นกับ สถานการณ์
* การบริการแพทย์ระดับหน่วย คงสนับสนุนหน่วยดำเนินกลยุทธ์



การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

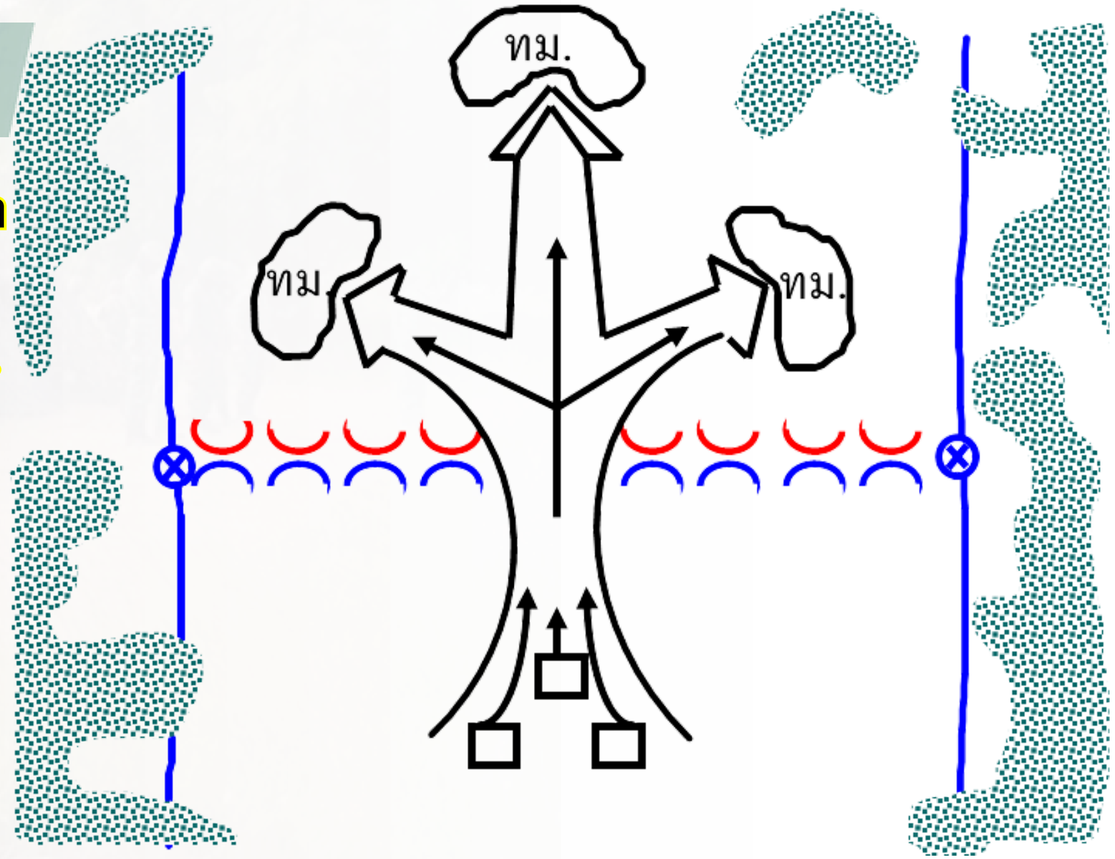
MEDICAL SERVICE IN OFFENSIVE OPERATIONS

การบริการทางการแพทย์ในการรบด้วยวิธีรุก

การบริการทางการแพทย์ (ระดับกองพล) ของ พัน.สร. พล.ร. ในการเข้าตี

การบริการทางการแพทย์ในการเข้าตีเจาะ

* ระยะแรก ผป.จะเกิดขึ้นจำนวนมาก การรวบรวม/ส่งกลับ กระทำได้ช้า
* การเจาะสำเร็จ รวบรวม/ส่งกลับ กระทำได้เร็วขึ้น
* การเจาะล้มเหลว ผป.จำนวนมากถูกจับเป็นเชลยการเก็บรวมรวม ผป. ทำได้เฉพาะเวลากลางคืน ส่งกลับล่าช้า
* ต้องมีบริการทางการแพทย์ สำหรับกองหนุน
* การเคลื่อนย้ายที่พยาบาลกองพล ติดตามอาจยุ่งยากพิจารณาตั้งระหว่างทางได้



การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

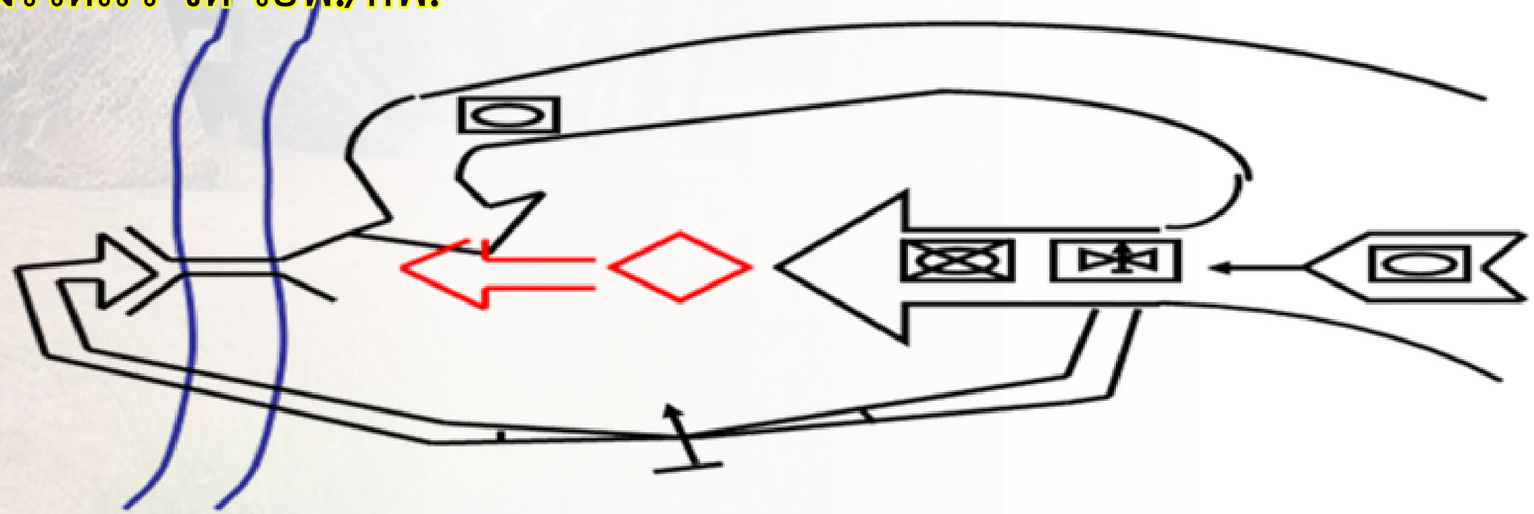
MEDICAL SERVICE IN OFFENSIVE OPERATIONS

การบริการทางการแพทย์ในการรบด้วยวิธีรุก

การบริการทางการแพทย์ (ระดับกองพล) ของ พัน.สร. พล.ร. ในการเข้าตี

การบริการแพทย์ในการไล่ติดตาม

* ใช้บริการทางการแพทย์แบบการรุกอย่างรวดเร็ว
* หน่วยโอบล้อมใช้บริการแพทย์แบบการรุกอย่างรวดเร็ว จัด รยพ./กพ. จากที่พยาบาลกองพลสมทบหน่วยโอบล้อม



การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

การบริการทางการแพทย์ในการรบด้วยวิธีตั้งรับ

การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

การบริการทางการแพทย์ในการรบด้วยวิธีตั้งรับ

- ทำให้การเข้าตีของข้าศึกล้มเหลว
- กลับเป็นฝ่ายครองความคิดริเริ่ม

เป็นมาตรการชั่วคราวที่นำมาใช้ เพื่อ
- เอาชนะการเข้าตีของข้าศึก
- ชิงความริเริ่ม กลับเป็นฝ่ายรุกใหม่

การรบด้วยวิธีรับ

วัตถุประสงค์
- ทำลายการเข้าตีของข้าศึกให้ได้เวลา
- รวมกำลัง ณ ตำบลอื่น
- ควบคุมภูมิประเทศสำคัญ/สำคัญยิ่ง
- บั่นทอนกำลังข้าศึกเพื่อกลับไปเป็นฝ่ายรุก
- ยึดที่หมายทางยุทธศาสตร์/ยุทธการ/ยุทธวิธี

METT-T

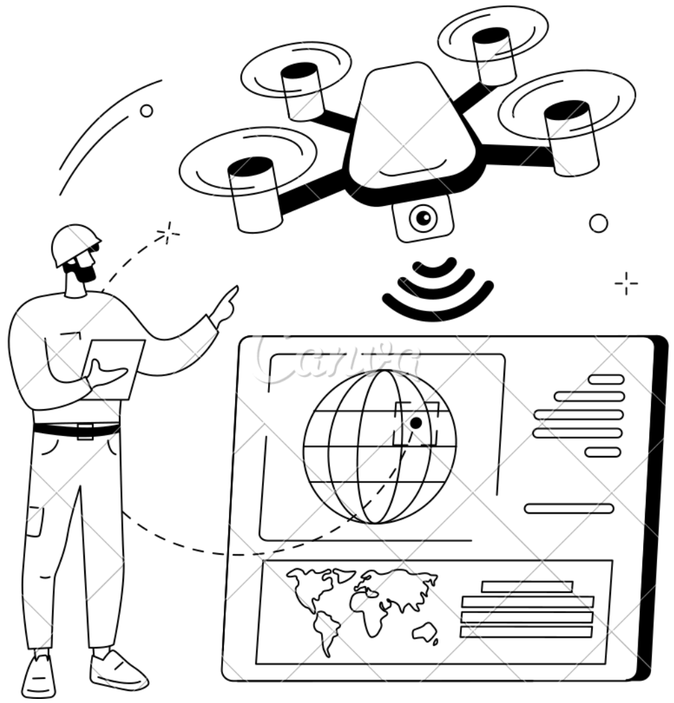
แบบของการตั้งรับ

- **แบบยึดพื้นที่** — เป้าหมาย คือ รักษาพื้นที่รับผิดชอบ
- **แบบคล่องตัว** — เป้าหมาย คือ ทำลายกำลัง ขศ.

การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

การบริการทางการแพทย์ในการรบด้วยวิธีตั้งรับ

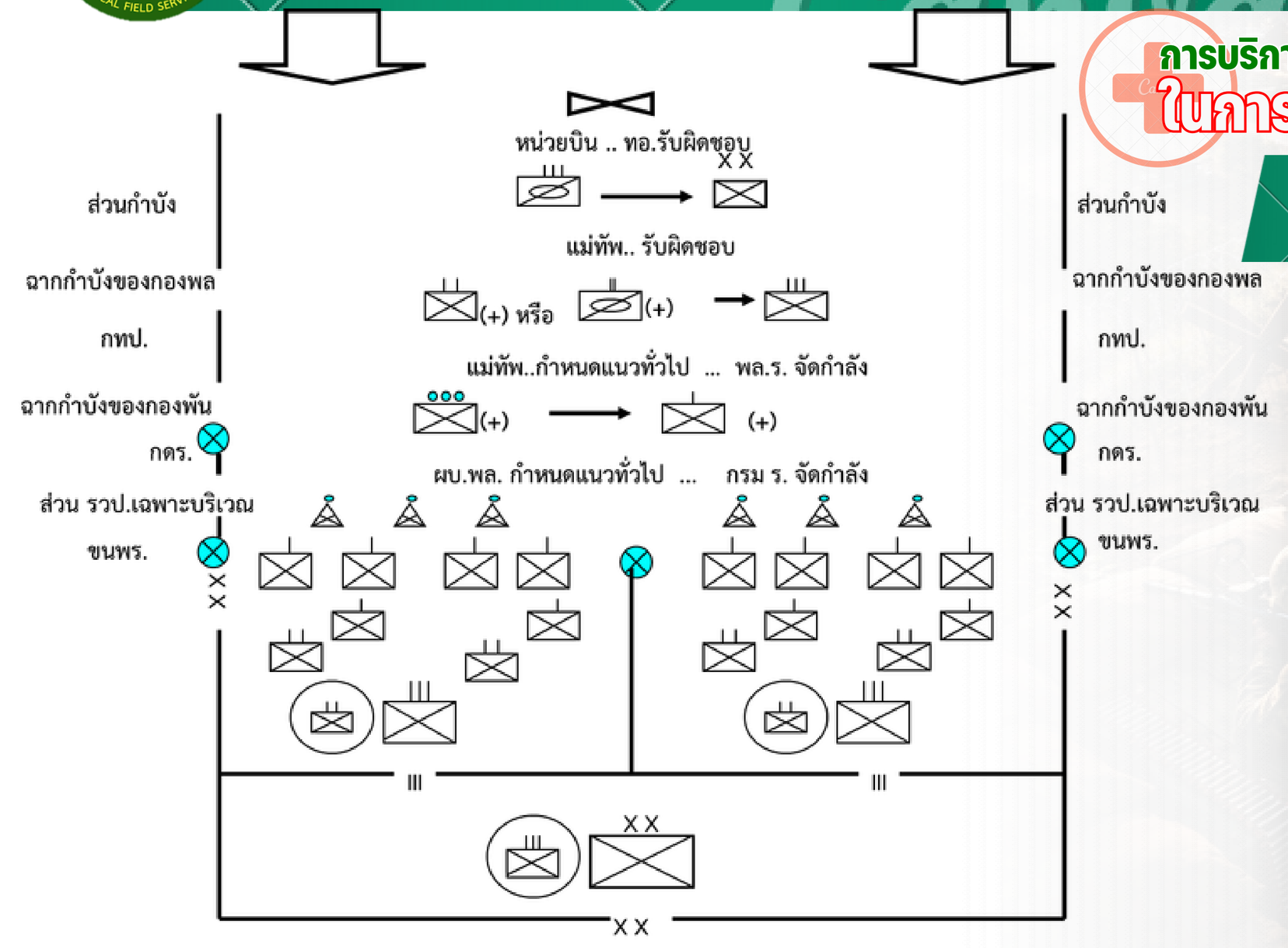
โครงร่างการปฏิบัติการตั้งรับ



การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

การบริการทางการแพทย์ในการรบด้วยวิธีตั้งรับ

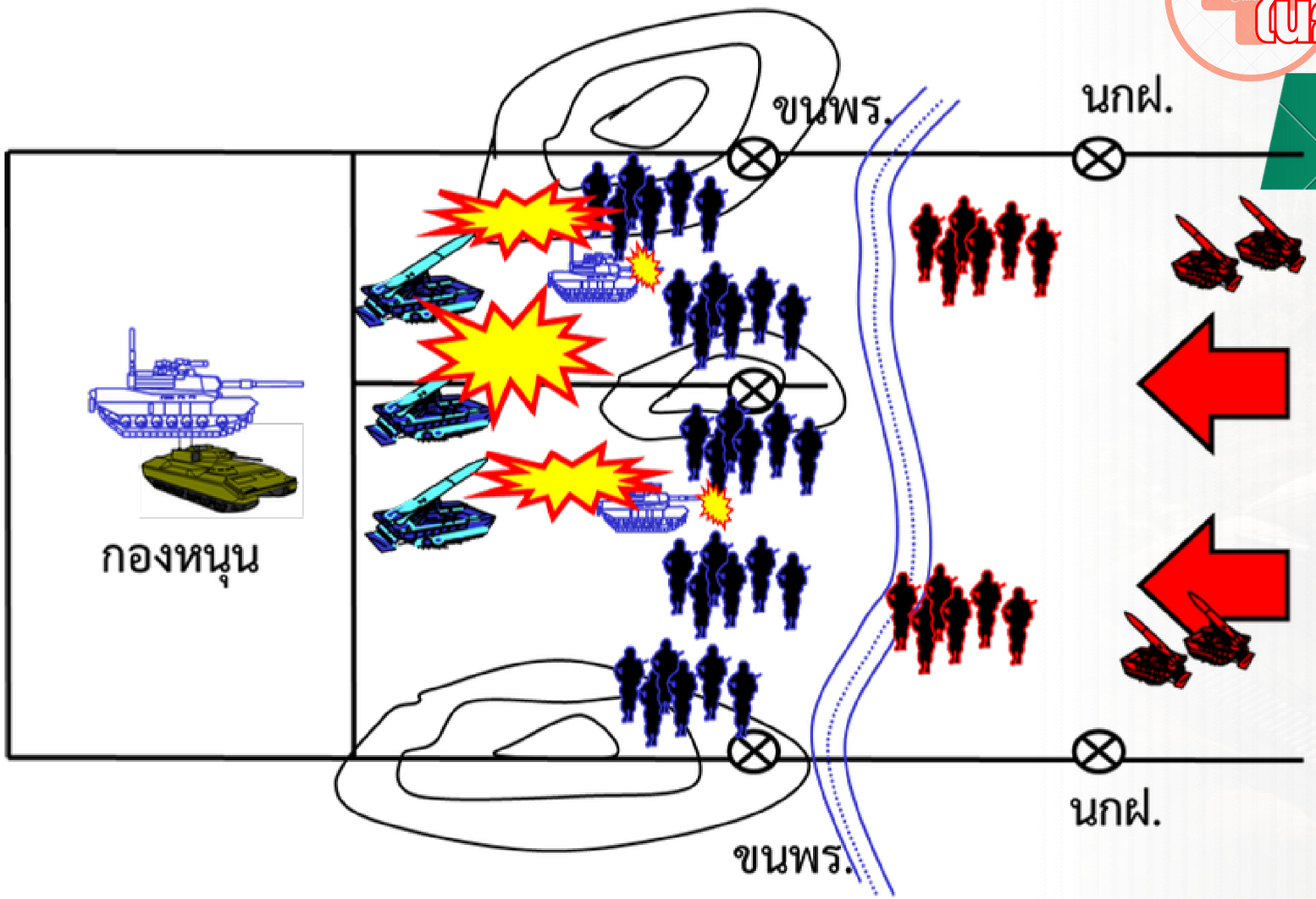
การวางกำลังในการตั้งรับ



การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

การบริการทางการแพทย์ในการรบด้วยวิธีตั้งรับ

การตั้งรับแบบยึดพื้นที่

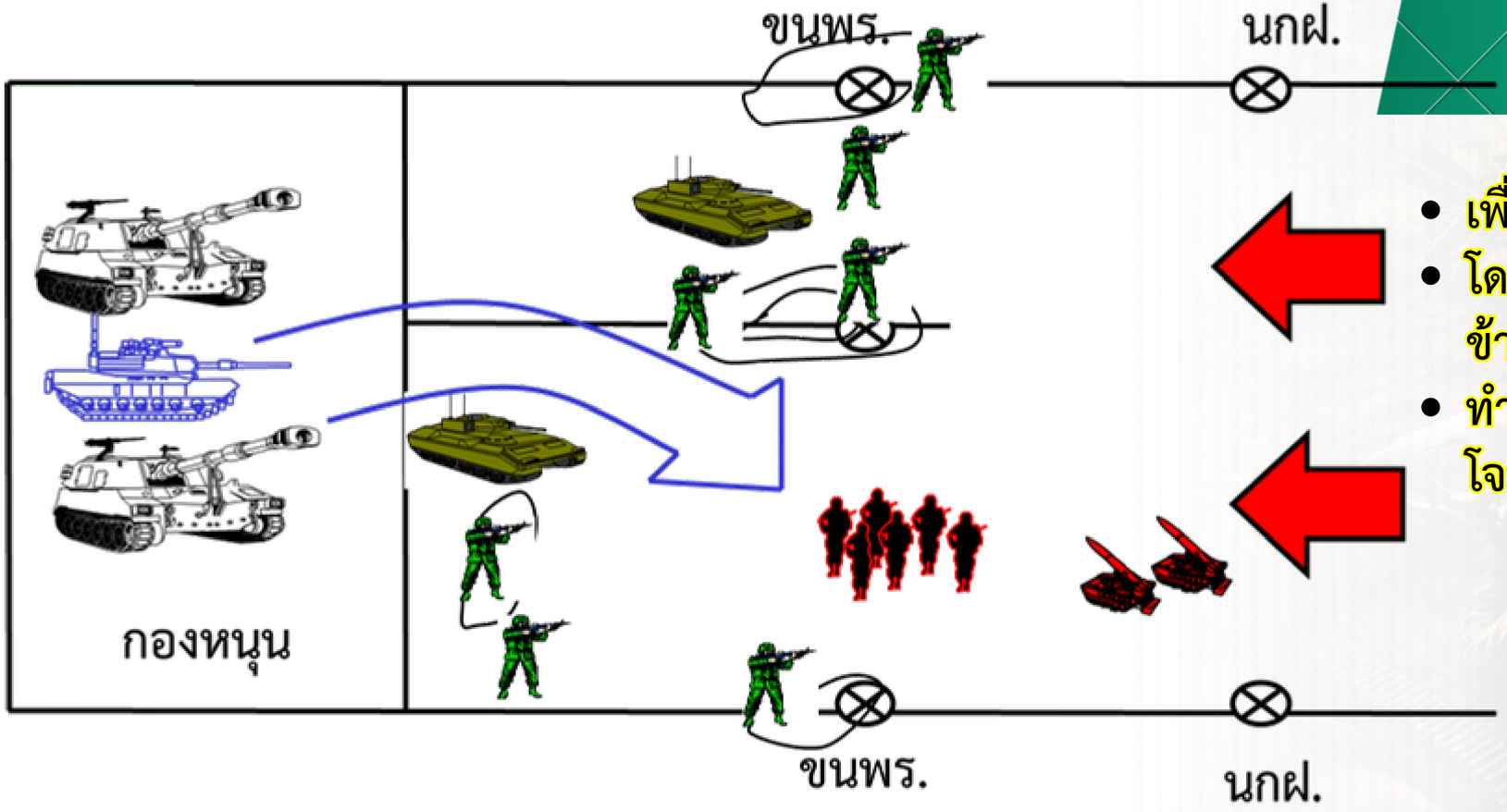


- มุ่งยึดรักษาภูมิประเทศ ที่ได้เปรียบ
- โดยดึงข้าศึกให้เข้ามาถูกตรึง อยู่ในกลุ่มที่มั่นตั้งรับ
- ทำลายด้วยอำนาจการยิง

การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

การบริการทางการแพทย์ในการรบด้วยวิธีตั้งรับ

การตั้งรับแบบคล่องตัว



- เพื่อทำลายกำลังของฝ่ายเข้าตี
- โดยยอมให้ข้าศึกรุกเข้ามาในพื้นที่ฝ่ายเรา ซึ่งทำให้ข้าศึกเสียเปรียบ
- ทำการตีโต้ตอบหรือตีโอบโดยกองหนุนหรือกำลังโจมตีที่มีความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่

การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

การบริการทางการแพทย์ในการรบด้วยวิธีตั้งรับ

ข้อแตกต่างของการตั้งรับ

การพิจารณาเลือกแบบการตั้งรับใช้ปัจจัย METT-T

ข้อพิจารณา	การตั้งรับแบบยึดพื้นที่	การตั้งรับแบบคล่องตัว
- เป้าหมายหลัก	- ยึดรักษาภูมิประเทศ	- ทำลายกำลังข้าศึก
- อำนาจกำลังรบ	- กำลังใน พตน. มาก	- กำลังใน พตน. น้อย

การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

การบริการทางการแพทย์ในการรบด้วยวิธีตั้งรับ

ข้อแตกต่างของการตั้งรับ

การพิจารณาเลือกแบบการตั้งรับใช้ปัจจัย METT-T

ข้อพิจารณา	การตั้งรับแบบยึดพื้นที่	การตั้งรับแบบคล่องตัว
ภารกิจกองหนุน	กำลังน้อย ใช้สกัดกั้น ผลักดัน	กำลังมาก ใช้ตีโต้ตอบทำลาย
ภารกิจกำลังใน พตน.	หยุดยั้ง ทำลาย	บังคับข้าศึกให้ไปใน ทิศทางที่วางแผนไว้
การปฏิบัติการแตกหัก	ณ พตน.	ณ พื้นที่กองหนุน

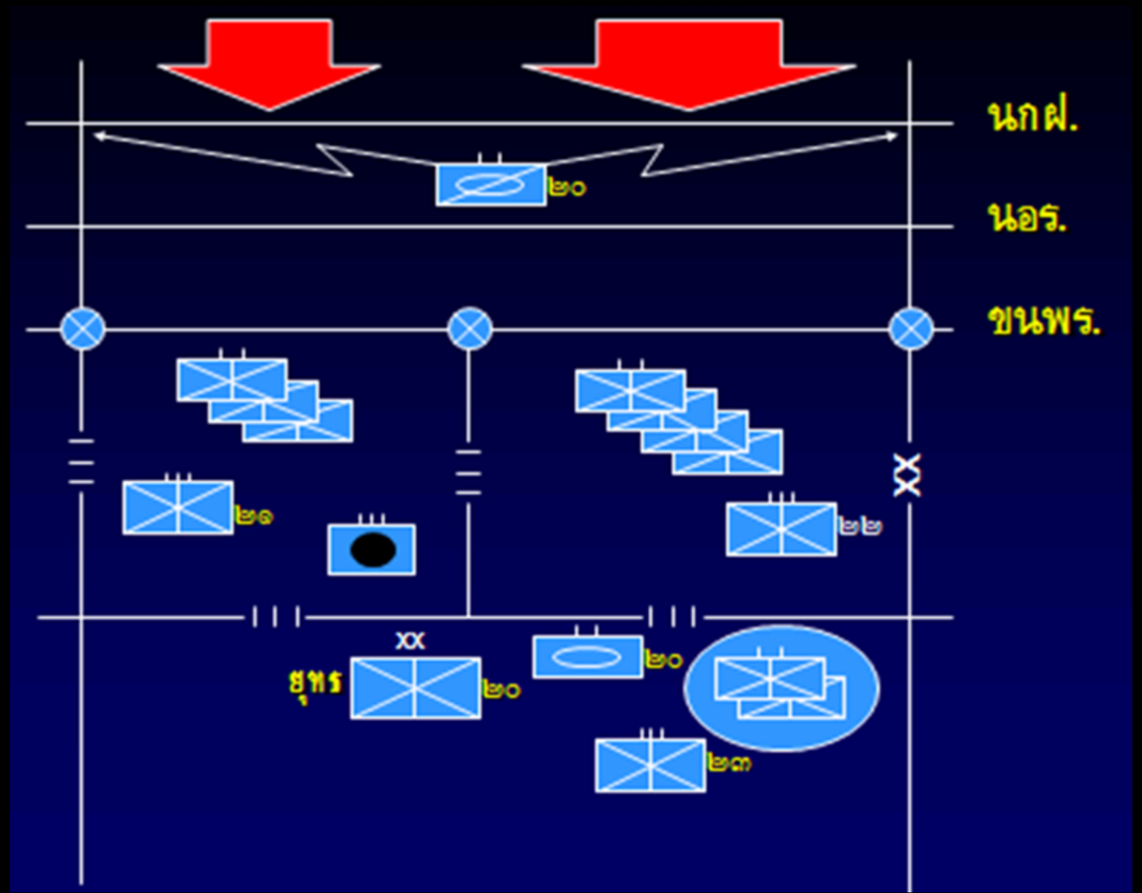
การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

การบริการทางการแพทย์ในการรบด้วยวิธีตั้งรับ

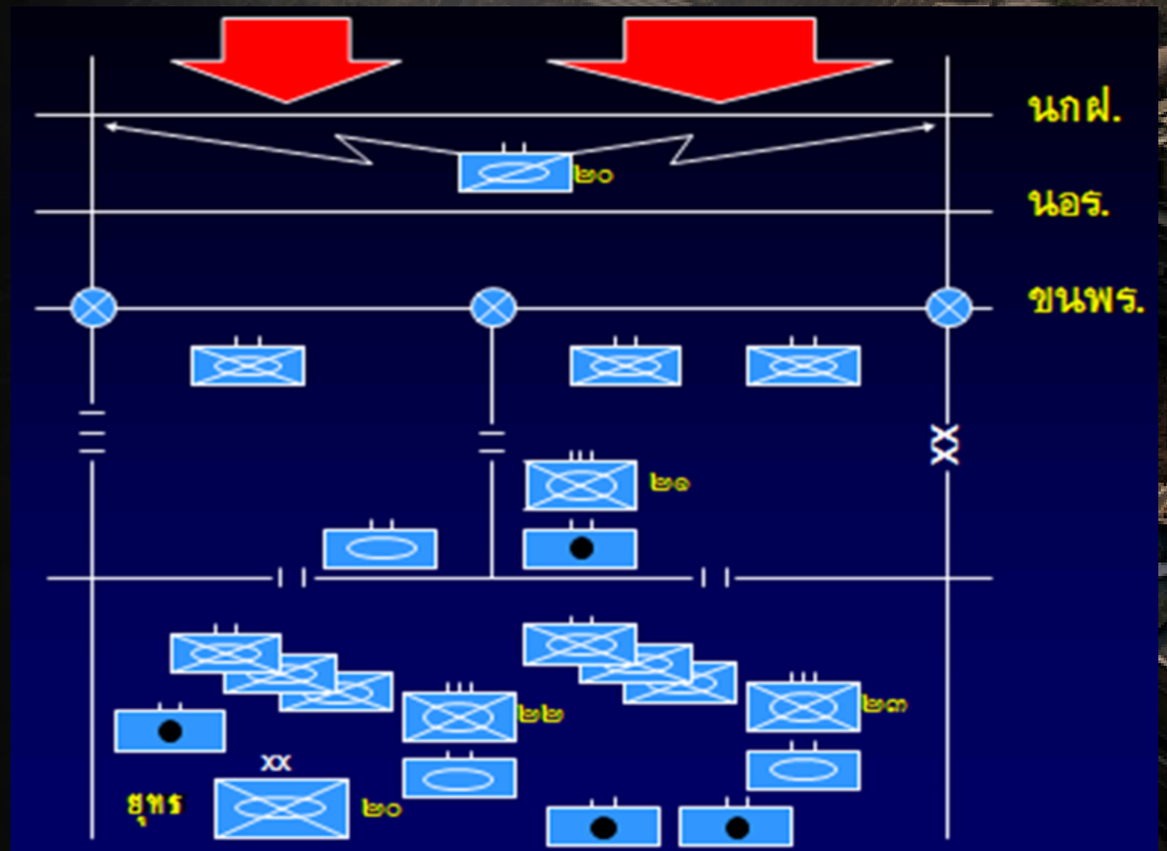
ข้อแตกต่างของการตั้งรับ

การพิจารณาเลือกแบบการตั้งรับใช้ปัจจัย METT-T

การตั้งรับแบบยึดพื้นที่

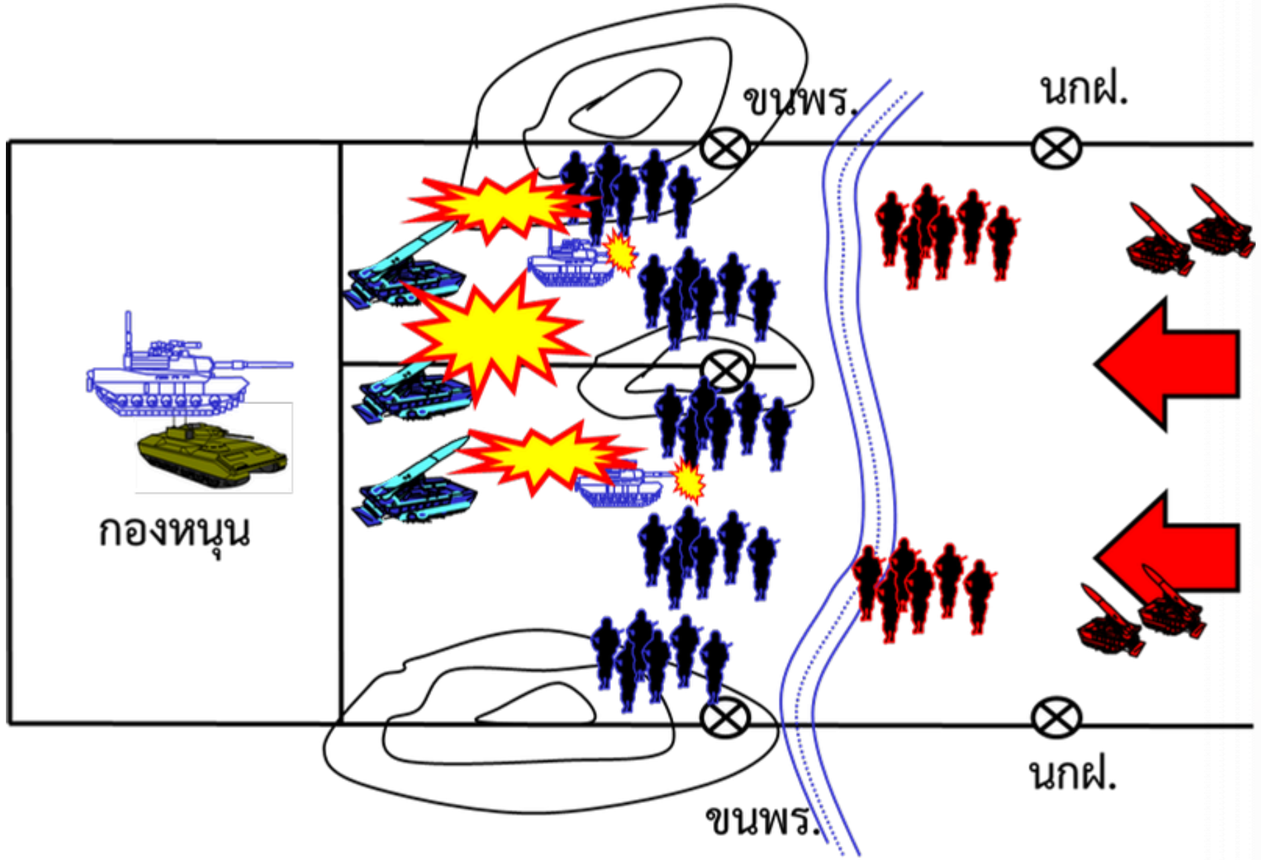


การตั้งรับแบบคล่องตัว



การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

การบริการทางการแพทย์ในการรบด้วยวิธีตั้งรับ



ลักษณะต่างๆ ของการตั้งรับ

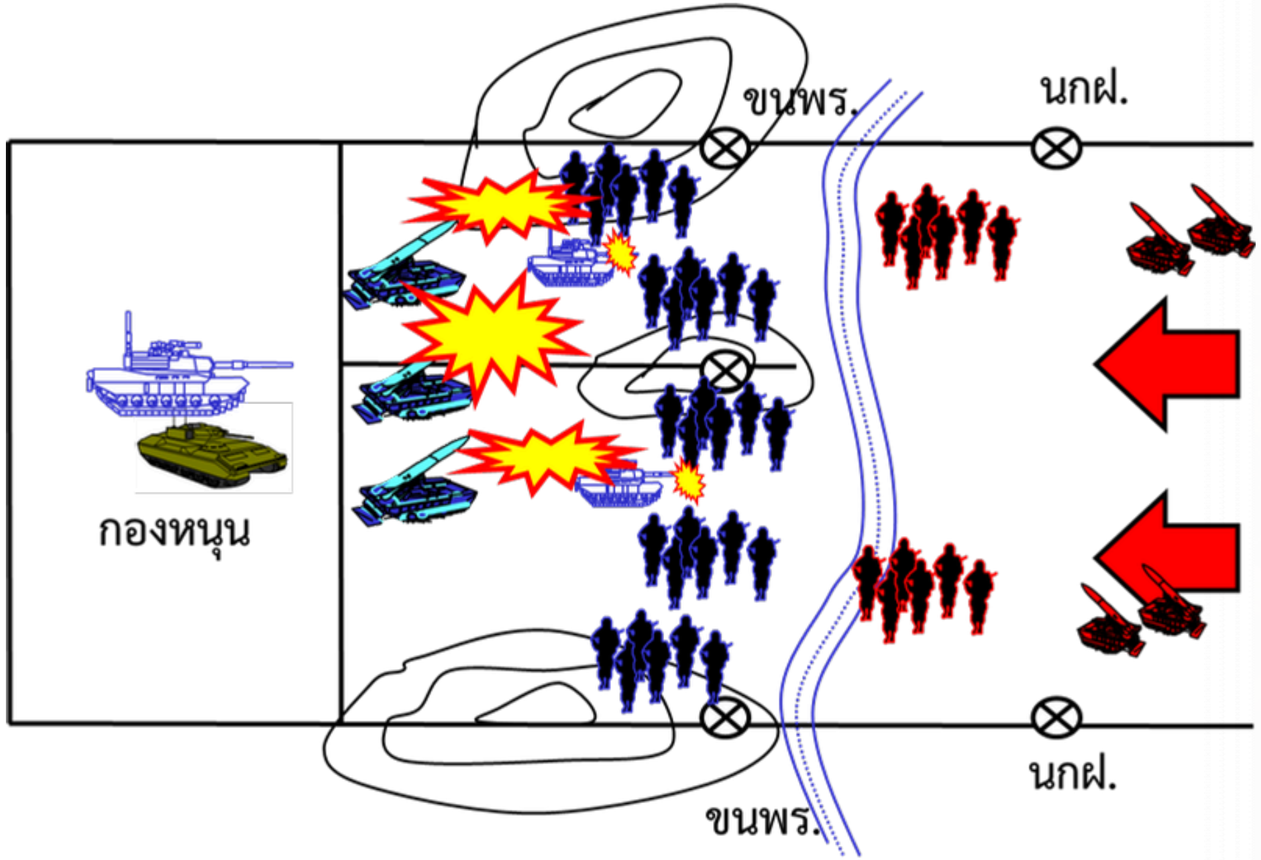
ที่มีอิทธิพลต่อการบริการทางการแพทย์

* การดัดแปลงที่มั่นต้อง สอดคล้อง กับหน่วยดำเนินกลยุทธ
* กว้างด้านหน้า ต้องนำมาพิจารณาในการจัดหน่วยแพทย์
* *การตรวจภูมิประเทศ* เป็นสิ่งจำเป็นในการวางแผน
* การจู่โจมในการปฏิบัติการ จะกระทบต่อการซ่อนพราง และการ คท.หน่วยแพทย์
* ต้องเตรียมหน่วยแพทย์ ให้พร้อมสำหรับการใช้กองหนุน
* ที่ตั้งของหน่วยแพทย์ *จะอยู่ห่าง*จากแนวหน้าไป ข้างหลังมากกว่าการเข้าตี
* ต้องจัดให้มีการบริการทางการแพทย์สนับสนุน *ส่วนกำบังและฉากกำบัง*

การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

การบริการทางการแพทย์ในการรบด้วยวิธีตั้งรับ

หลักนิยมของการบริการทางการแพทย์ในการตั้งรับ

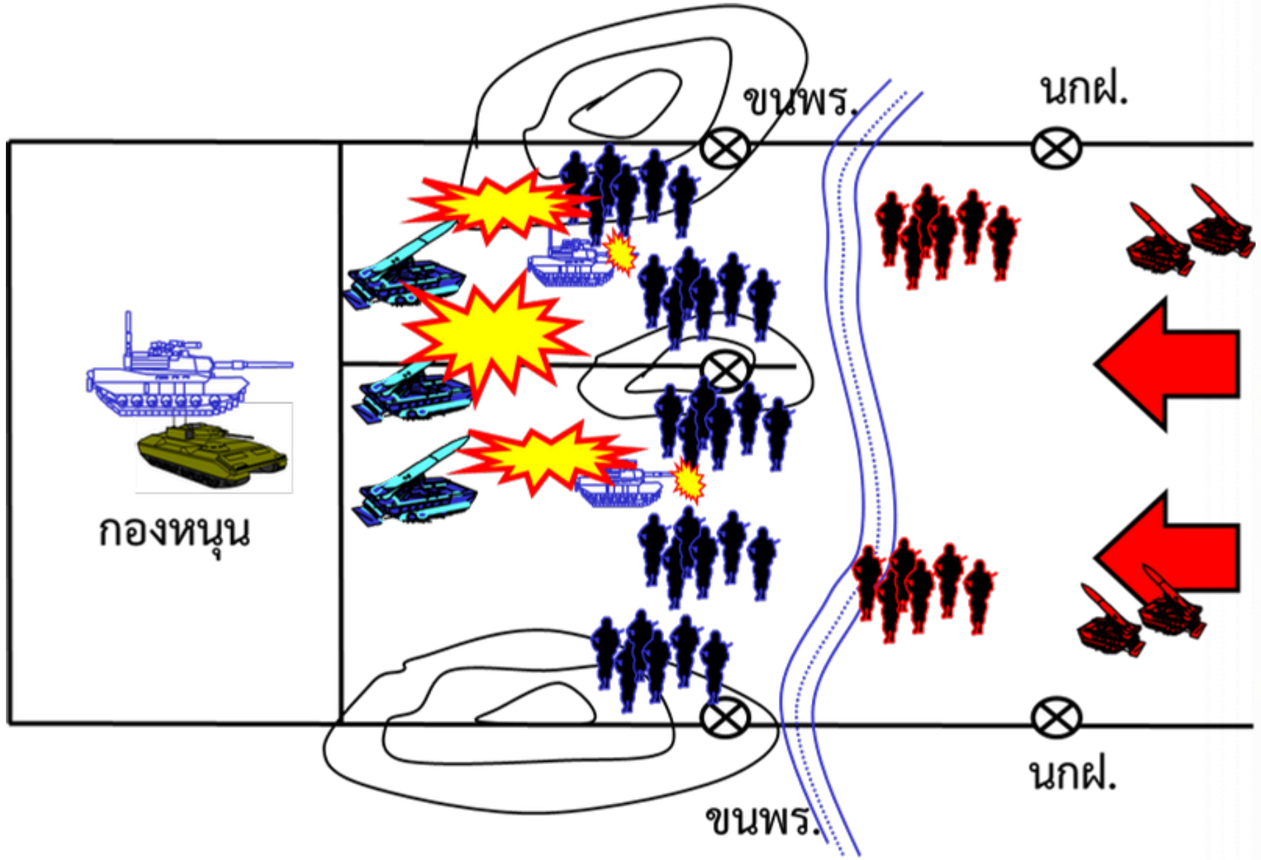


* ต้องจัดให้มีการบริการทางการแพทย์สนับสนุนส่วนกำบัง
* หน่วยเก็บรวบรวม ผป. ต้องกระจายไปทางข้างด้วย
* หน่วยแพทย์ ต้องดำรงความคล่องแคล่วในการ คท.
* หน่วยแพทย์ อยู่ห่างจากแนวหน้ามากกว่าการเข้าตี

การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

การบริการทางการแพทย์ในการรบด้วยอาวุธ ตั้งรับ

หลักนิยมของการบริการทางการแพทย์ในการตั้งรับ



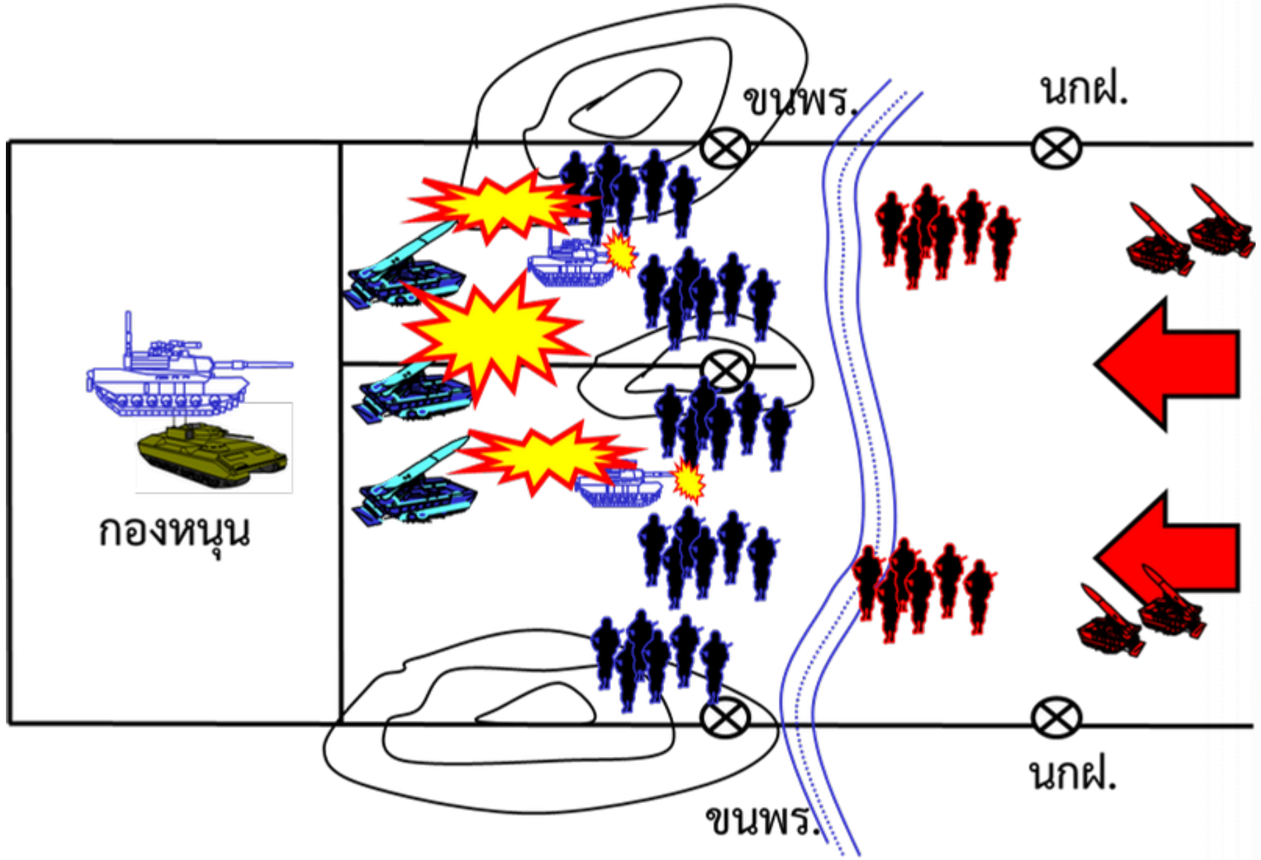
การสมทบนายสิบพยาบาลกองร้อย

* บาง มว.ปล. อาจใช้ ส.พยาบาลกองร้อย มากกว่า 1 คน
* บางสถานการณ์ ร้อย.ค.หนัก อาจต้องใช้ ส.พยาบาลกองร้อย ของ มว.ปล. ที่อยู่ใกล้เคียง
* ผบ.มว.สร. ต้องศึกษาภูมิประเทศให้ดี เพื่อพิจารณาจัด ส.พยาบาลกองร้อย สนับสนุนหน่วยต่าง ๆ

การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

การบริการทางการแพทย์ในการรบด้วยวิธีตั้งรับ

หลักนิยมของการบริการทางการแพทย์ในการตั้งรับ



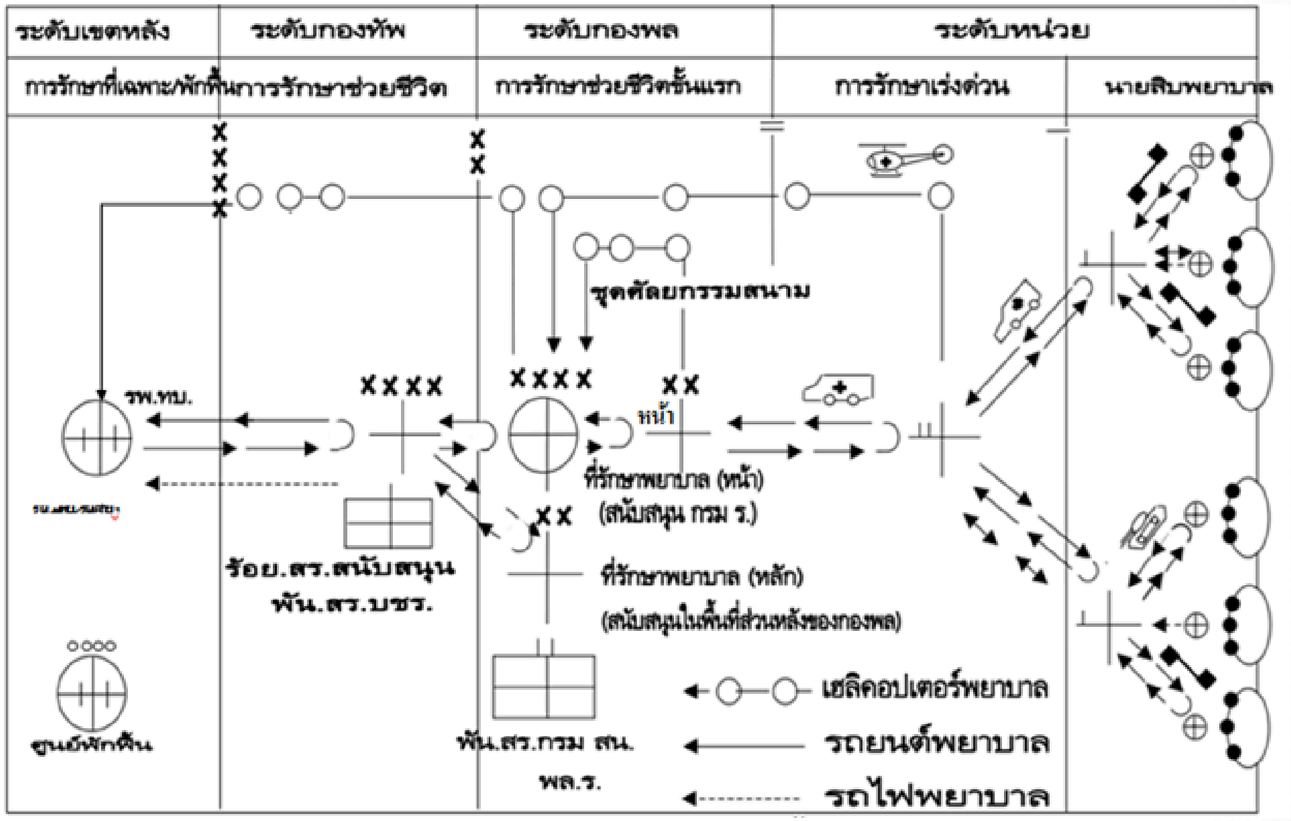
การสมทบพวกเปล

* บางสถานการณ์ อาจจัด พวกเปล สมทบกับ ร้อย.อวบ.(ต้องออกคำสั่งสมทบ และเลิกสมทบด้วยทุกครั้ง)
* พิจารณาถึงบริเวณที่มี ผป.หนาแน่น / ระยะทาง / ภูมิประเทศ และ กองหนุน ที่จำเป็นต้องใช้พลเปล
* ลว. เส้นทางส่งกลับ ทำการดัดแปลงภูมิประเทศ เพื่อป้องกันตนเองและเส้นทางลำเลียงเปล

การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

การบริการทางการแพทย์ในการรบด้วยอาวุธตั้งรับ

หลักนิยมของการบริการทางการแพทย์ในการตั้งรับ



รถพยาบาล

*ลำเลียง ผป.จากที่พยาบาลกองร้อย มายังที่พยาบาลกองพัน

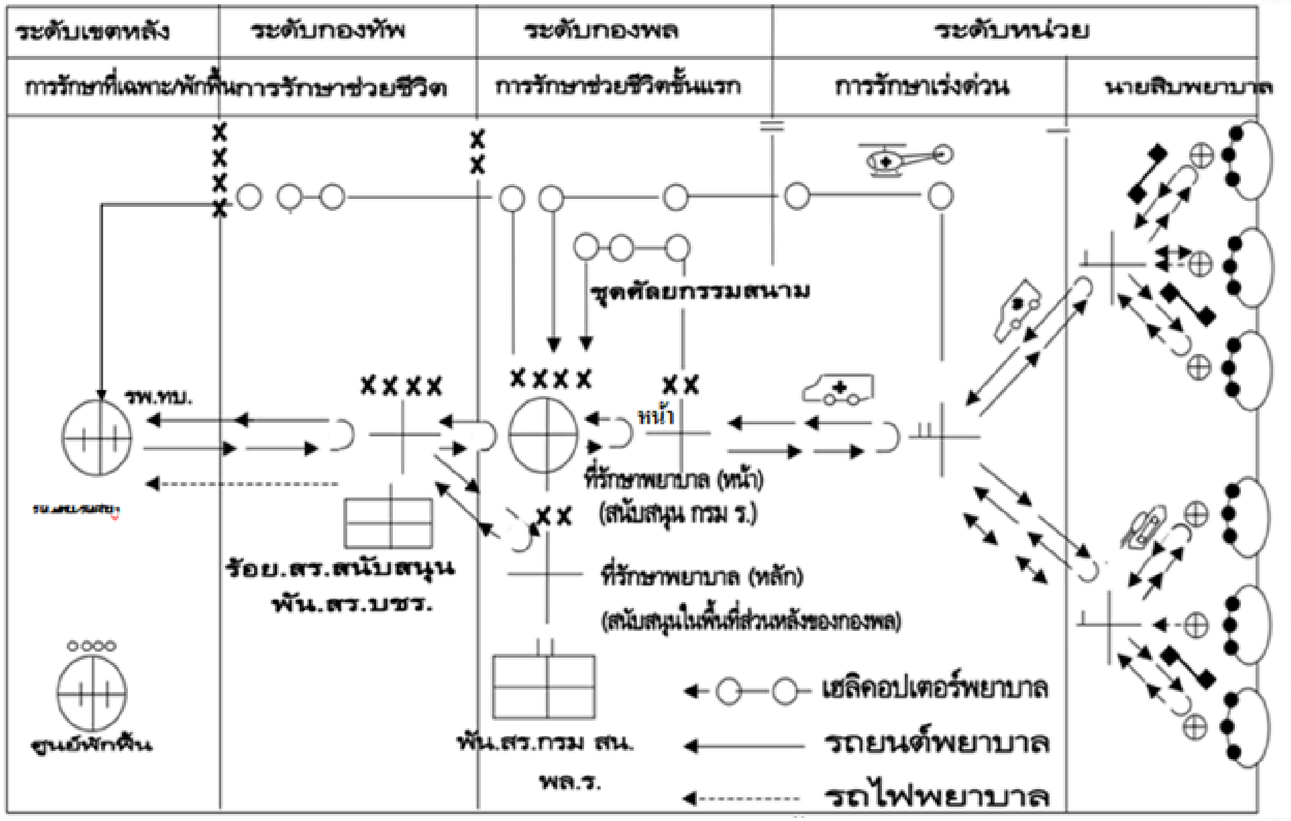
มว.สร.

* มว.สร. ของกองหนุน ยังไม่จัดตั้ง ที่พยาบาลกองพัน

การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

การบริการทางการแพทย์ในการรบด้วยอาวุธตั้งรับ

หลักนิยมของการบริการทางการแพทย์ในการตั้งรับ



พัน.สร.

* จัดตั้งที่พยาบาลกองพลสนับสนุนการบริการแพทย์ตามอัตรา
* เลือกเส้นทาง ที่สะดวกในการส่งกลับ โดยรถพยาบาลในเวลากลางคืน
* ตำบลต่าง ๆ ในการส่งกลับโดยรถพยาบาล ต้องคำนึงถึงการกำบังและการซ่อนพราง
* การส่งกลับ ผป. ถ้าไม่มี การวาง กำลังคุ้มกัน ควรทำการส่งกลับในเวลากลางคืน
* หน่วยแพทย์ ที่สนับสนุนกำลังตีโต้ตอบ ต้องดำรงความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ เพื่อพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติ

การบริการทางการแพทย์ในการรบด้วยวิธี ร่นถอย

หน่วง-ถอน-ถอย

การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

การบริการทางการแพทย์ในการรบด้วยวิธีร่นถอย

หน่วง-ถอน-ถอย

การรบด้วยวิธีร่นถอย

- เป็นการปฏิบัติที่ใช้การเคลื่อนย้ายไปข้างหลัง/ออกห่างข้าศึกอย่างมีระเบียบ
- ถูกบีบบังคับ/โดยสมัครใจ
- ต้องได้รับอนุมัติจาก ผบ.หน่วยเหนือ

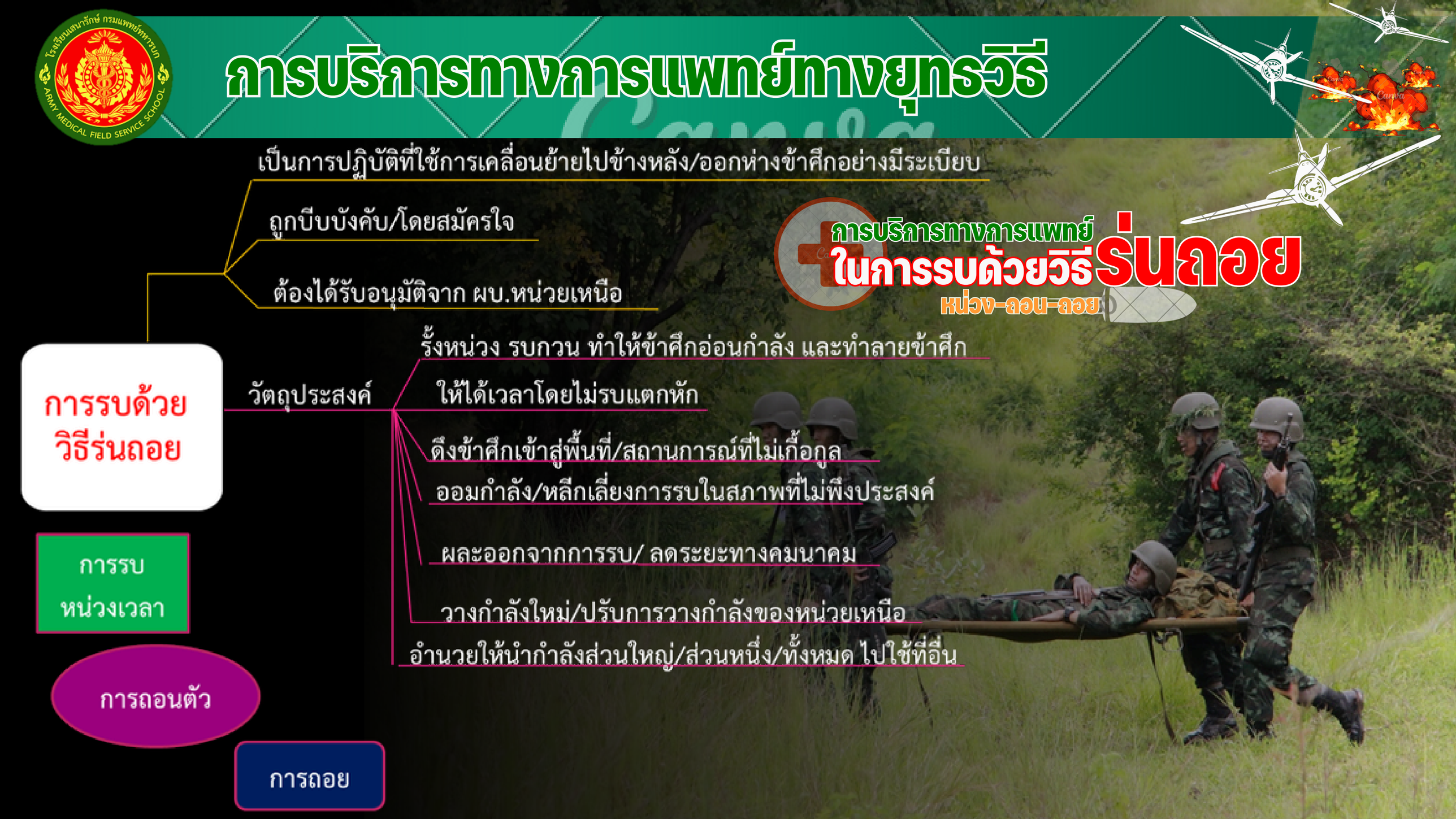
วัตถุประสงค์

- รั้งหน่วง รบกวน ทำให้ข้าศึกอ่อนกำลัง และทำลายข้าศึก
- ให้ได้เวลาโดยไม่รบแตกหัก
- ดึงข้าศึกเข้าสู่พื้นที่/สถานการณ์ที่ไม่เกื้อกูล
- ออมกำลัง/หลีกเลี่ยงการรบในสภาพที่ไม่พึงประสงค์
- ผละออกจากการรบ/ ลดระยะทางคมนาคม
- วางกำลังใหม่/ปรับการวางกำลังของหน่วยเหนือ
- อำนวยให้นำกำลังส่วนใหญ่/ส่วนหนึ่ง/ทั้งหมด ไปใช้ที่อื่น

การรบหน่วงเวลา

การถอนตัว

การถอย



การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

การบริการทางการแพทย์ในการรบด้วยวิธีร่นถอย

หน่วง-ถอน-ถอย

มี ขศ.เกาะฝ่ายเรา
หลอกล่อ/สร้างความเสียหาย
เพื่อต้องการเวลา

มี ขศ.เกาะฝ่ายเรา
ต้องการผละออกมา
เร็วได้เท่าไหร่ยิ่งดี

ถอยเมื่อ ผบ.สั่ง
อย่างมีกลศึก

รบหน่วงเวลา

- ตามลำดับขั้น
- สลับขั้น
- ผสม

ถอนตัว

- ถูก ขศ.กดดัน (ภายใต้ความกดดัน)
- ไม่ถูก ขศ.กดดัน (นอกความกดดัน)

ร่นถอย

METT-T

ถอย

ไม่มี ขศ.เกาะ
ถอยห่างออกมา

ข้อพิจารณาทั่วไป
ของการบริการทางการแพทย์ในการร่นถอย

ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว ขึ้นอยู่กับ
* ประเภทของการรบ
* ขีดความสามารถของข้าศึก
* สถานการณ์ที่เผชิญอยู่

การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

การบริการทางการแพทย์ในการรบด้วยวิธีร่นถอย
หน่วง-ถอน-ถอย

ปัจจัยที่ควรนำมาพิจารณาในการวางแผน

ปัจจัยเวลา

- ถ้าเวลาน้อยจะทำให้มี ผป. ตกค้างมาก
- ผบ.หน่วยแพทย์ ต้องประมาณการทางการแพทย์ในเรื่องความสามารถในการเก็บรวบรวมและส่งกลับ ผป. เพื่อเสนอแนะ ผบช. ในการเพิ่มเติมกำลัง และเครื่องมือในการส่งกลับ หรือ การสละ ผป.

อัตรา ผป.

* จะสูงถ้าเคลื่อนย้ายภายใต้ความกดดันของ ขศ. ต้องจัดส่วนเหลือไว้ปะทะ

การส่งกลับ

* ยากลำบากกว่าการรบแบบอื่น เส้นทางส่งกลับ คับคั่ง หรือถูกตัดขาด ดังนั้น รยพ. อาจต้องเคลื่อนย้ายในลำดับต้น ๆ ใช้ รยบ. ช่วยลำเลียง ผป.

การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

การบริการทางการแพทย์ในการรบด้วยวิธีร่นถอย
หน่วง-ถอน-ถอย

ปัจจัยที่ควรนำมาพิจารณาในการวางแผน

การเพิ่มเติมกำลัง

* ถ้าจำกัดด้วยเวลา ต้อง เพิ่มเติมกำลัง ให้หน่วยแพทย์ แต่ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยเฉพาะความคล่องแคล่วของหน่วย

การสละ ผป.

* เป็นความรับผิดชอบของ ผบ.หน่วย

ที่ตั้งหน่วยแพทย์

* ต้องมีการวางแผนล่วงหน้า ที่ตั้งตามลำดับขั้น ต้องพร้อมปฏิบัติงาน ก่อนสละที่ตั้งด้านหน้า

การจัดระเบียบที่ตั้ง

* จำนวนครั้งขึ้นอยู่กับอัตราการเคลื่อนย้ายของกำลังรบ ภูมิประเทศ ความปลอดภัย การย้าย จะกระทำเป็น ส่วน ๆ หรือแบบกบกระโดด

การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

การบริการทางการแพทย์ในการรบด้วยวิธีร่นถอย

หน่วง-ถอน-ถอย

หลักนิยมการบริการทางแพทย์ในการร่นถอย

- ที่ตั้งการบริการทางการแพทย์ระดับกองพล เคลื่อนที่ไปข้างหลังเรื่อยๆ
- การเคลื่อนย้ายกระทำแบบแยกการ กำหนดเพียงจุดเริ่ม จุดแยก ที่รวมพล
- อาจจัดกำลังพล ที่พยาบาลกองพลไปเพิ่มเติมกำลังให้กับระดับหน่วย
- ก่อนเคลื่อนย้าย หน่วยเหนือต้องส่งกลับจากที่พยาบาลกองพลให้ทันเวลา
- การคัดแยก ผป. เพื่อส่งกลับเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับประเภทการขนส่ง
- ต้องให้ลำดับความเร่งด่วนในการส่งกลับแก่ ผป.นอนเปล
- ผป. ที่เดินได้ อาจให้เดินไปกับหน่วย หรือบรรทุกไปกับ รยบ.
- การสละผู้ป่วยเจ็บ เป็นหน้าที่ของ ผบ.หน่วย ดย. ผบ.หน่วยแพทย์มีหน้าที่เสนอแนะเท่านั้น
- เมื่อ ผบ.หน่วย ตกลงใจสละ ผป. จะต้องจัดเจ้าหน้าที่แพทย์/ยา/เวชภัณฑ์ ไว้ดูแล ผป.ด้วย

การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

การบริการทางการแพทย์ในการรบด้วยวิธีร่นถอย
หน่วง-ถอน-ถอย

การรบหน่วงเวลา(Delays)

รั้งหน่วงข้าศึกภายใต้ความกดดัน ยอมเสียพื้นที่เพื่อให้ได้เวลาที่ต้องการ ทำความเสียหายให้ข้าศึกให้มากที่สุดโดยไม่รบแตกหัก 2 ประเภท

1.รบหน่วงเวลาในที่มั่นตามลำดับขั้น 2.รบหน่วงเวลาในที่มั่นสลับขั้น

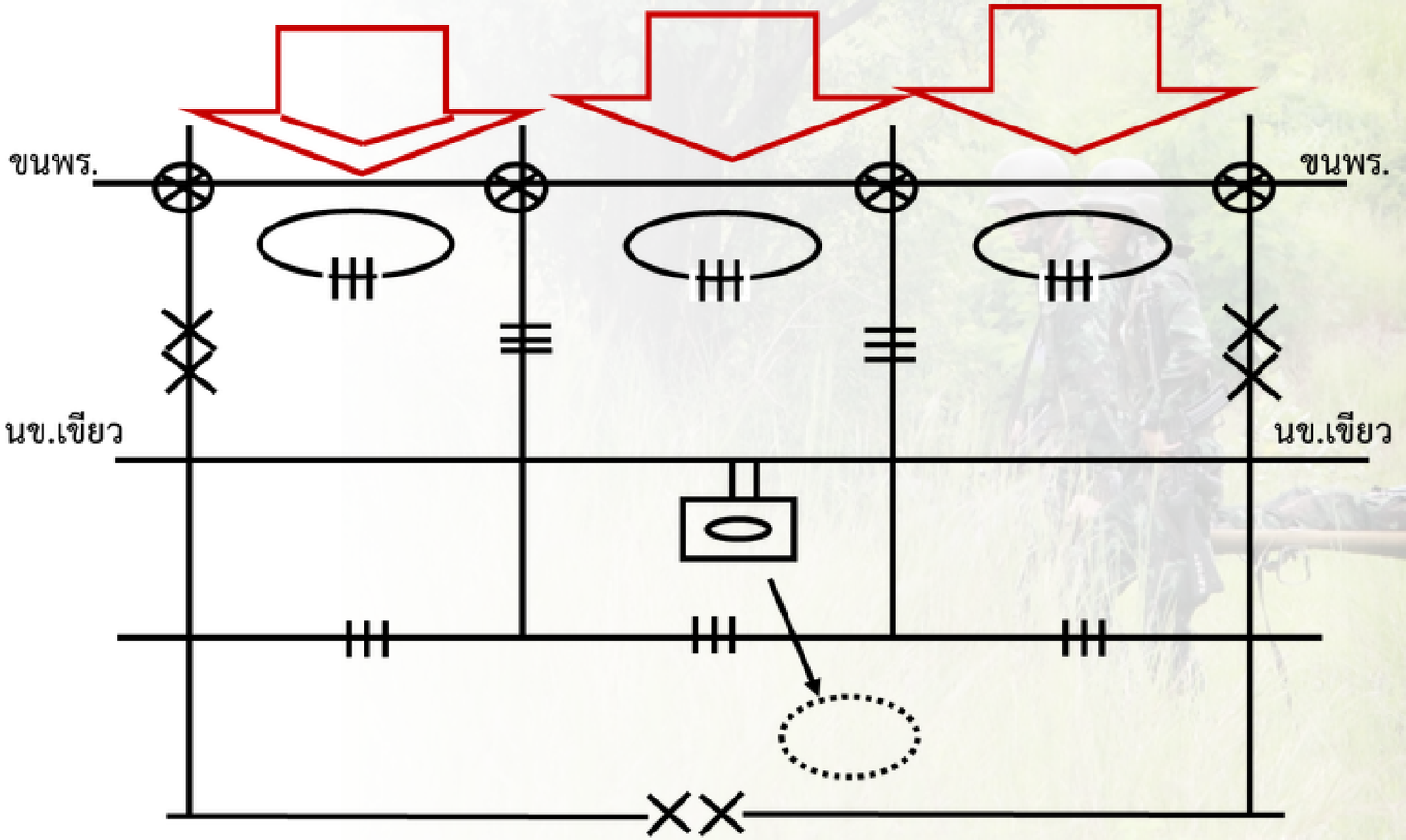
ปัจจัย	ตามลำดับขั้น	สลับขั้น
ความกว้างเขตปฏิบัติการ	กว้างมาก(>, = 2 พื้นที่ตั้งรับ)	แคบ(ใกล้เคียงกับพื้นที่ตั้งรับ
กำลังที่มีอยู่	มีกำลังพลน้อย	มีกำลังพลมาก
ความคล่องแคล่า	เท่ากับหรือมากกว่าข้าศึก	ไม่จำกัด
ภัยคุกคาม	ในพื้นที่อันตรายน้อย	ในพื้นที่อันตรายมาก
จำนวนที่มั่นในทางลึก	มีจำนวนจำกัด	มีหลายที่มั่น
ระยะห่างระหว่างที่มั่น	มาก	น้อย
เวลาในการเตรียมการ	มาก(48 ชม.ขึ้นไป)	น้อย(ไม่เกิน 48 ชม.)
ห้วงเวลาในการรบหน่วง	น้อย	มาก

การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

การบริการทางการแพทย์ในการรบด้วยวิธี ร่นถอย
หน่วง-ถอน-ถอย

การรบหน่วงเวลา(Delays)

ยอมเสียพื้นที่ เพื่อให้ได้เวลา ทำลาย ขศ. ให้มากที่สุด



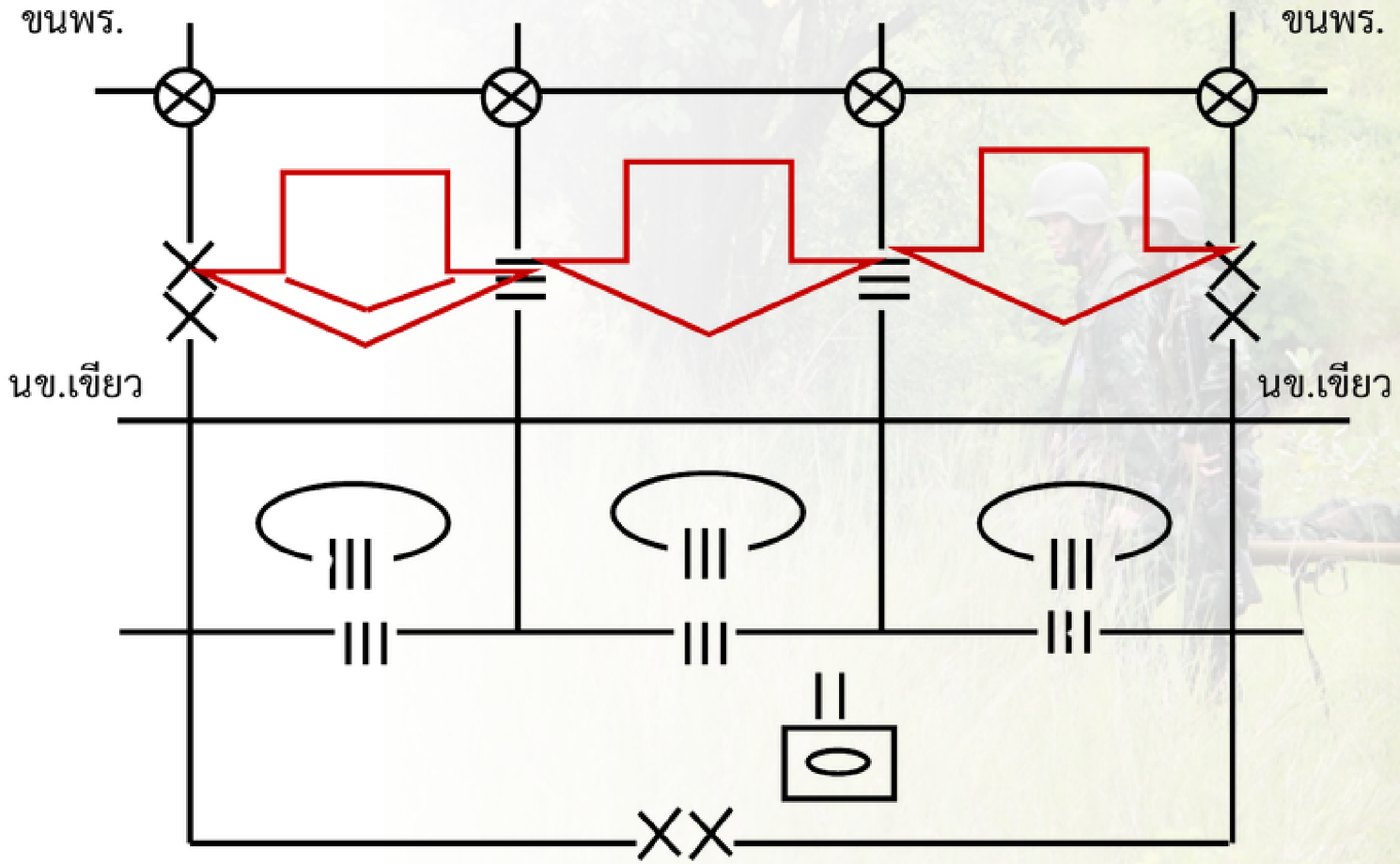
การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

การบริการทางการแพทย์ในการรบด้วยวิธี ร่นถอย

หน่วง-ถอน-ถอย

การรบหน่วงเวลา(Delays)

ยอมเสียพื้นที่ เพื่อให้ได้เวลา ทำลาย ขศ. ให้มากที่สุด



การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

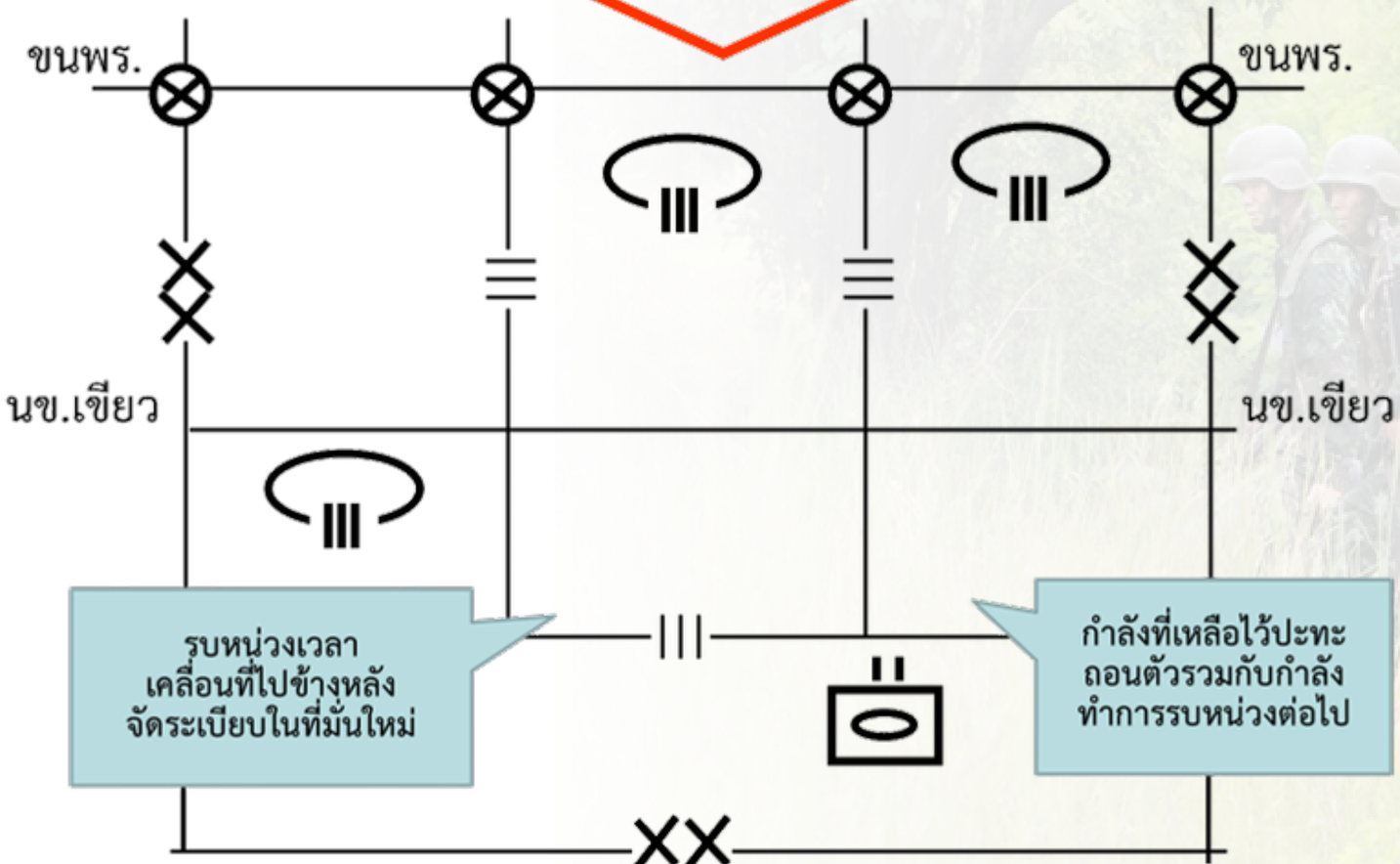
การบริการทางการแพทย์ในการรบด้วยวิธีร่นถอย

หน่วง-ถอน-ถอย

การรบหน่วงเวลา(Delays)

การรบหน่วงเวลาตามลำดับขั้น

ยอมเสียพื้นที่ เพื่อให้ได้เวลา ทำลาย ขศ. ให้มากที่สุด



การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

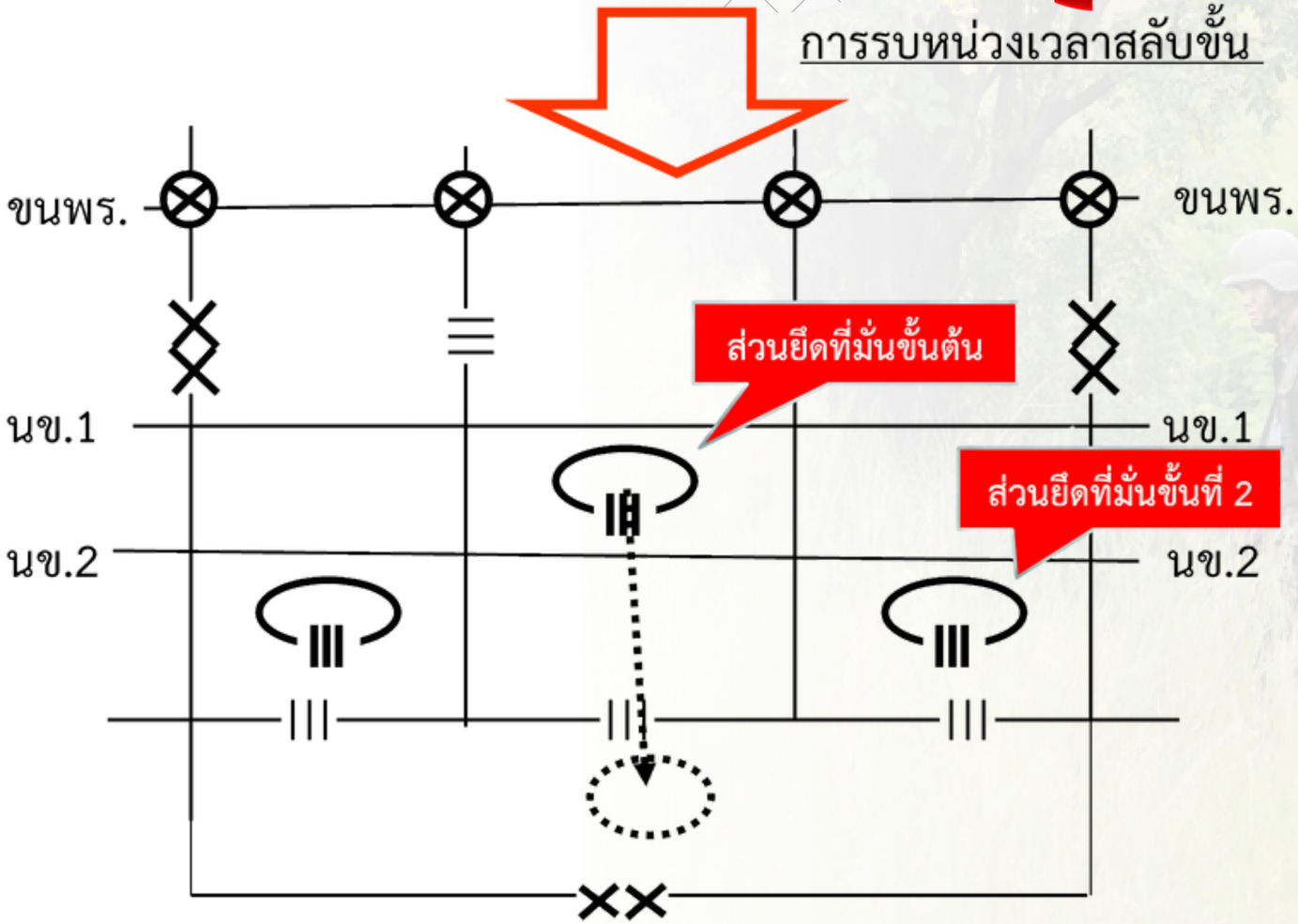
การบริการทางการแพทย์ในการรบด้วยวิธีร่นถอย

หน่วง-ถอน-ถอย

การรบหน่วงเวลา(Delays)

การรบหน่วงเวลาสลับขั้น

ยอมเสียพื้นที่ เพื่อให้ได้เวลา ทำลาย ขศ. ให้มากที่สุด



การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

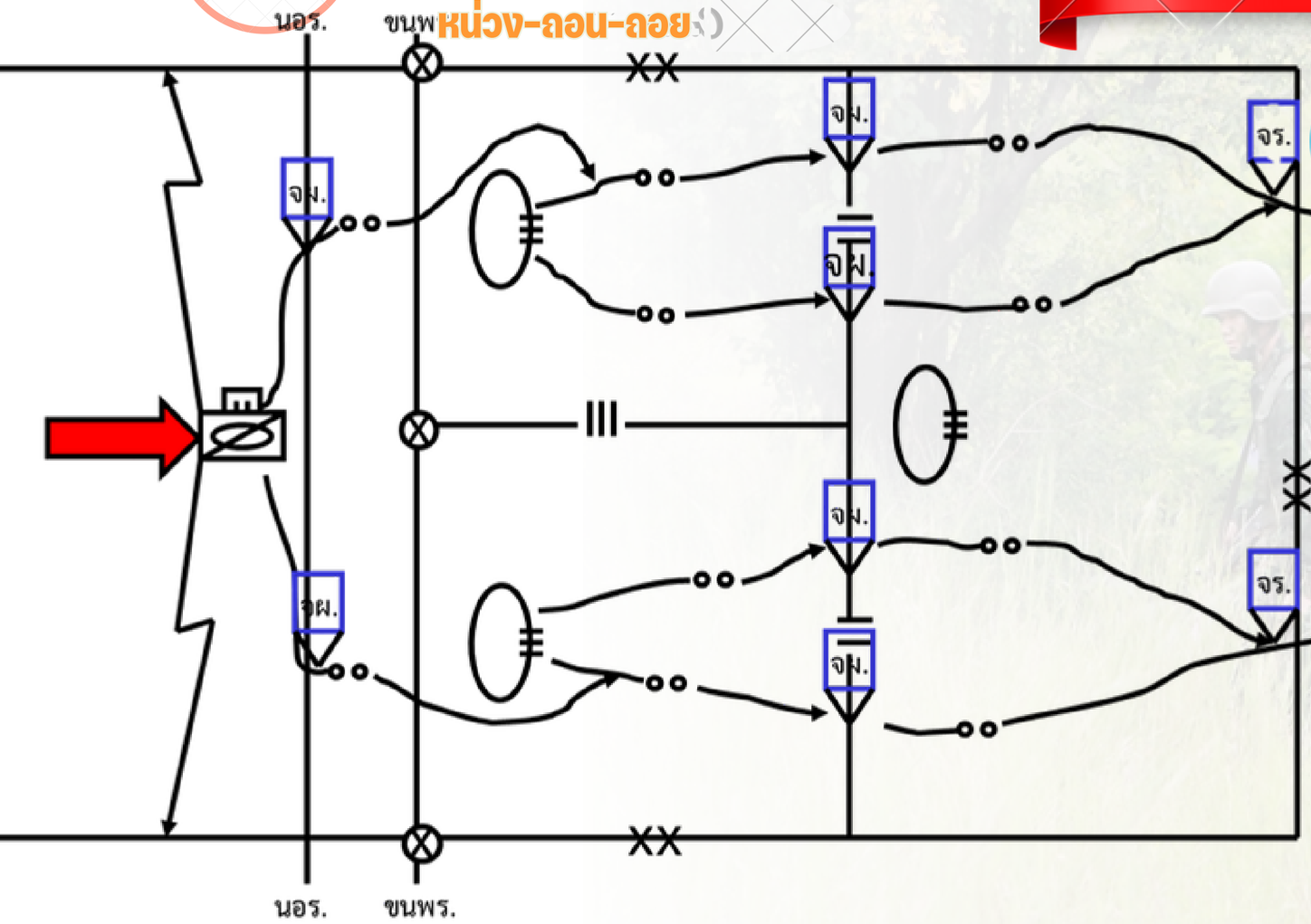
การบริการทางการแพทย์ในการรบด้วยวิธีร่นถอย
หน่วง-ถอน-ถอย

หลักนิยมการบริการทางแพทย์ในการรบหน่วงเวลา

- ขณะอยู่ในที่มั่นให้การบริการทางการแพทย์เป็นแบบตั้งรับ
- ถ้ากว้างด้านหน้ามาก อาจต้องแยกที่พยาบาลกองพัน
- พิจารณาจัดหน่วยสำหรับเก็บรวบรวมผู้ป่วยเจ็บ และพยายามใช้รถยนต์พยาบาลส่งกลับให้มากที่สุด
- สำหรับหน่วยที่อยู่โดดเดี่ยว อาจต้องจัดรถยนต์พยาบาล จากที่พยาบาลกองพลสมทบให้
- ที่พยาบาลกองพล ตั้งห่างไปข้างหลังมากๆ พร้อมให้การสนับสนุนที่มั่นได้ 2 ขั้น โดยไม่ต้องเคลื่อนย้าย

การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

การบริการทางการแพทย์ในการรบด้วยวิธี ร่นถอย



การถอนตัว(Withdrawal)

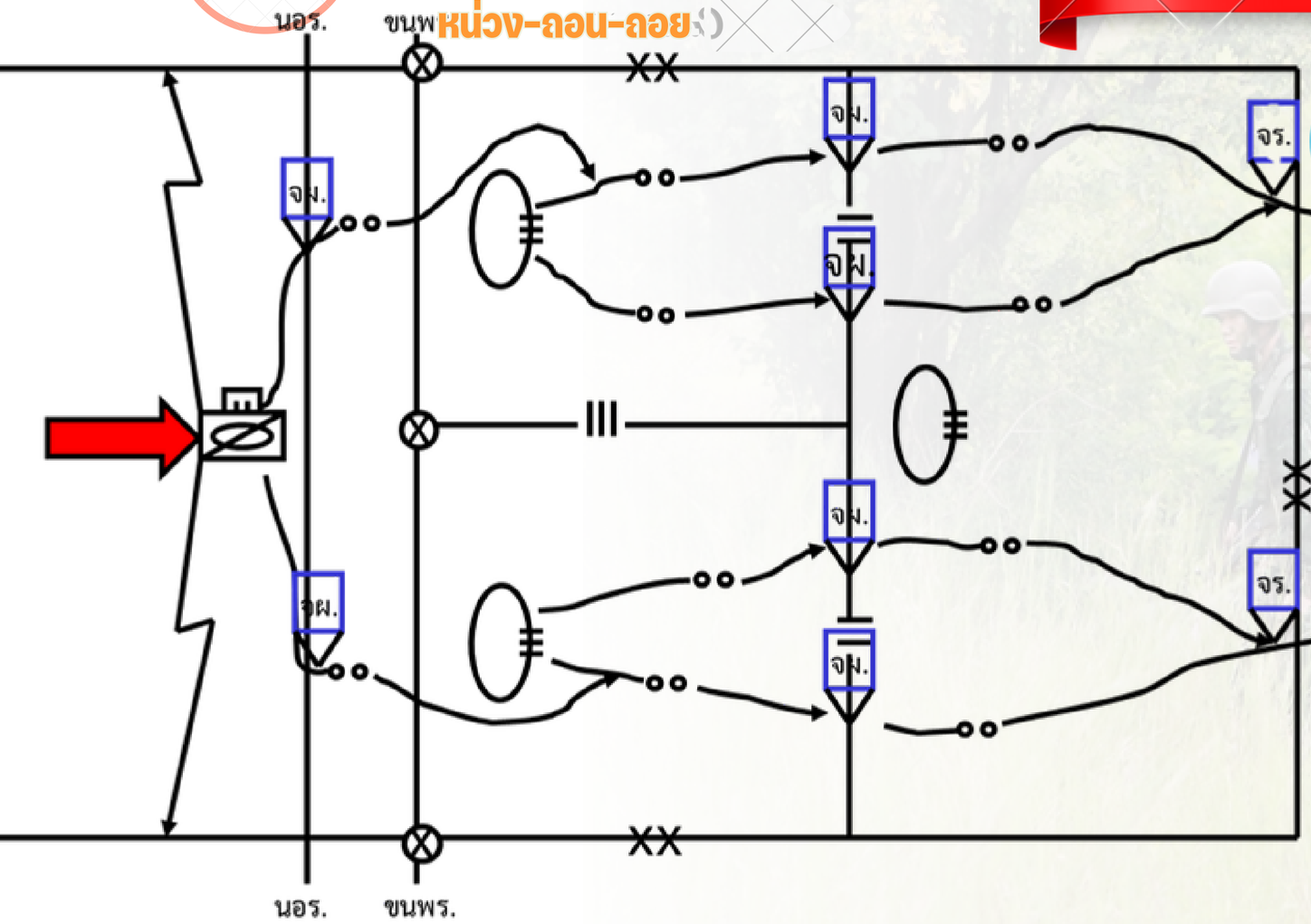
1. การถอนตัวนอกความกดดัน
2. การถอนตัวภายใต้ความกดดัน

1. การถอนตัวนอกความกดดัน นำกำลังทั้งหมดหรือบางส่วนผละออกจากการรบโดยไม่มีการกดดันจากข้าศึก เพื่อให้มีเสรีในการปฏิบัติใหม่

- การจัดกำลัง 2 ส่วน
  - ส่วนใหญ่ ส่วน ดย. 2 ใน 3 อาวุธ สน. 1 ใน 3 (ของทั้งหมด)
  - ส่วนเหลือไว้ปะทะ ส่วน ดย. 1 ใน 3 อาวุธ สน. 1 ใน 2 (ของทั้งหมด)

การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

การบริการทางการแพทย์ในการรบด้วยวิธี ร่นถอย



การถอนตัว(Withdrawal)

1. การถอนตัวนอกความกดดัน
2. การถอนตัวภายใต้ความกดดัน

2. การถอนตัวภายใต้ความกดดัน นำกำลังทั้งหมดหรือบางส่วนผละออกจากการรบโดยมีการกดดันจากข้าศึก เพื่อให้มีเสรีในการปฏิบัติใหม่

- การจัดกำลัง 2 ส่วน
  - ส่วนใหญ่ 2 หน่วยในพื้นที่การรบหลัก
  - ส่วนกำบัง 1 หน่วยในพื้นที่กองหนุน หน่วยเหนือจัดให้

การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

การบริการทางการแพทย์ในการรบด้วยวิธีร่นถอย

หน่วง-ถอน-ถอย

หลักนิยมการบริการทางแพทย์ในการถอนตัว

มว.สร.

- ใช้หลักการบริการทางการแพทย์ เช่นเดียวกับการเคลื่อนที่เข้าปะทะ
- ไม่สามารถจัดตั้ง ที่พยาบาลกองพันได้ ใช้การบริการทางการแพทย์แบบประตูท้ายรถ
- การค้นหา รวบรวมผู้ป่วยเจ็บทำควบคู่ไปกับการถอนตัว เพื่อให้การรักษาพยาบาล ลำเลียงเข้าหาเส้นหลักการถอนตัว
- การถอนตัวภายใต้ความกดดัน ต้องได้รับพลเปลเพิ่มเติม หรือ หน่วยรบช่วยในการลำเลียงผู้ป่วยเจ็บ

การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

การบริการทางการแพทย์ในการรบด้วยวิธีร่นถอย

หน่วง-ถอน-ถอย

พัน.สร.

หลักนิยมการบริการทางแพทย์ในการถอนตัว

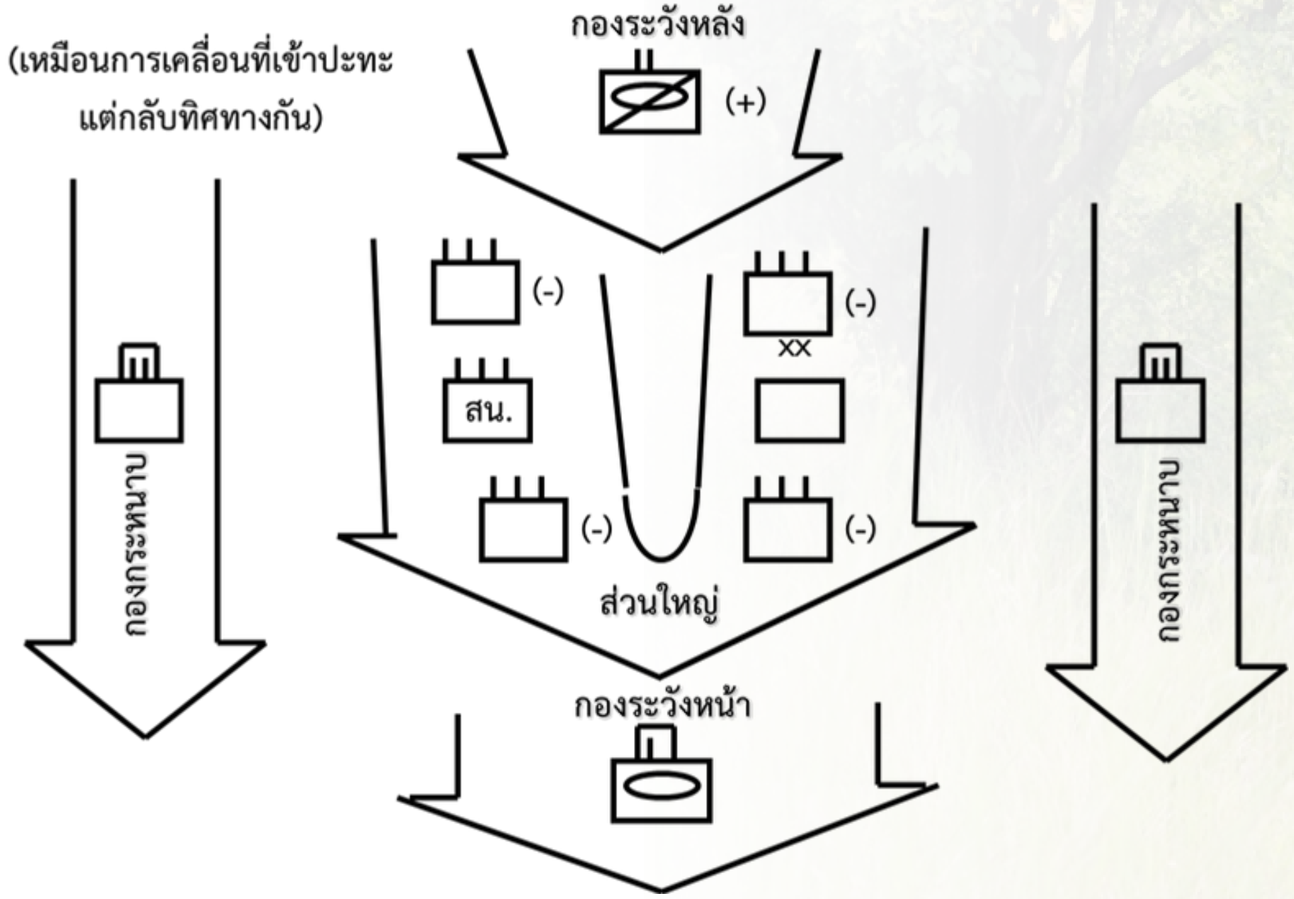
- อาจแบ่ง รยพ. ไปขึ้นสมทบให้กับส่วนกำบัง เพื่อทำการส่งกลับไปที่พยาบาลกองพลหน้าโดยตรง
- รยพ. บางส่วนอาจส่งกลับจากที่รวมพล พัน.ร. หรือ ต.นัดหมายอื่นๆ ไปยังพยาบาลกองพลหน้า
- ระยะแรกของการถอนตัวหน่วยแพทย์ของหน่วยเหนือต้องทำการส่งกลับ จากที่พยาบาลกอพลหน้าให้เร็วที่สุด

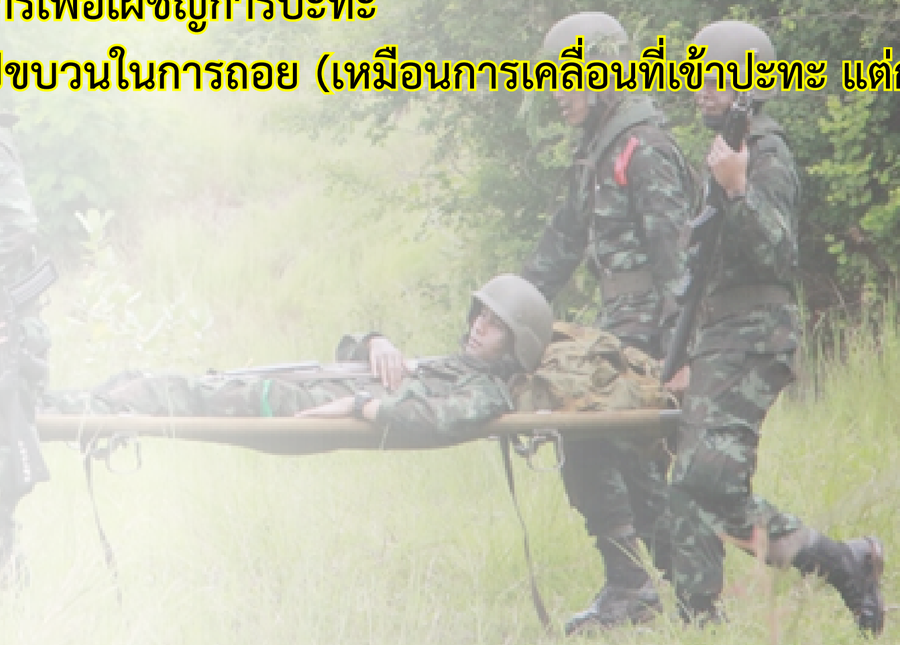
การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

การบริการทางการแพทย์ในการรบด้วยวิธี ร่นถอย หน่วง-ถอน-ถอย

การถอย (Retirement)

* การปฏิบัติต่อเนื่องมาจากการถอนตัว ออกจากพื้นที่การตั้งรับ โดยที่ไม่มีสถานการณ์ข้าศึก ถอนตัวอย่างมีระเบียบ ตามแผนที่วางไว้
* หน่วยที่อยู่ระหว่างการถอยยังล่อแหลมต่อการปฏิบัติของข้าศึก ต้องเตรียมการเพื่อเผชิญการปะทะ
* การจัดรูปขบวนในการถอย (เหมือนการเคลื่อนที่เข้าปะทะ แต่กลับทิศทางกัน)



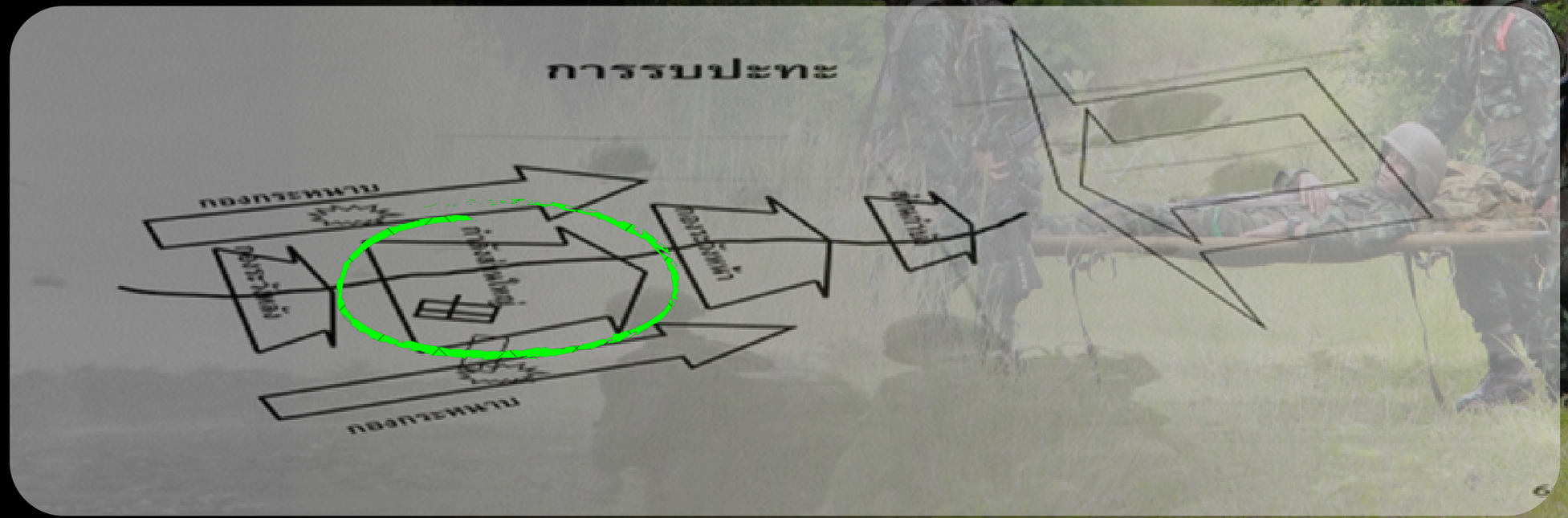


การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

การบริการทางการแพทย์ในการรบด้วยวิธีร่นถอย
หน่วง-ถอน-ถอย

หลักนิยมการบริการทางแพทย์ในการถอย

- ต้องพิจารณาเกี่ยวกับการบริการทางการแพทย์ให้กับกองระวังหลัง หากเกิดการปะทะกับ ขศ.
- โดยทั่วไปการบริการทางการแพทย์ เช่น เดียวกับ การเคลื่อนที่เข้าปะทะ
- หน่วยแพทย์ที่ไม่ได้จัดสนับสนุนกองระวังหลัง หรือใช้ในการเก็บรวบรวม ผป. เคลื่อนย้ายไปกับส่วนล่วงหน้าของแต่ละหน่วย



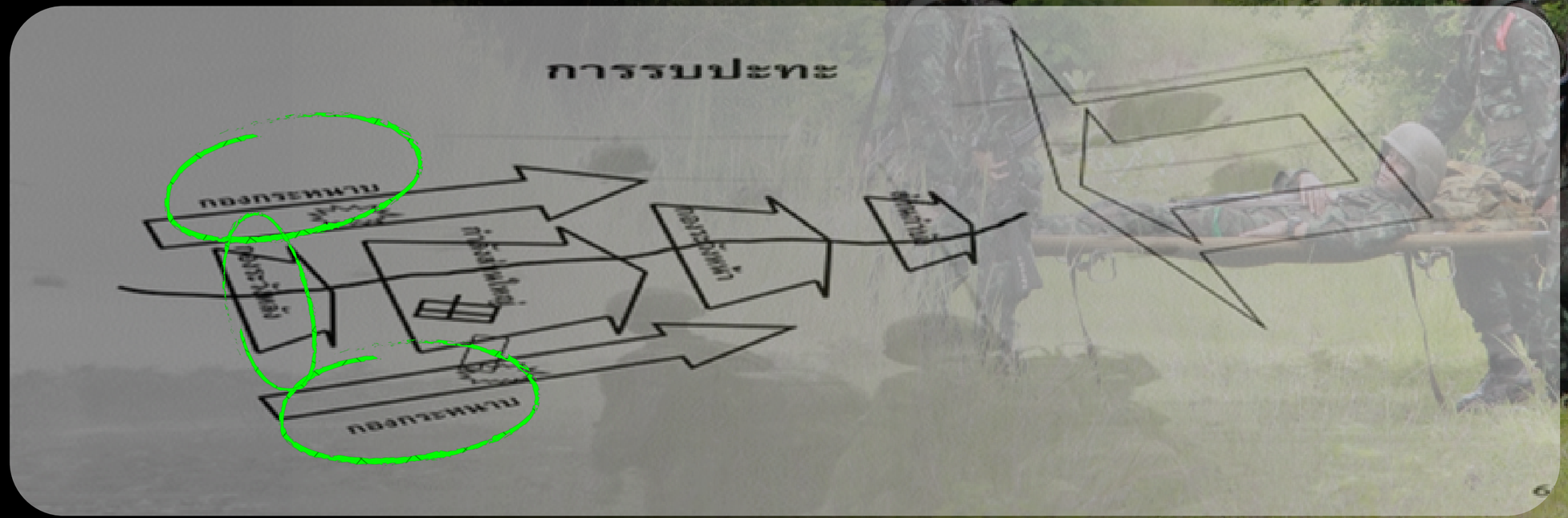
การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

การบริการทางการแพทย์ในการรบด้วยวิธีร่นถอย

หน่วง-ถอน-ถอย

หลักนิยมการบริการทางแพทย์ในการถอย

- หน่วยแพทย์ที่จัดสนับสนุนกองระวังหลังหรือใช้ในการเก็บรวบรวม ผป. ปฏิบัติงานในพื้นที่ระหว่างส่วนใหญ่ กับ กองระวังหลัง
- การสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ให้กับ ส่วนระวังป้องกันต่าง ๆ ต้องอ่อนตัว / สอดคล้องกับสถานการณ์



คนฉลาด...ชอบแกล้งโง่

คนโง่...ชอบเสแสร้งว่าฉลาด

ส่วน “นักปราชญ์”

เรียนรู้ที่จะ “ฉลาด” และ...

เรียนรู้ที่จะ “โง่”